

ECG

Dr.KHERBA_N

ECG

✓ Vailde: $1\text{mm}=0.04\text{s}/1\text{mm}=0.1\text{mv}$

- Vitesse: 25mm/s Voltage: 10mm/mv
- Pas d'inversion : P(+) en D1/P(-) en avR
- QRS (V1....V6)=> un seul sommet
- La ligne de base: isoélectrique (pas de tribulations =parasitage)

✓ Interprétation générale:

- Rythme: Régulier=> RR constant
- Sinusal: P(+) en DI et DII
- Chaque P doit être suivie par un QRS
et chaque QRS doit Précédé par P
- Fréquence: $300/\text{nb des grands carreaux RR}$
Si rythme irrégulier: calculer la moyenne de 3RR

✓ Interprétation spécifique:

- Onde P: présente/positive/petite(2.5mm)

Si: Absente:

1/Remplacée: Flutter A ou Fibrillation A

- Flutter Atrial: Rythme régulier
- Fibrillation Atriale: Rythme irrégulier

2/Non Remplacée: T jonctionnelle

(QRS fin <3mm)

ou Troubles de rythme ventriculaire TDR

(QRS large = ou >3mm)

- ESV: QRS prématuré

Maligne: Polymorphe/regroupé/à la 2ème partie de T.

- TV: amplitude constant et durée constante
- TP: amplitude varié et durée constante
- FV: amplitude varié et durée variée
- P ample=> HAD
- P bifide=> HAG

- PR: 3mm<...<5mm

- <3mm=> WFW (Triangle ou angle Delta)

- >5mm=> BAV 1er D

- BAV 2ème D: blocage de P (pas suivie de QRS)

1/Mobitz 1: allongement de PR + blocage

2/Mobitz 2: blocage seul

- BAV 3ème D: tt les P sont bloquées

Rythme Atrial et ventriculaire réguliers mais pas le rythme Atrial qui est responsable de ventriculaire.

- QRS: 3mm

=ou> 3mm avec un aspect en M (pas W) : Bloc de branche BB

- Si (V1V2): BBD

- Si (V5V6): BBG

Ou BBD=> M(V1) /W(V6)

BBG=> W(V1)/M(V6)

- Onde Q: pathologique:

- Ample $\Rightarrow > 1/4R$

- Large $\Rightarrow =$ ou $> 1\text{mm}$

- Absence de R $\Rightarrow$ QS

⊖ q r st T: pathologique dans au moins 2 D

- DII_DIII_avF: inférieur

- V5_V6_DI_avL: latéral

- V1_V2_V3_V4: antérieur

- Ischémie :

- T ample ou (-)

- ST sus ou sous décalage

- Puis nécrose :

- Q Ample/large/seul

- Rabaillage de R( amplitude en V1V2V3V4)

- ST: >2mm/2D/2ECG

- Image en miroir :

ST(+) pas forcément a une image en miroir
mais ST(-) => image en miroir

- infer(DII DIII avF) # latéral haut(DI avL)

- infer # antérieur(V1V2V3V4)

- antérieur # poster (V7V8V9)

- latéral bas(V5V6) # droit (V1 av3R av4R)

- Onde T (-) en avR

- Elle peut être (-) en V1V2D3 à condition que QRS aussi si non pathologique

- T ample >2/3 ou plat <1/10 => pathologique

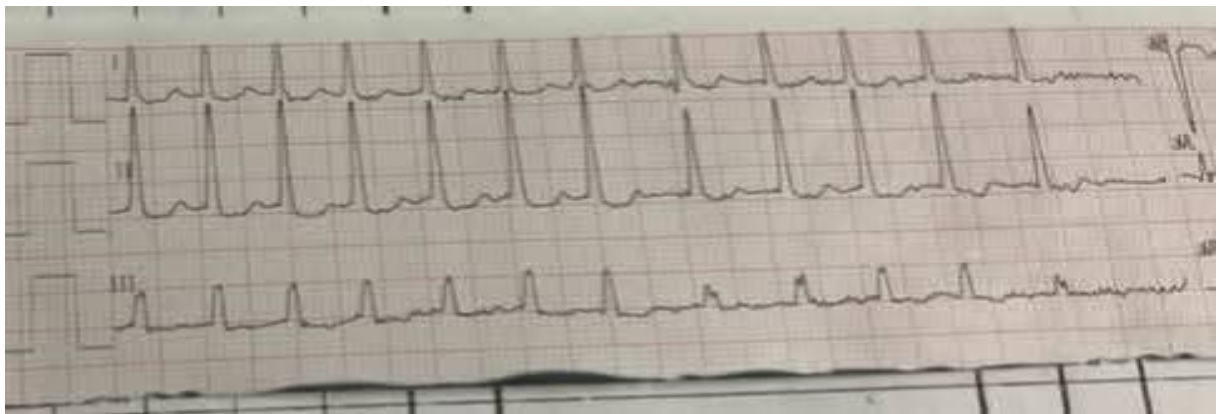
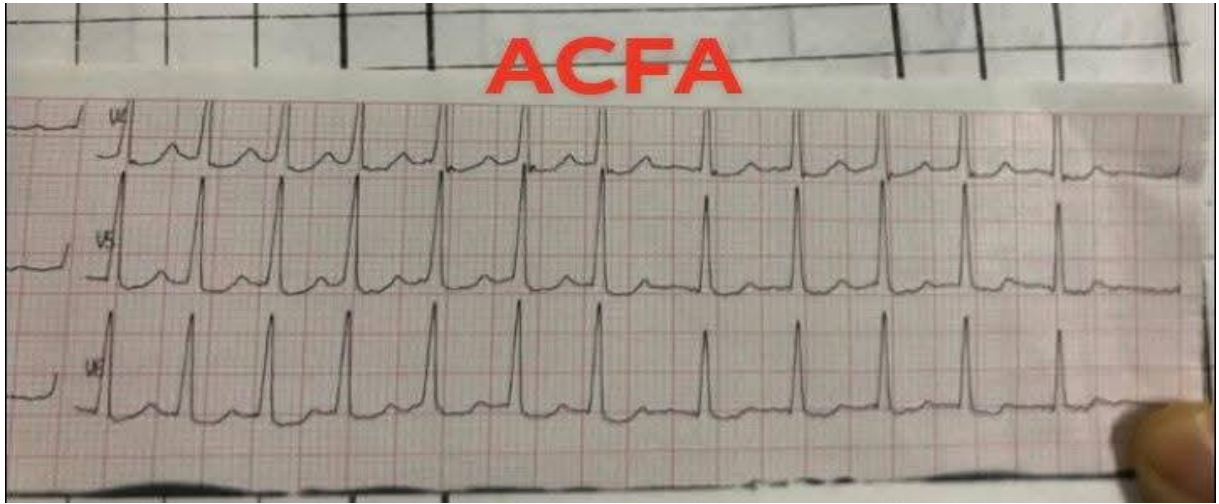
- Péricardite

- Ischémie

- Dyskalémie (ample: $\nearrow$ K / plat ou (-): $\searrow$ K)

D'après Dr.Astuce...

ACFA



● Motif : Palpitations

Femme de 52ans sans ATCD

⚠ Interprétation : **ACFA**

=> Rythme irrégulier + Absence d'onde P
(Remplacée par des trémulations)

- Tachycardie >100btt/min

- Causes : Valvulopathies, complications thromboemboliques, Traitement par les bêtabloquants ou Amiodarone en IV, Anticoagulants, anémie, Hyperthyroïdie

- Inhibiteur calcique bradycardisant en subligual comme Diltiazem

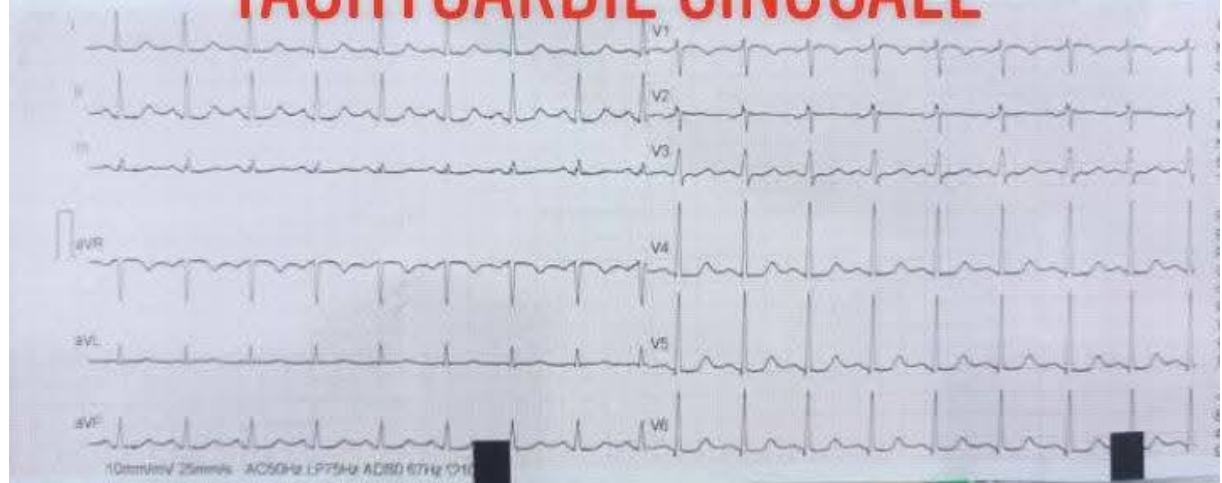
- Si bien toléré : cliniquement bien stable pas d'hypotension

☞ Orientation cardiologie pour instaurer un traitement anticoagulant le plus tôt possible (consultation cette semaine)

■ Si mal toléré : choc, OAP ..

☞ Avis cardiologie en urgence pour une cardioversion en urgence

TACHYCARDIE SINUSALE



● Motif: Palpitations

Patiente 37ans

Sans ATCD

Ta: 110/70

Dextro: correct

⚠ Interprétation: **Tachycardie_Sinusale**

● Clinique:

Bénigne FC=100/min

Effort, stress, consommation de tabac, café,

Fièvre, anémie, déshydratation, crise de panique, Hyperthyroïdie..

✓ O2 thérapie

1/2amp Mg diluée dans 250 SG5%

■ Bilan : 

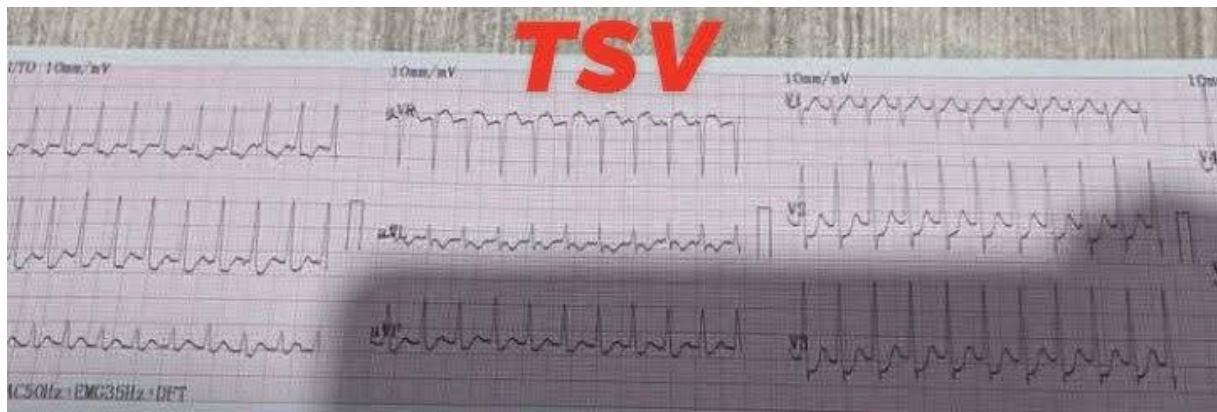
■ FNS

■ TSH

■ DDIMÈRES

■ Ionogramme

→ Orientation Cardiologie



● Motif : Palpitations

Sujet jeune sans ATCD

Dextro : normal

⚠ Interprétation : **TSV**

- Tachycardie supraventriculaire
- TA+++
- +/- Massage carotidien
- Manœuvre de Valsalva (vagale)

■ Si non réponse et TA correcte (stable) :

1cp de bêtabloquant ou 2amp de Cordaron en perfusion de SG 5%

 Si le malade est en état de choc (instable) :

 cardioversion en urgence

⊖ Attention : n'introduit jamais la Digoxine dans ce cas (WPW)

■ Après réduction=> ECG (à rechercher un raccourcissement de l'espace PR)



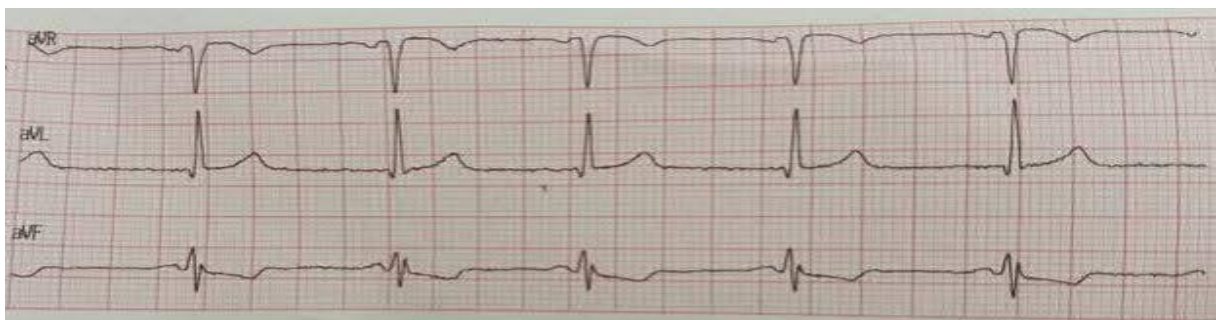
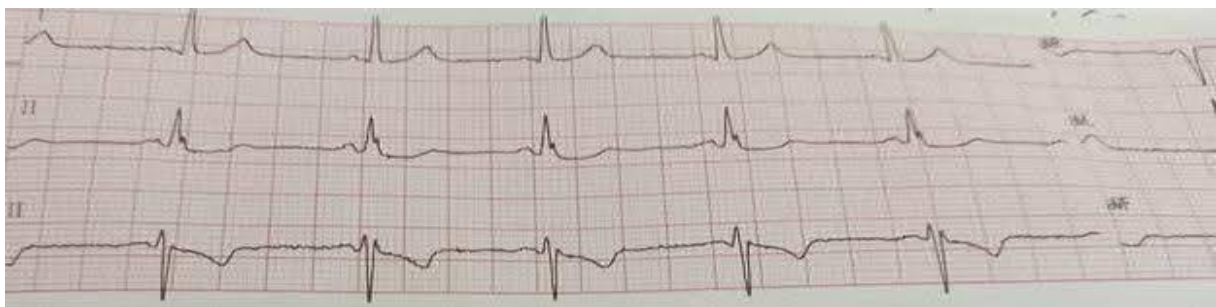
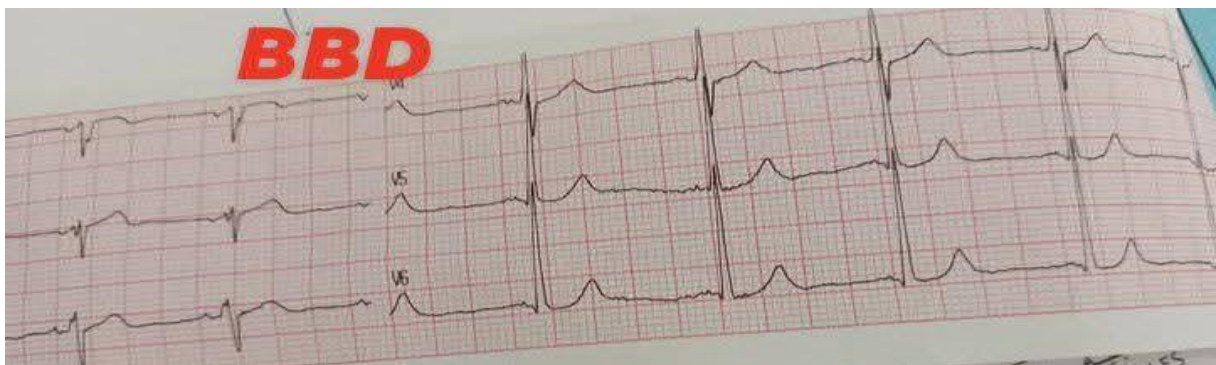
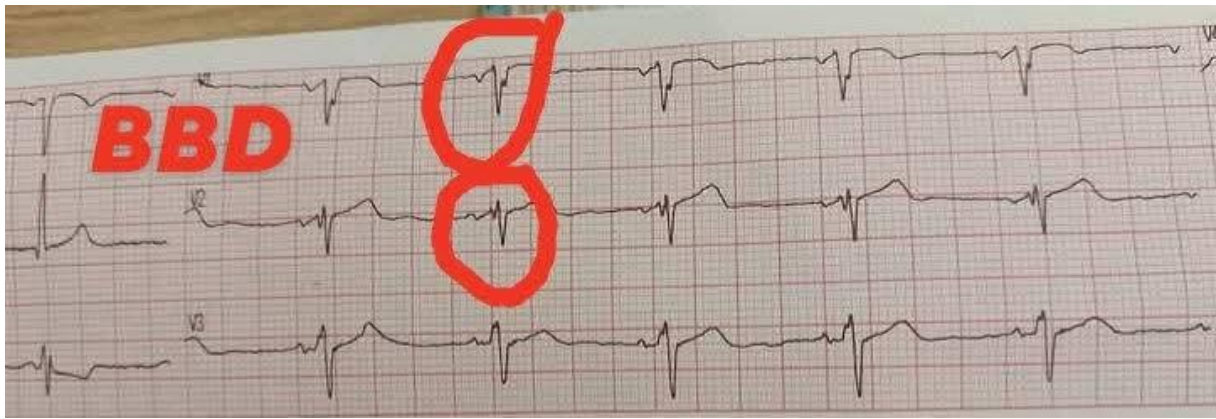
● Motif : Douleur épigastrique

Patient 84ans, hypertendu

Ta correcte

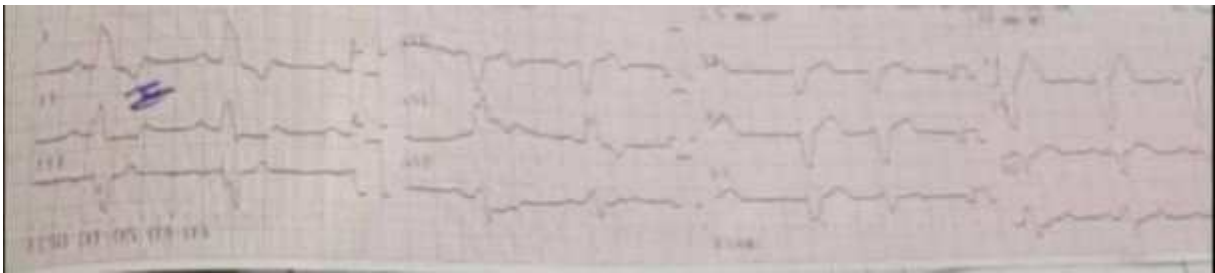
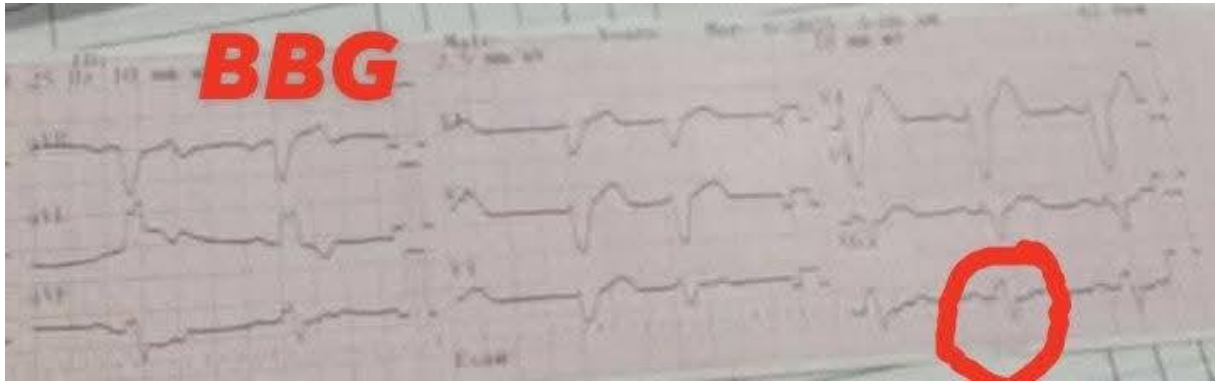
⚠ Interprétation : **SCA sans sus décalage de ST** en V4V5V6

- Ondes T amples=> Hyperkalémie
- Faire un ECG de 17D=> ça peut être une image en miroir d'un SCA(+)
- Demander :
 - Troponines
 - Ionogramme



BBD

=>Aspect en M en V1V2



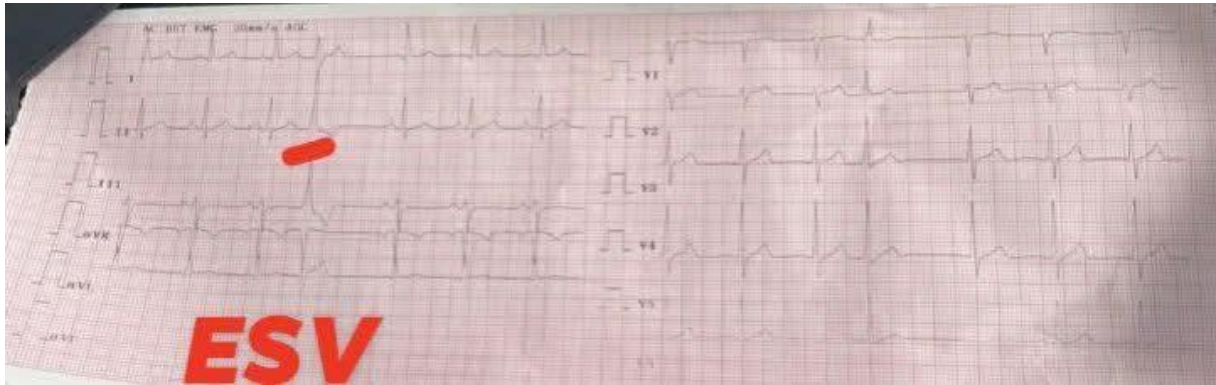
● Motif : Douleur thoracique

Patiente de 60ans

⚠ Interprétation : **BBG**

⇒ Aspect en M en V5V6

- BBG complet qui peut caché un syndrome coronarien.
- Scope
- Surveillance électrique
- ECG avec D2 long
- Dosage des troponines en urgence



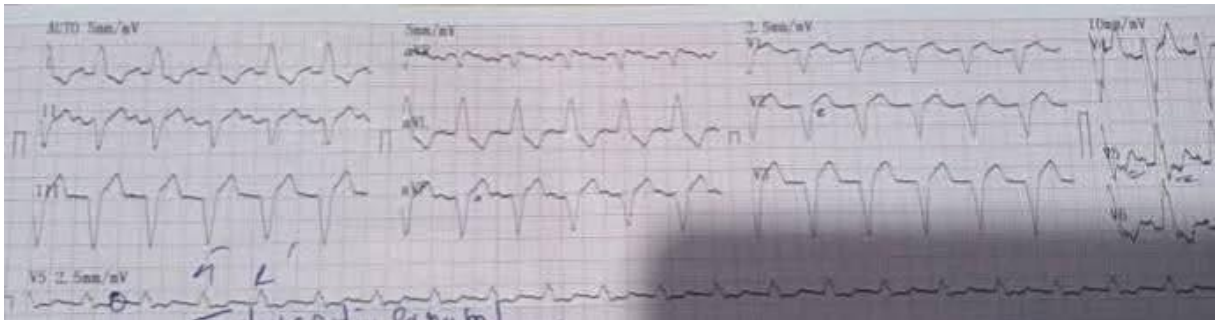
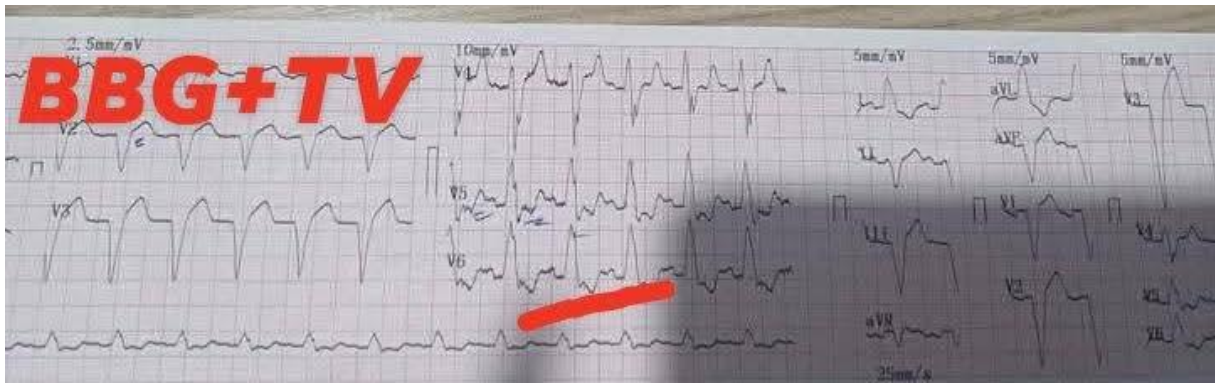
● Motif : Toux

Un patient de 73ans hypertendu

Ta 16/09

⚠ Interprétation : **ESV**

■ QRS prématuré



● Motif : Dyspnée

Patient sans ATCD

SaO₂ : normal

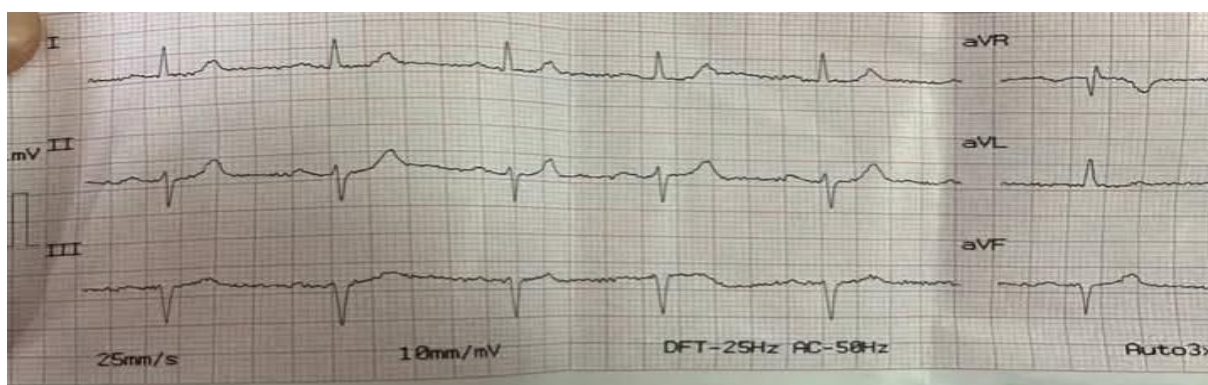
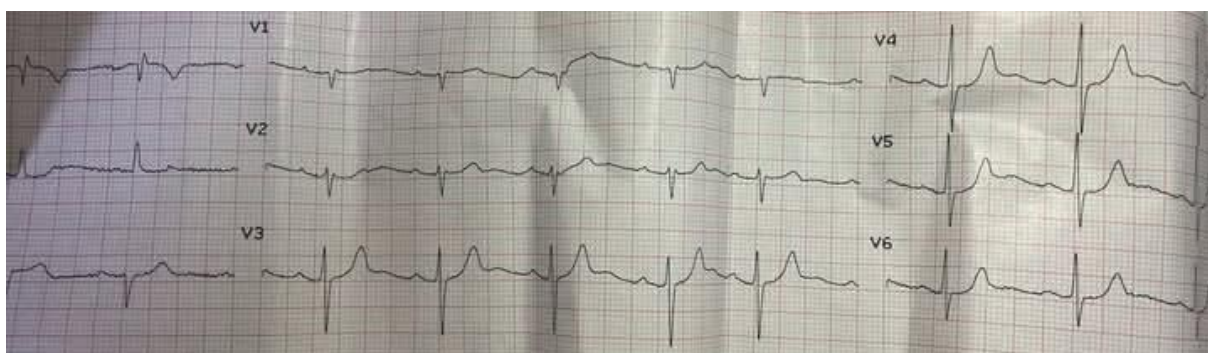
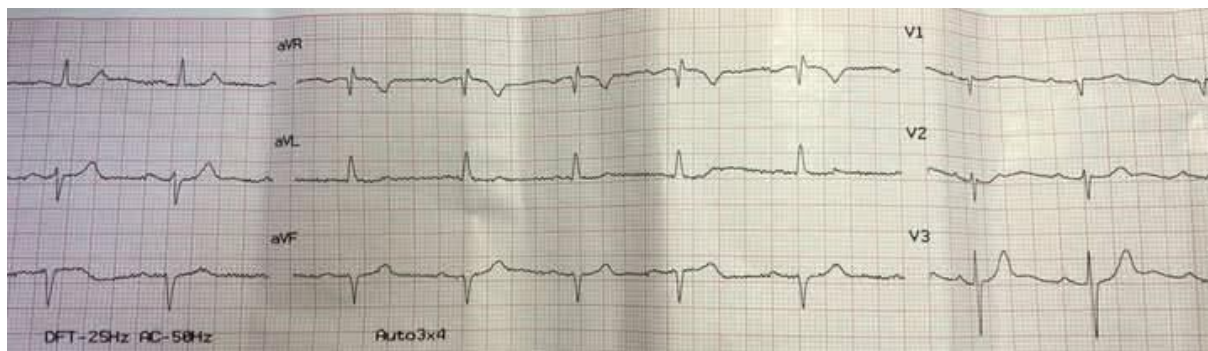
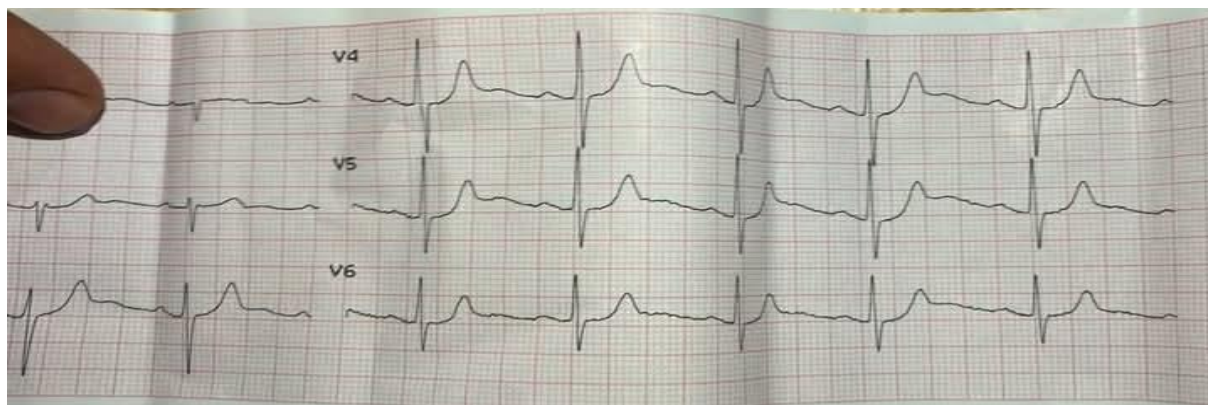
Ta : 22/14, FC : 116

⚠ Interprétation : **BBG + TV**

■ BBG (Aspect en M en V5V6)

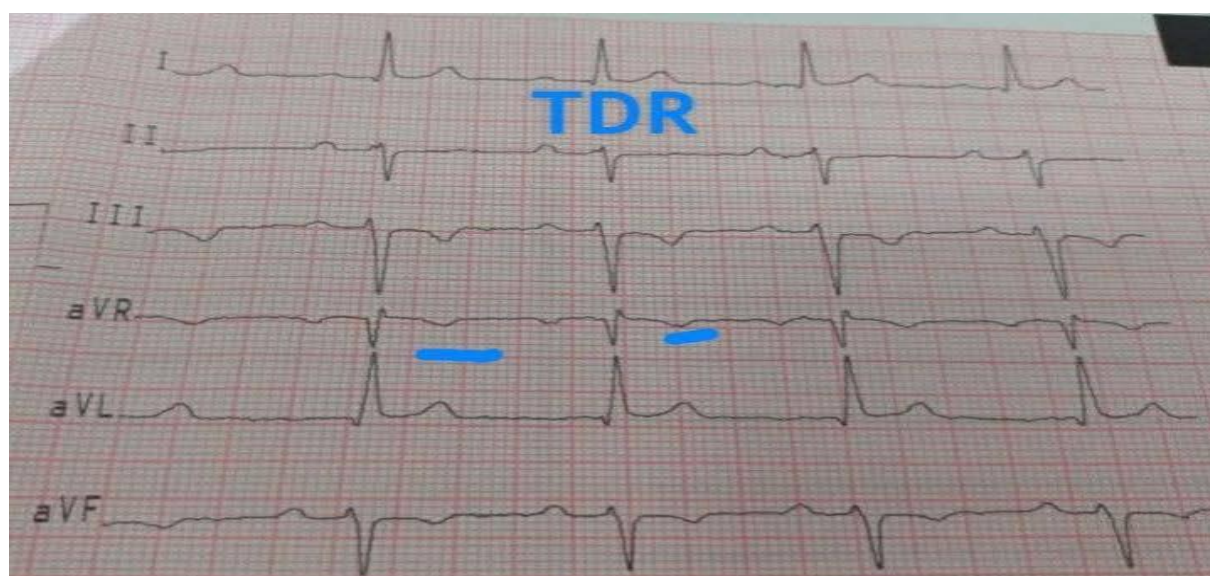
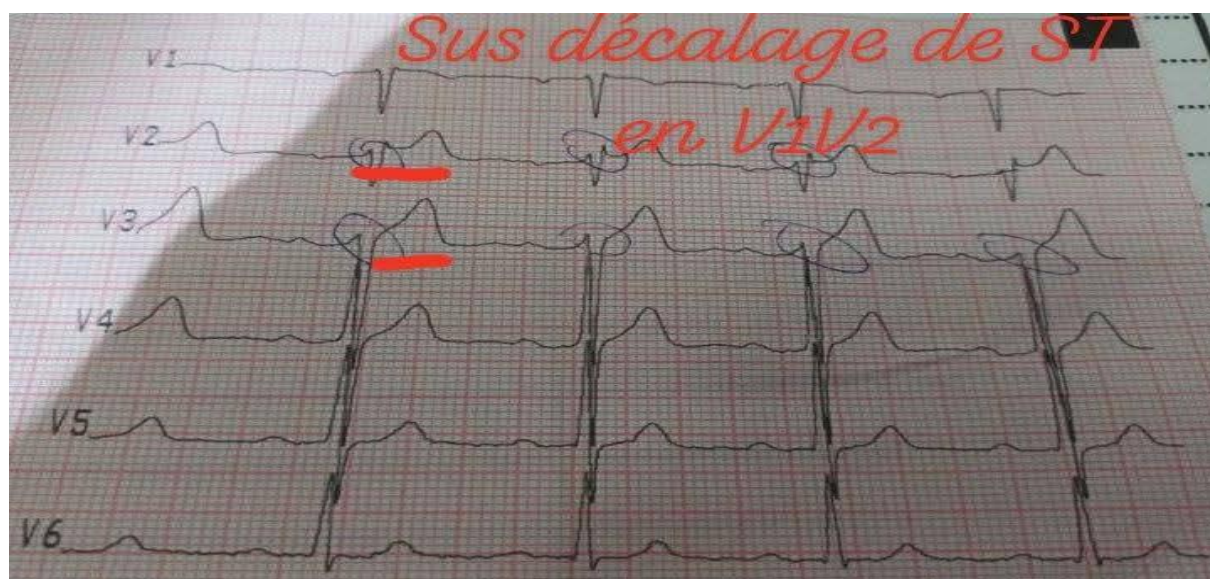
■ TV (QRS avec amplitude constant et durée constante)

⇒ OAP sur SCA st(+)



⚠ Interprétation : **BAV + BBD**

- PR allongé mais constant : BAV 1er degré
- QRS en V1 aspect en M : BBD incomplet



● Motif : Épigastralgies

Homme 61ans, Diabétique

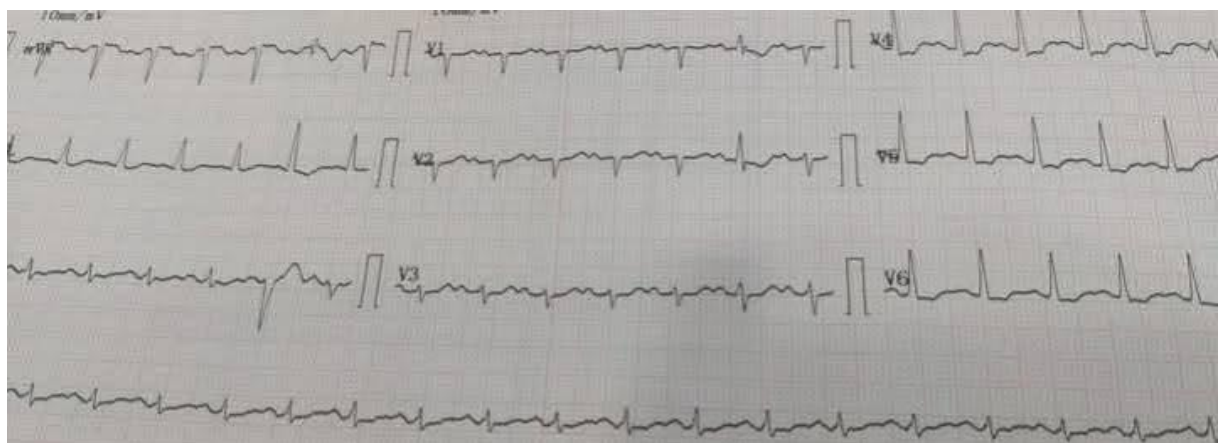
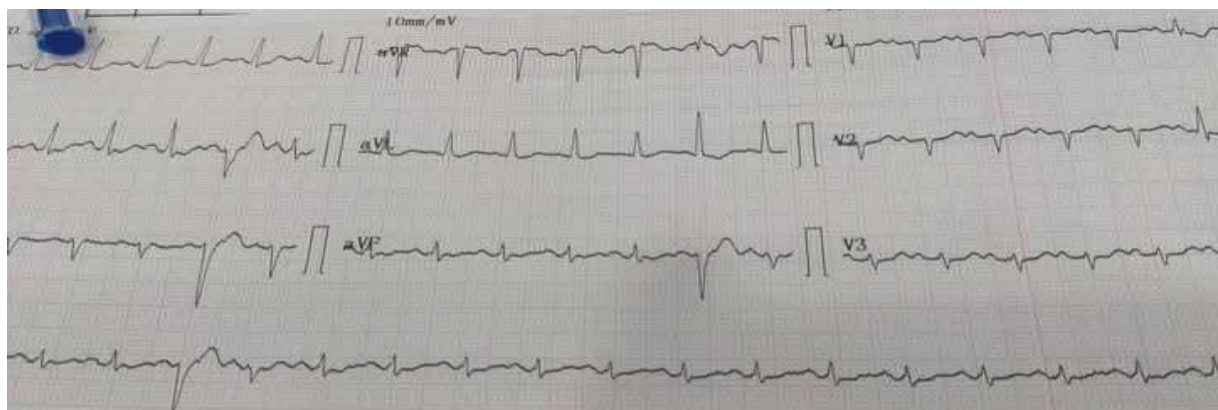
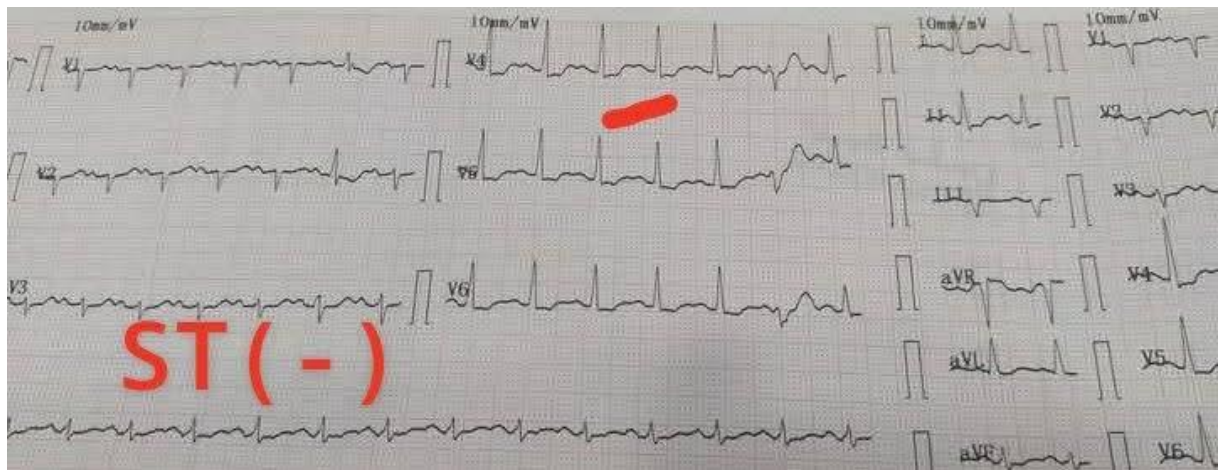
Ta : 15/10

⚠ Interprétation : **Sus décalage de ST en V2V3**

■ Troubles de repolarisation en territoire inférieur, AVR, V1

⇒ Dosage des troponines

■ Refaire l'ECG après 10_20min



● Patiente âgée de 65ans hypertendue, mal suivie pour son traitement d'HTA

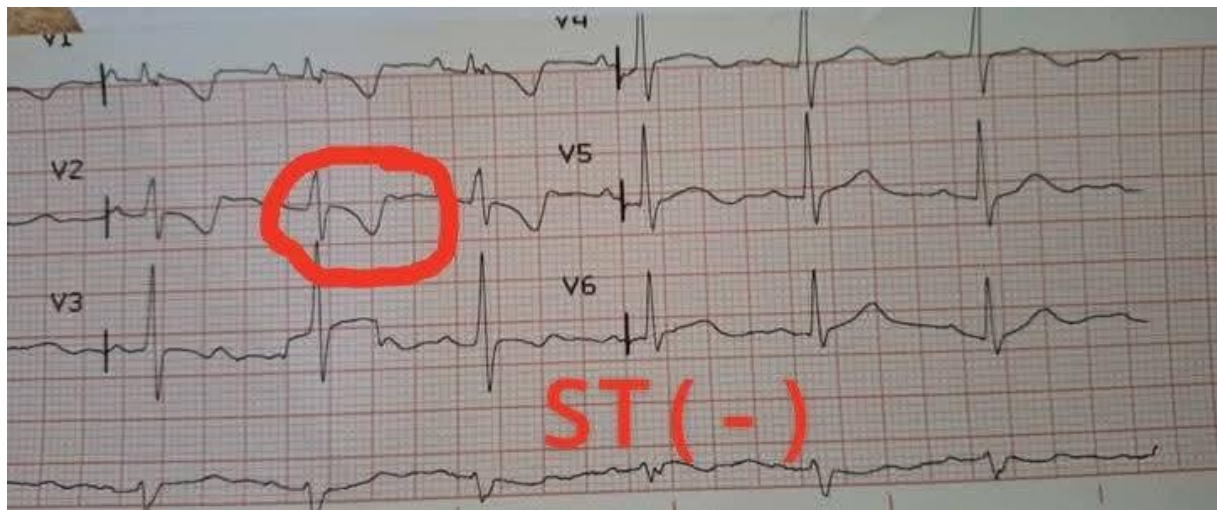
⚠ Interprétation: **Sous décalage de ST en V4V5V6**

=> Dosage des troponines

■ Refaire l'ECG

■ Faut faire les dérivations postérieures et droites, V7V8V9V1 V3R V4R

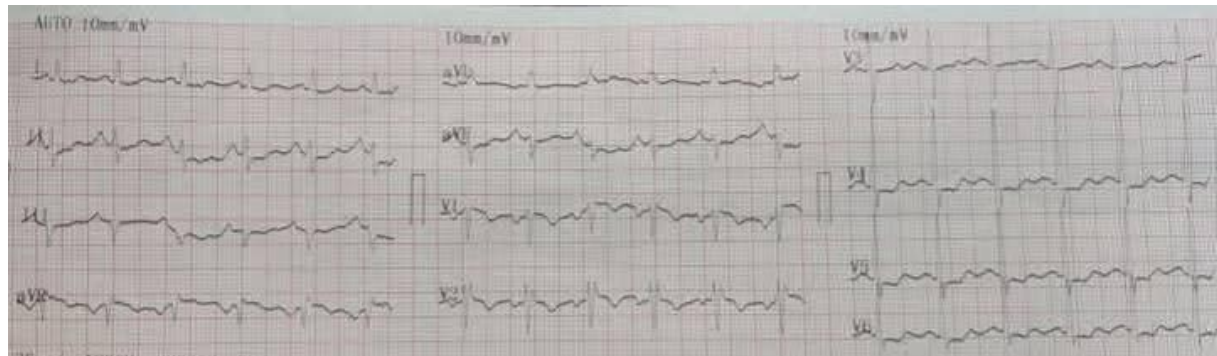
■ Le sous décalage en V5V6 peut être le miroir d'un sus décalage V1 V3R V4R, ischémie de la face latérale droite



● Motif : Épigastralgies

Patient de 40ans, hypertendu, diabétique

⚠ Interprétation : **Sous décalage de ST en V1V2V3**



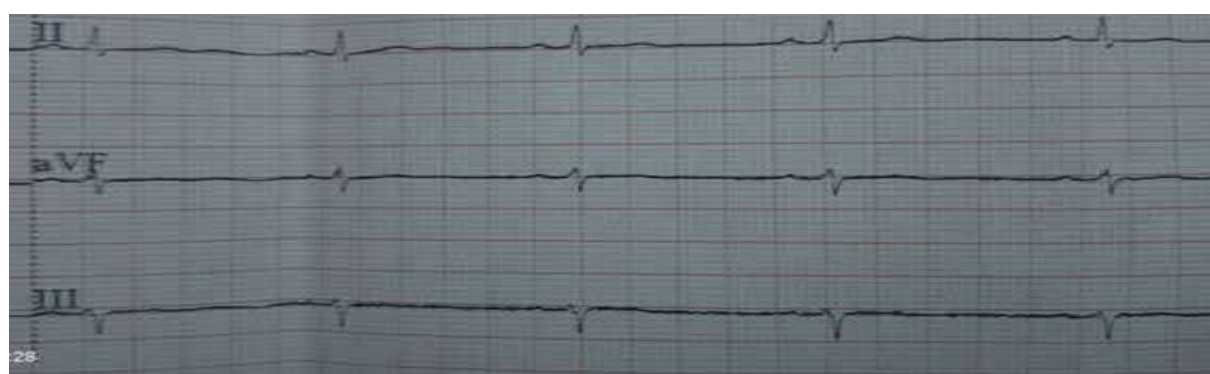
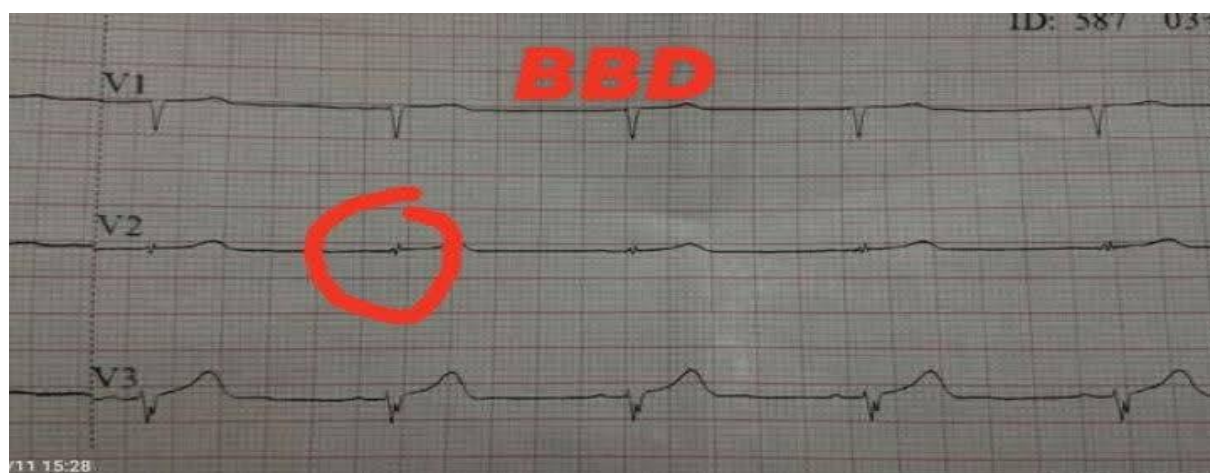
● Motif: Épigastralgies + Douleur thoracique irradie vers l'épaule gauche jusqu'au poignet et le cou

⚠ Interprétation: **Sus décalage en AVR +/- V1**
 + un sous décalage diffus aux autres dérivations
 ■ Aspect électrique d'une lésion tritronculaire (équivalent d'un syndrome coronarien à haut risque)

 CAT :

- 2 AVS / Scope
- Dosage des troponines
- Dose de charge : Plavix (selon l'âge), Aspegic 250mg, Lovenox (selon le poids)
- Faxez à un centre spécialisé pour la réalisation d'une coronarographie dans les plus brefs délais.

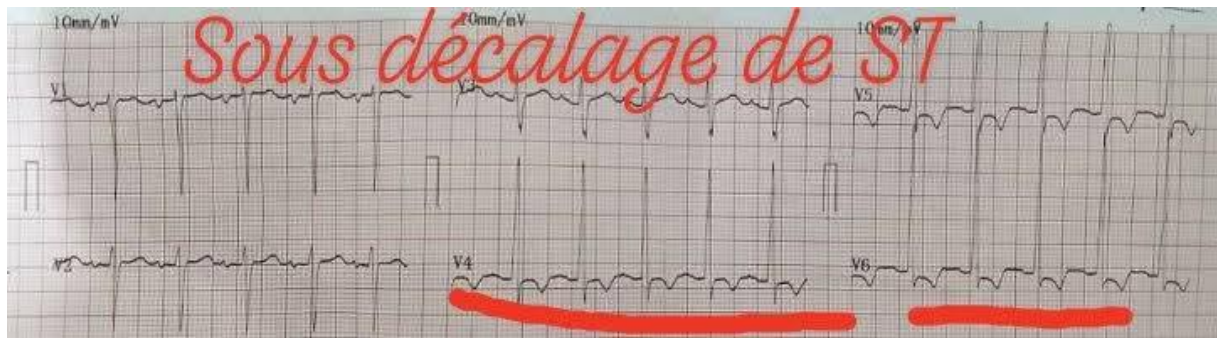
 Hospitalisation du patient au service de cardiologie



● Motif : Épigastralgies

Patient âgé de 70ans, hypertendu

⚠ Interprétation : **BBD**



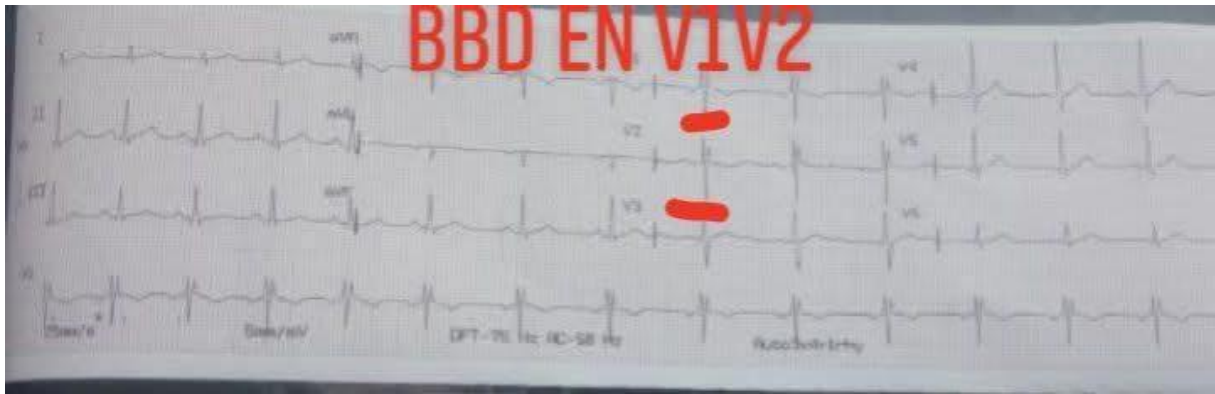
● Patiente de 63ans, sans ATCD

Ta : 18/08

T° : 18.6

⚠ Interprétation: **Sous décalage de ST en V4V5V6**

⇒ Dosage des troponines en urgence



● Un sujet jeune 25ans, sans ATCD

Présente une douleur thoracique précordiale sans irradiations ni d'autres signes associés sauf notion d'asthénie depuis une semaine

A l'examen clinique patient conscient coopérant en EG moyen SGW 15/15

TA : 150/90

FC : 84 FR : 24 SaO₂ : 97%

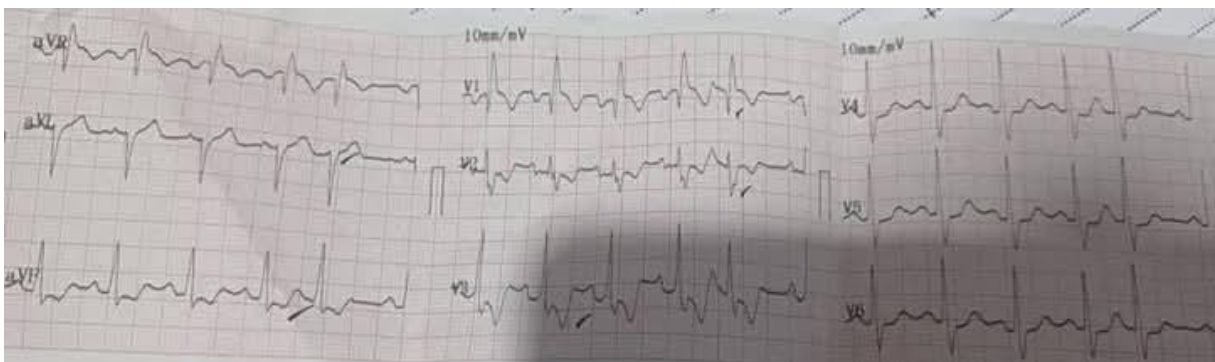
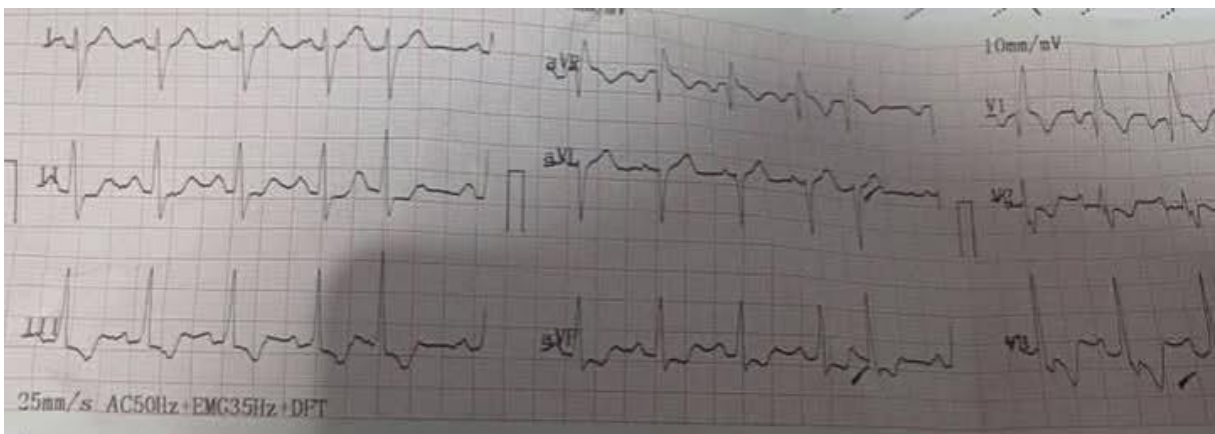
L'auscultation : propre

TLT est normal

⚠ Interprétation : **BBD en V1V2**

⇒ Aspect en M

SOUS DÉCALAGE DE ST



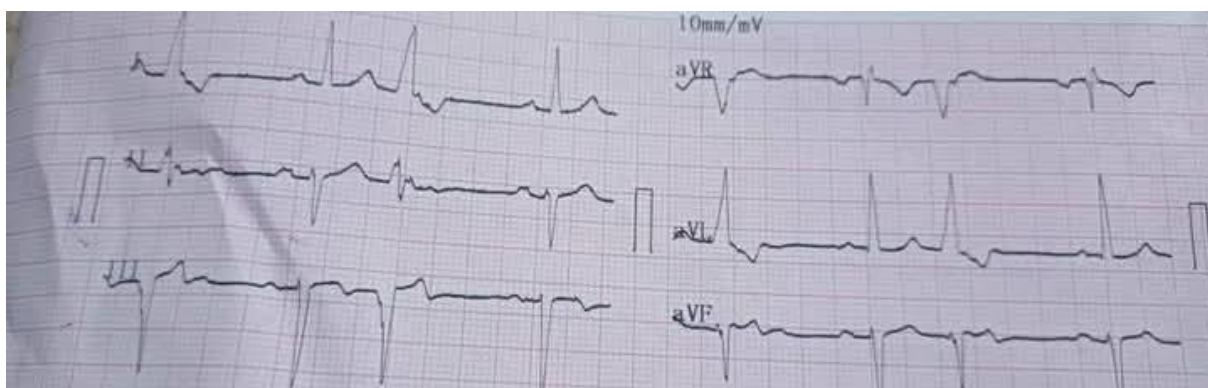
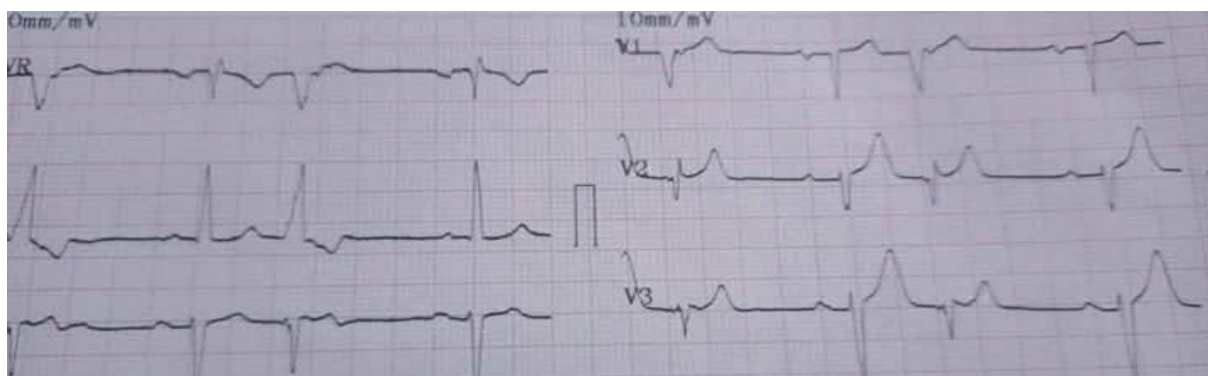
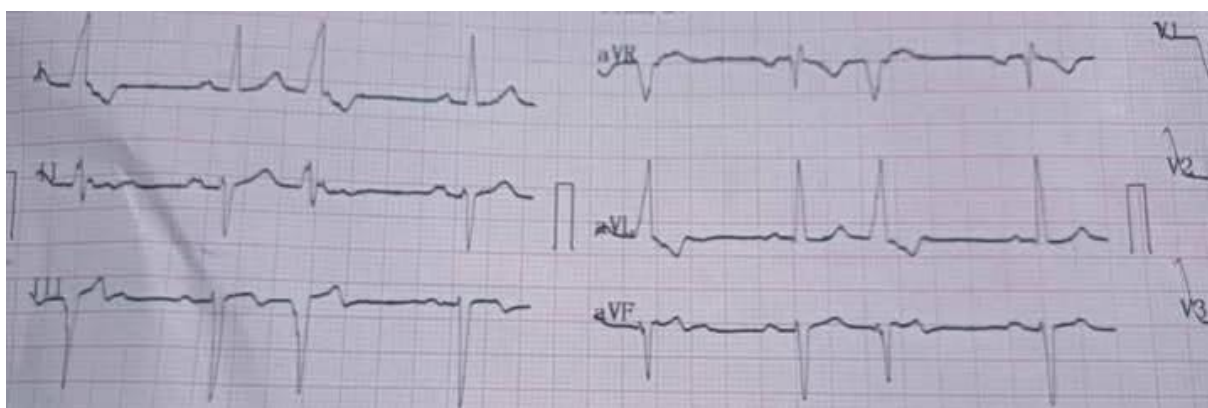
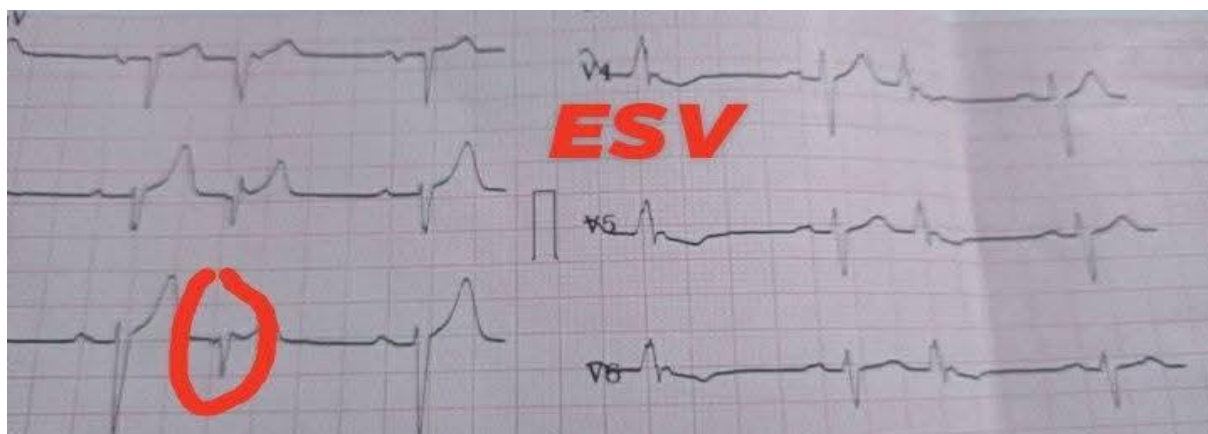
● Motif : Douleur thoracique

Ta normal

Examen normal

⚠ Interprétation : **Sous décalage de ST en antérieur et inférieur**

- Faites les dérivations postérieures (image en miroir)
- Dosage des troponines
- Refaire l'ECG après 10_20min



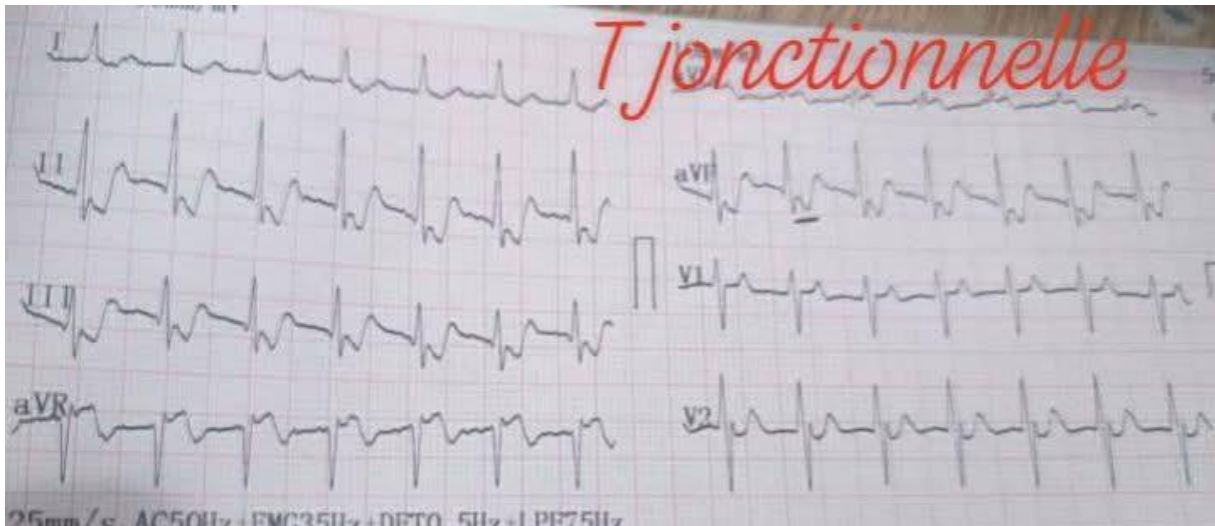
⚠ Interprétation : **ESV**

- QRS prématuré

✓ CAT :

- Si c'est symptomatique :

➡ Orientation Cardiologie en urgence



● Motif : Un pic d'HTA + Palpitations

Patiente 66ans, d'ATCD d'insuffisance rénale chronique, HTA sous traitement

Ta : 190/70 mmhg

Fc : 140/min

⚠ Interprétation : **Tachycardie_jonctionnelle**

⇒ Absence des ondes P + QRS fins

✓ CAT :

■ 1 amp de Mg dans 250cc de SG5 % ou SSI

Bisoprolol 5mg

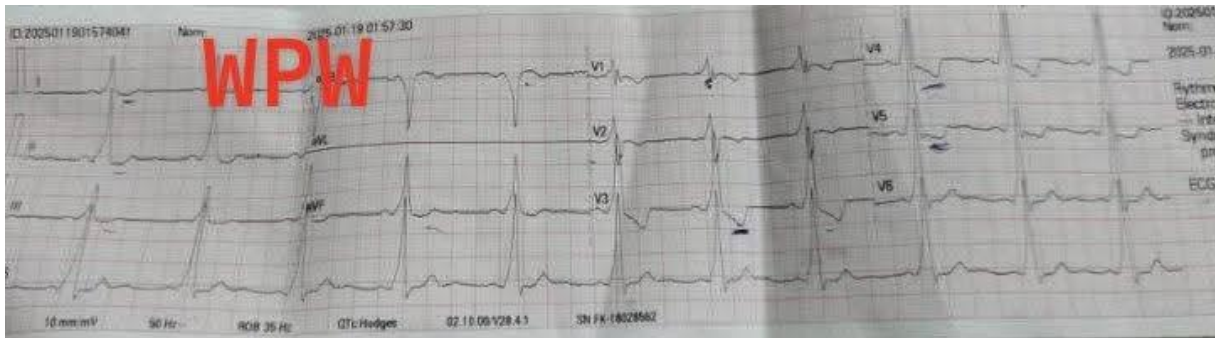
■ Manœuvre de Valsalva

■ Bilan 

■ FNS

■ Rénal

■ Ionogramme



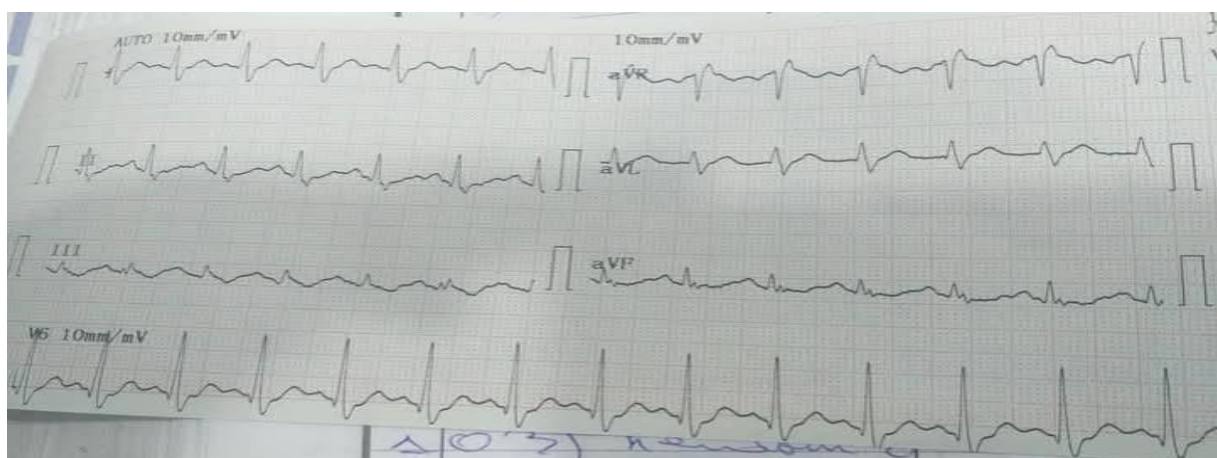
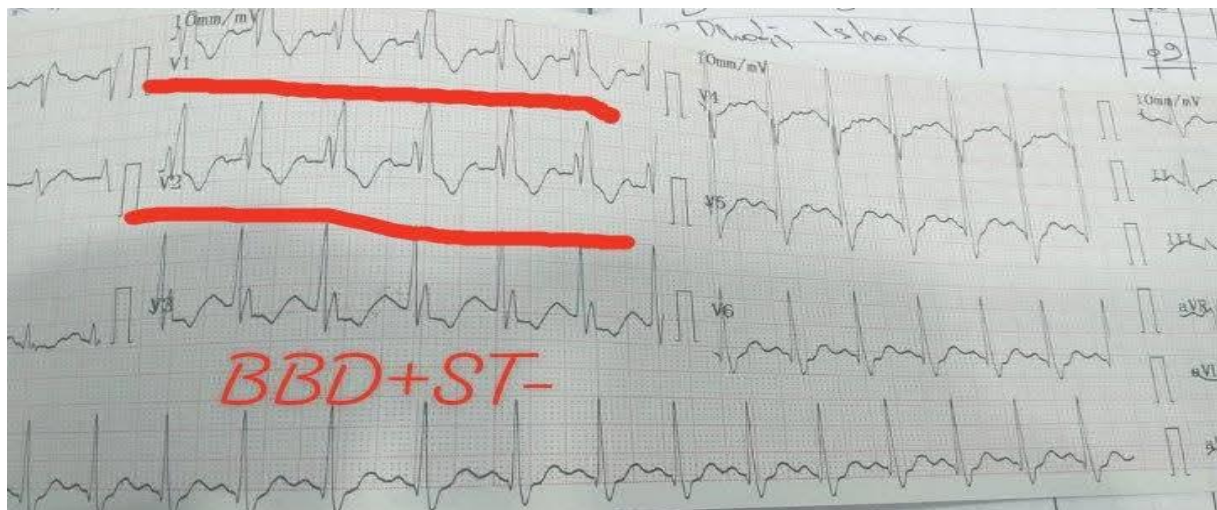
● Patient de 55ans, ancien tabagique

⚠ Interprétation : **Wolf Parkinson White WPW**

➡ Orientation Cardiologie en urgence

⊖ Risque de FA puis FV et mort subite

■ Toute activité sportive est contre indiquée

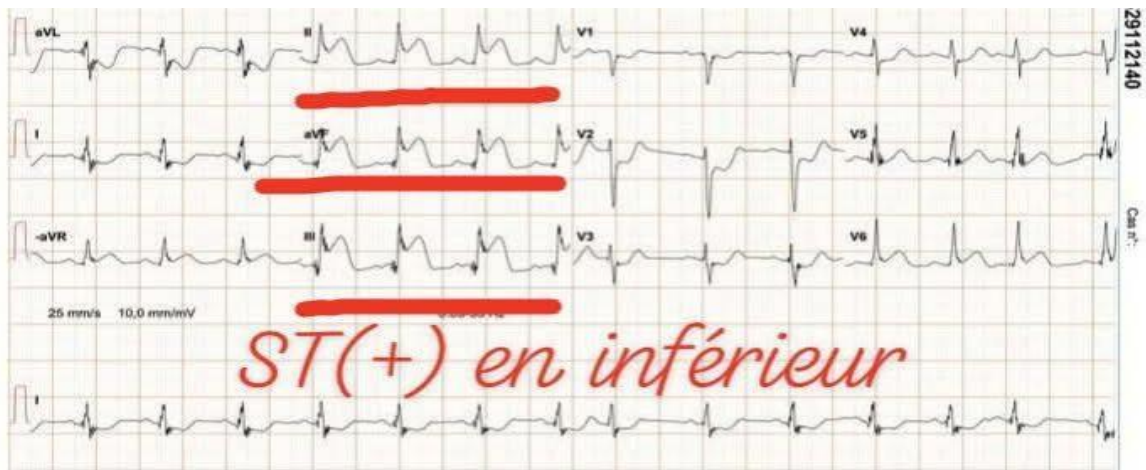


● Motif : Douleur thoracique

Patient 70ans, sans ATCD

⚠ Interprétation : **BBD + Sous décalage de ST en V1V2**

■ Dosage des troponines



● Homme de 67ans, diabétique et hypertendu qui se plainte de douleurs abdominales et de nausées depuis 24h

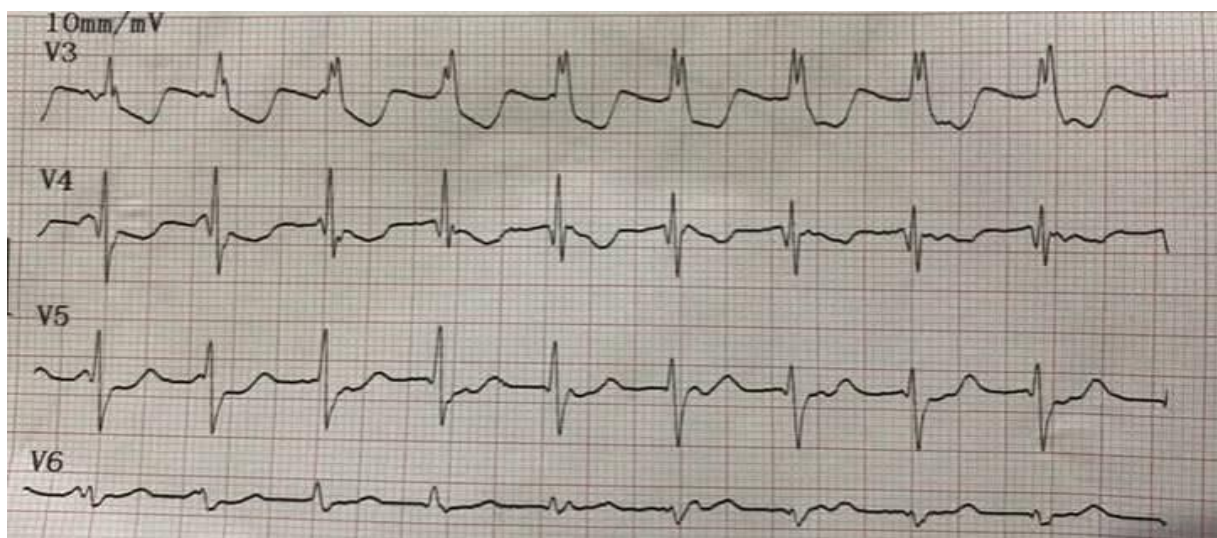
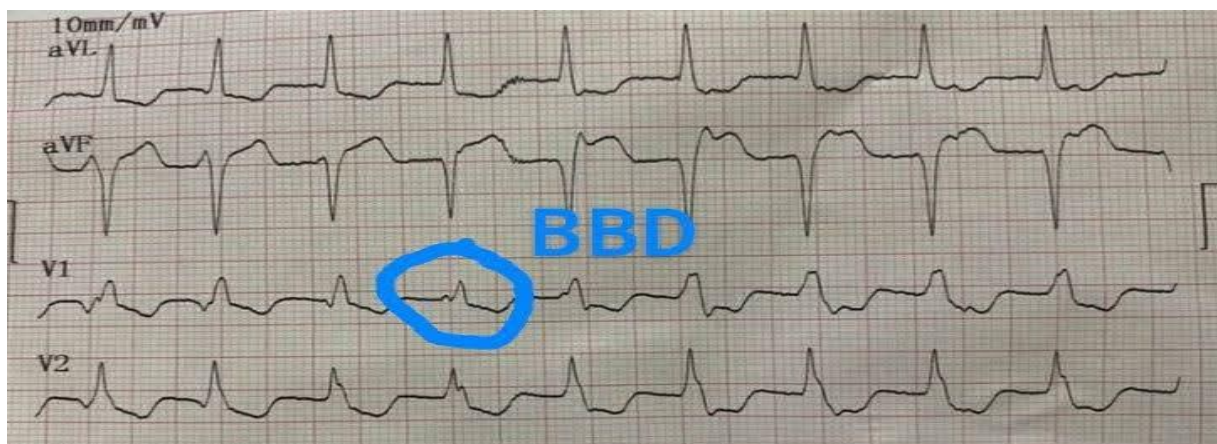
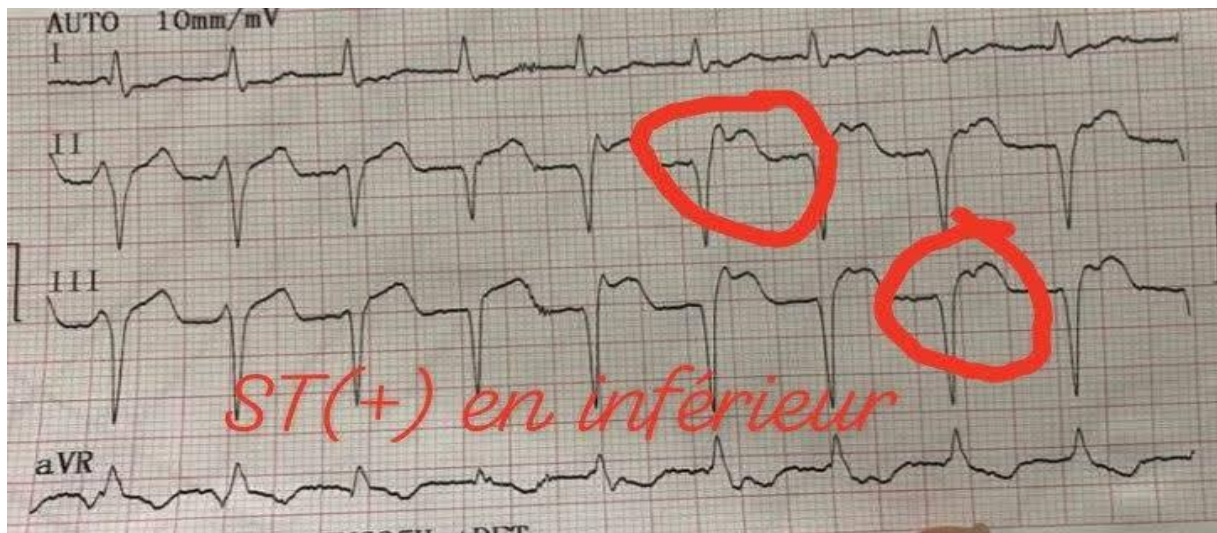
⚠ Interprétation : **STEMI ST(+) en inférieur DII DIII AVF**

■ Avec image en miroir en latéral haut DI AVL

Mais, on note également un sous-décalage en antérieur V1V2V3 ce qui est à coup sûr l'image en miroir du territoire postérieur..

■ Donc c'est un STEMI postérieur Vrai

■ Compléter les dérivations droites et postérieures +++



● Patiente de 66ans, diabétique

Elle consulte pour des vomissements et toux

Gly : 4

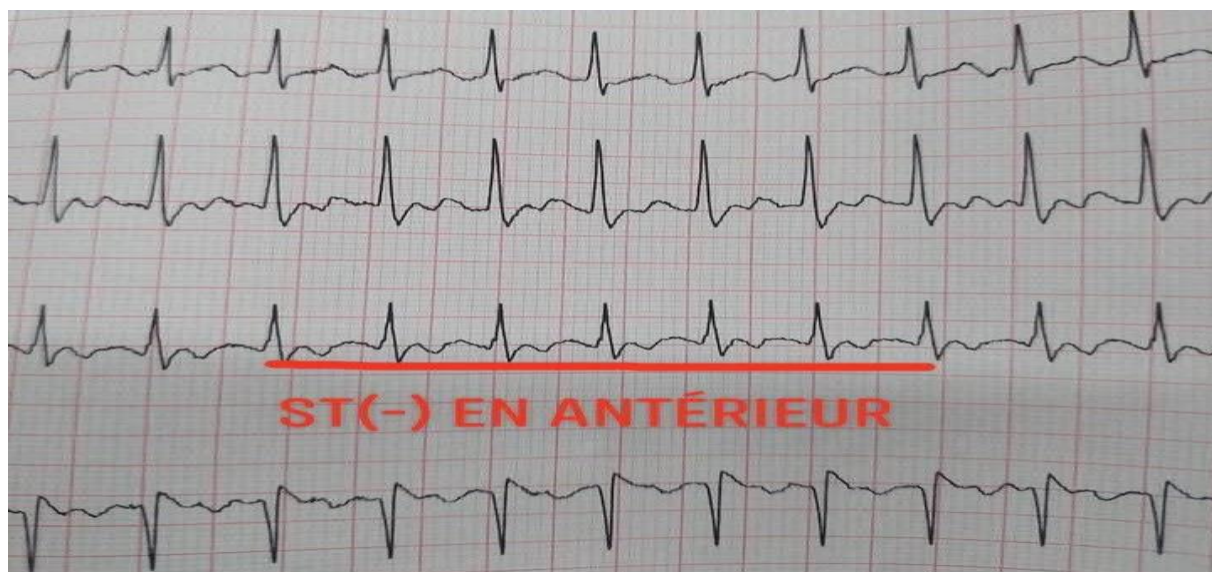
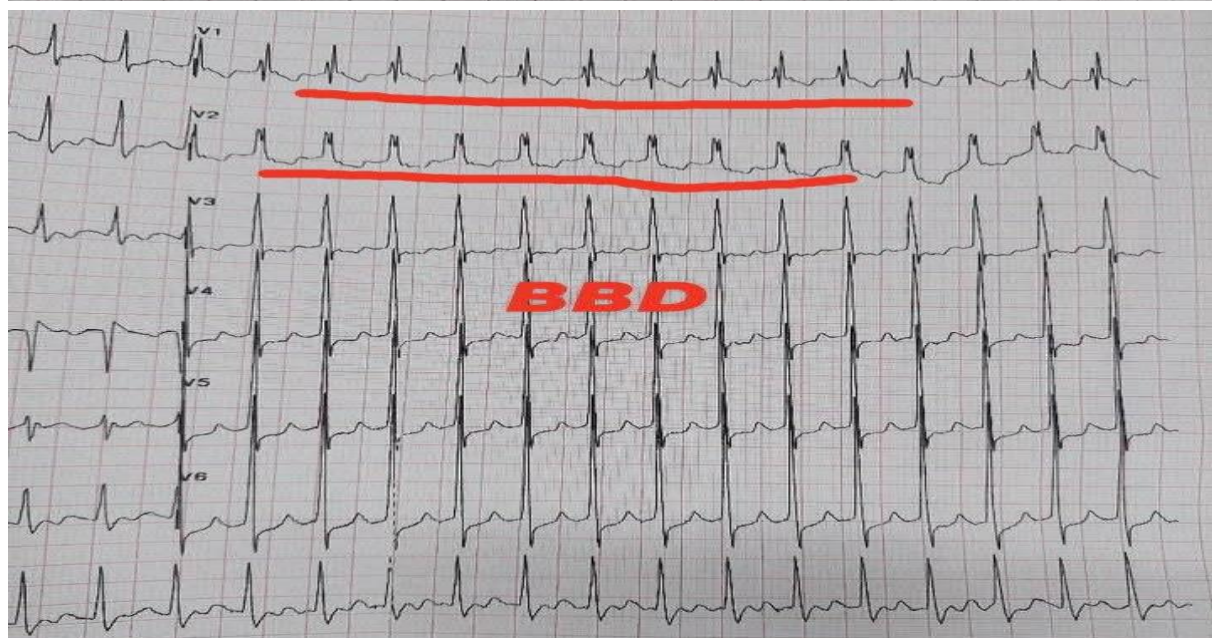
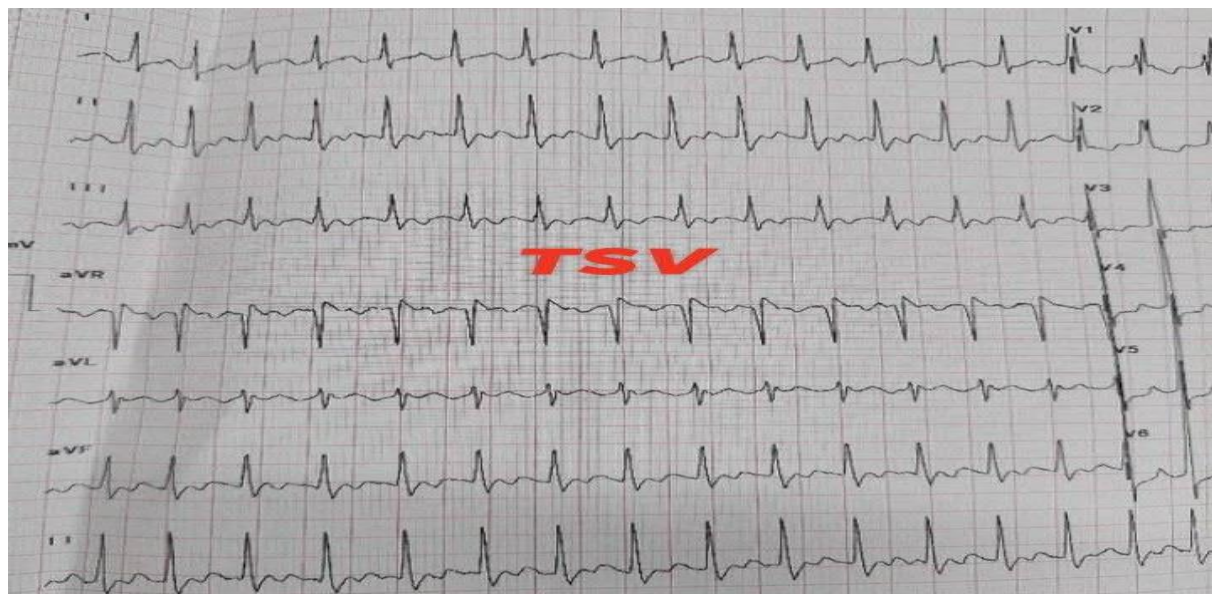
Ph (bandelette) : 5

CU : cc+++

⚠ Interprétation : **Sus décalage en inférieur D2D3 AVF** avec des images en mémoire V5 AVL
+ **BBD aspect en M en V1V2**

■ Compléter par les dérivations droite et postérieure

■ Donner les doses de charge Aspegic et Plavix
évacuer rapidement le malade



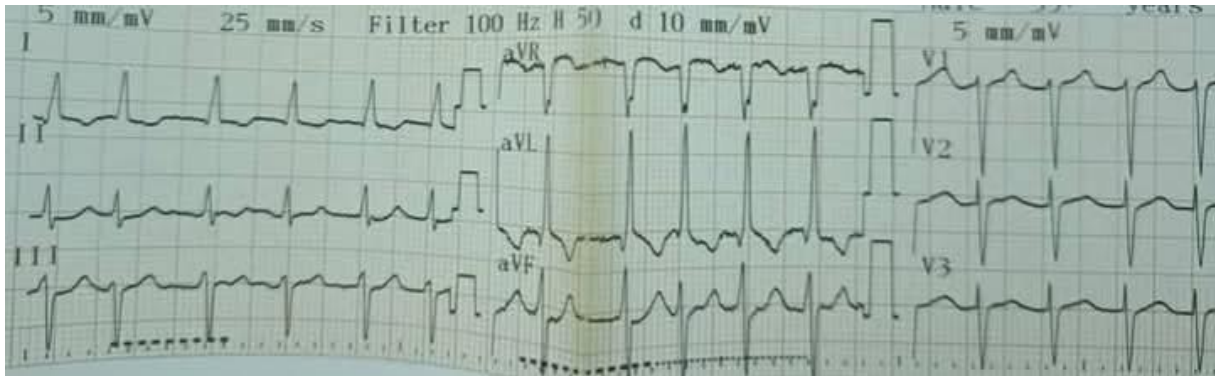
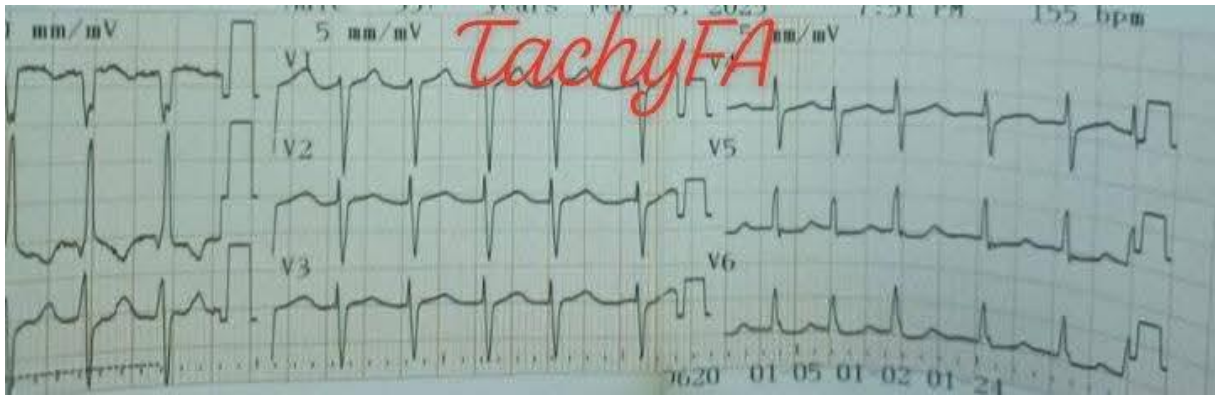
● Patiente de 62ans, d'ATCD de syndrome du côlon irritable

Consulte pour tachycardie Fc :174

Ta : 11/07

⚠ Interprétation : **TSV + BBD (Aspect en M en V1V2) + ST(-) en antérieur**

- Nb : On ne peut pas interpréter un sous ou sus décalage en Tachycardie
- Faut d'abord ↘ la Fc
- Mg 1amp en IVL si non Béta bloquant ou Cordarone, puis refaire l'ECG

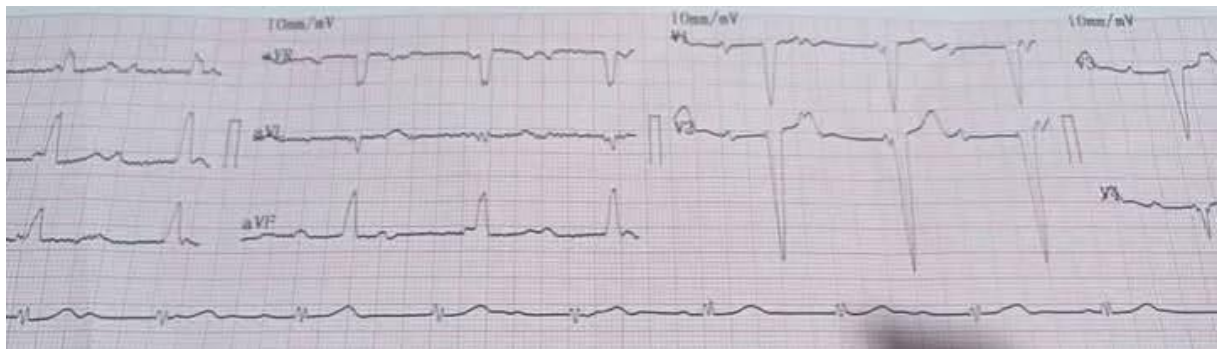
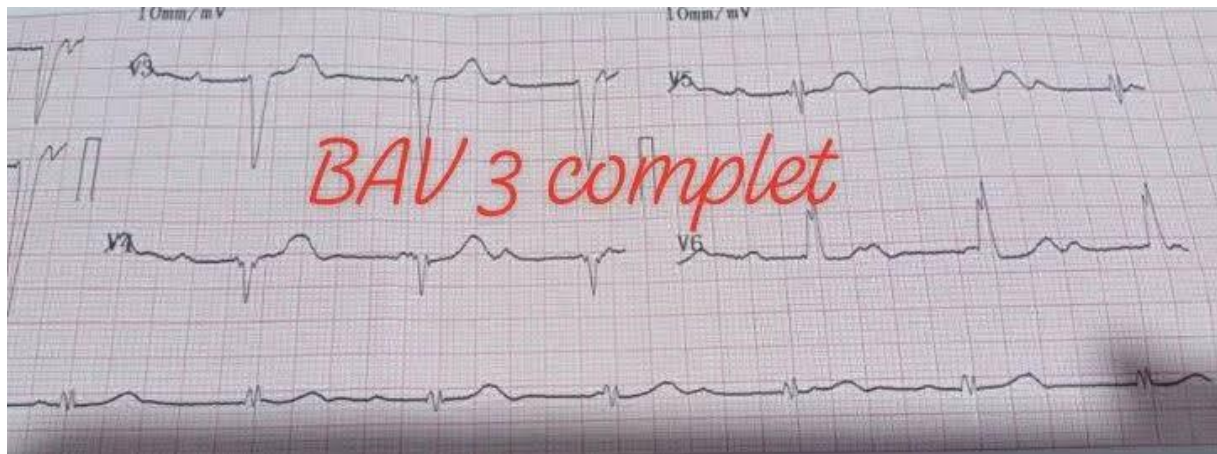


● Patient de 84 ans, sans ATCD

Douleur thoracique intense non soulager par
Perfalgan

Ta 120/70, Fc : 75, SaO₂ : 99

⚠ Interprétation : **TachyFA + BBG**



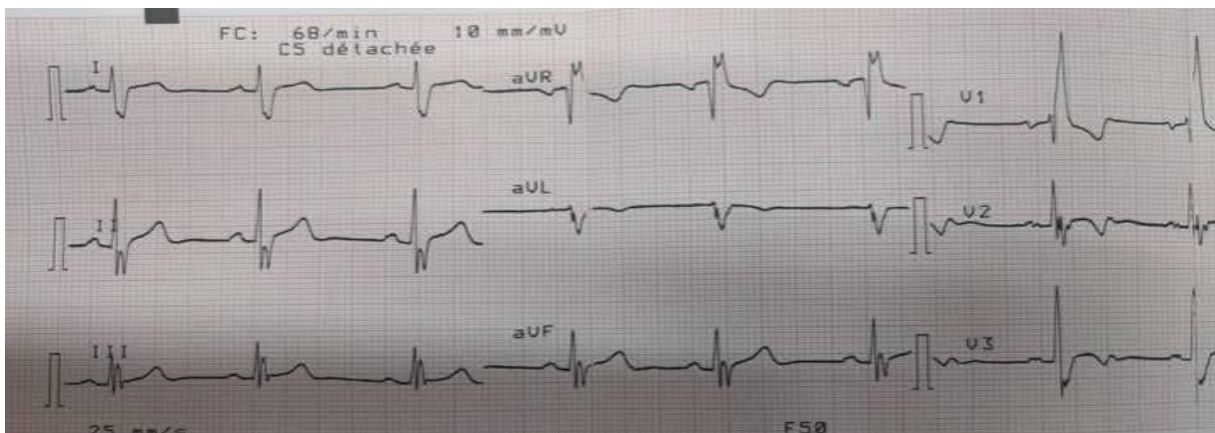
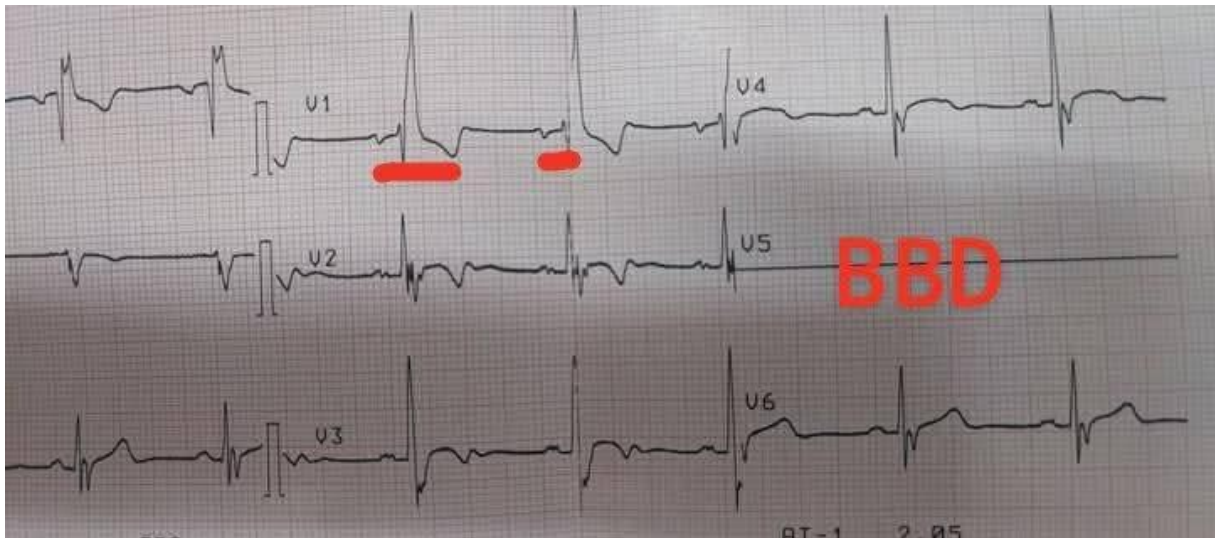
● Epigastralgies

Ta normal

Pacemaker

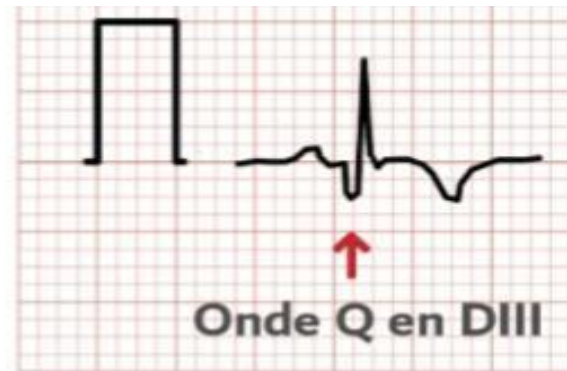
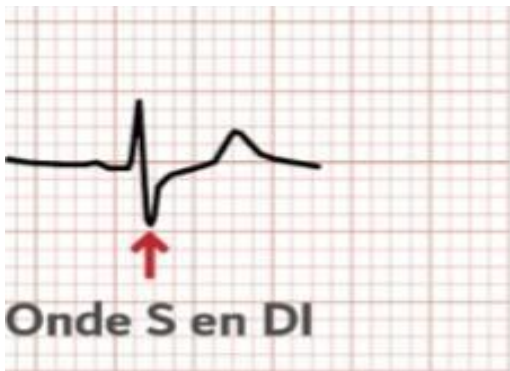
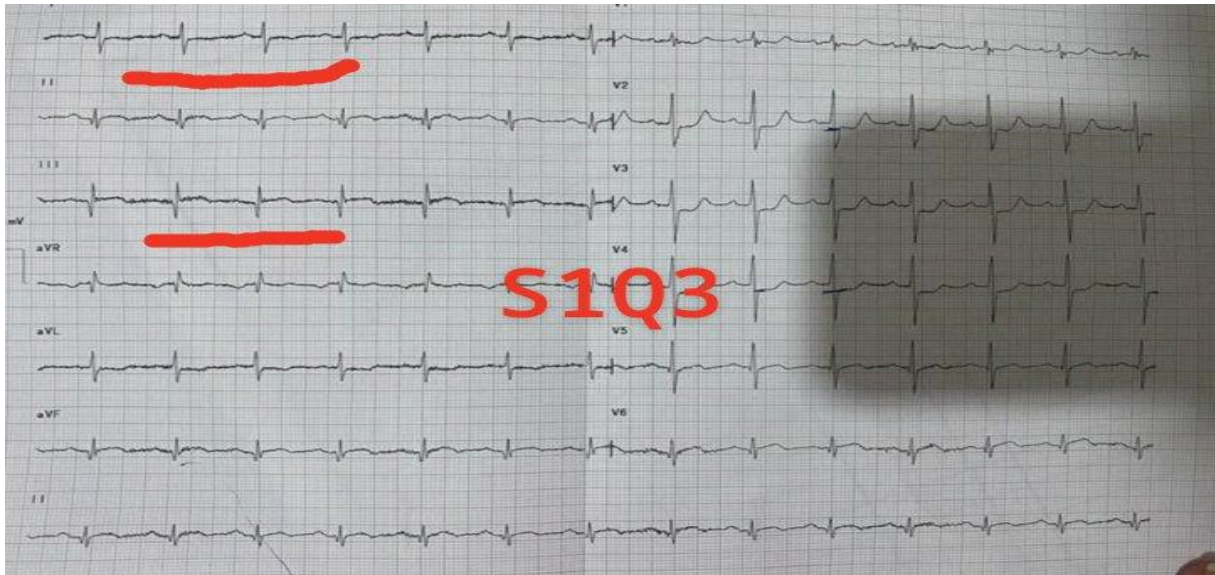
⚠ Interprétation : **BAV 3 complet** (toutes Les ondes P sont bloquées)

➡ Avis cardiologie en urgence



● Dans le cadre du travail d'un sujet de 35ans

⚠ Interprétation : **BBD**



● Patient de 61ans aux ATCD de diabète et HTA

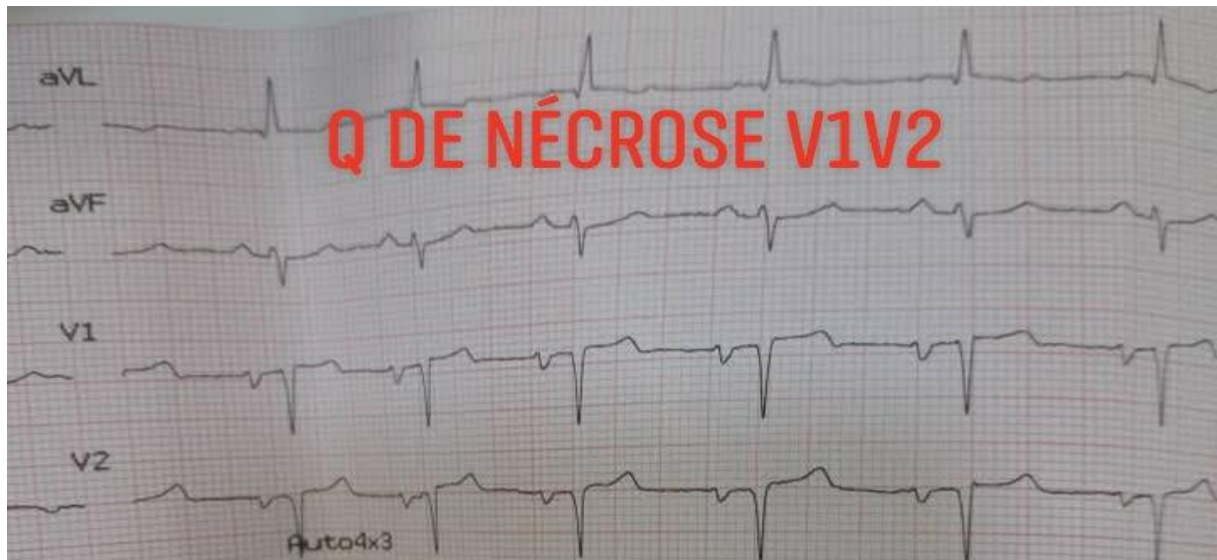
Il consulte pour une dyspnée et sueurs

Ta: 12/8, Dextro: pas de bandelette

Auscultation libre

⚠ Interprétation: **Aspect S1Q3=> Embolie pulmonaire**

■ Dosage: Troponines/DDIMÈRES



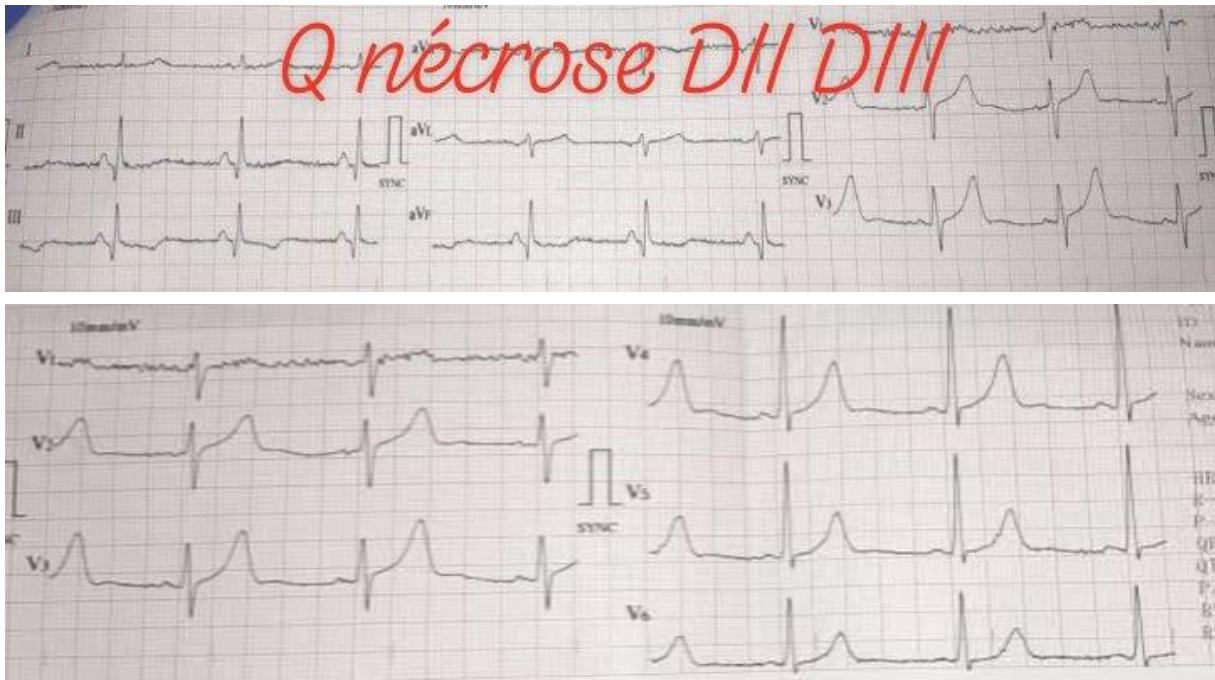
● Patiente de 76ans, ATCD : DID

Cardiopathie avec IDM en 2023

Consulte pour douleur thoracique irradiant aux épaules, Toux grasse , TLT fait objectivant un sd interstitiel sous traitement antibiotique

⚠ Interprétation: **Q de nécrose en V1V2**

■ Séquelles de l'IDM



● Sujet âgé hypertendu, il a fait une chute de sa propre hauteur avec plaie du scalp

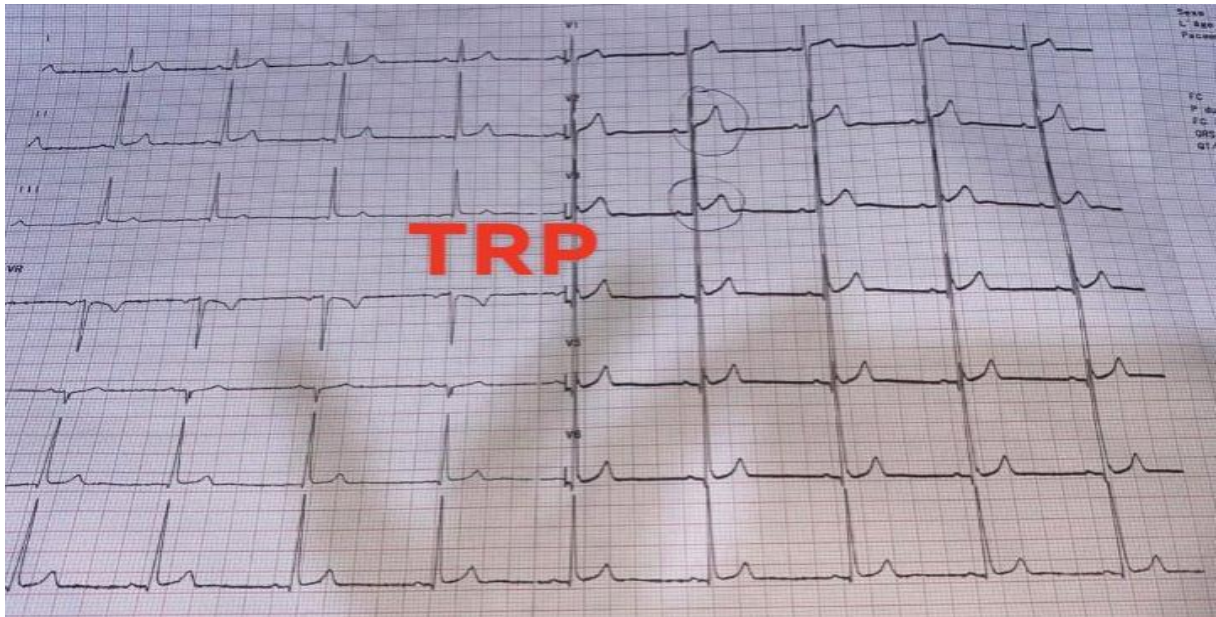
Ta: 10/6

Gly: 1.4 g/dl

⚠ Interprétation : **Q de nécrose en DII DIII**
(Séquelles d'IDM)

+ T ample (Troubles de repolarisation)

=> Ionogramme



● Patient de 27ans, sans ATCD

Il consulte pour douleur cardiaque avec fourmillements de main gauche

⚠ Interprétation : **Trouble de repolarisation précoce** (Bénin)

- Pour TRP : Généralement un sujet jeune, sans FDR :
- Sus décalage concave vers le haut, absence d'images en miroir
- Présence de point « J »
- QRS amples...

- Mais, ça n'élimine pas un sus décalage, plus la clinique ça reste inquiétante..
- Demande un dosage des troponines pour confirmer et refaire l'ECG



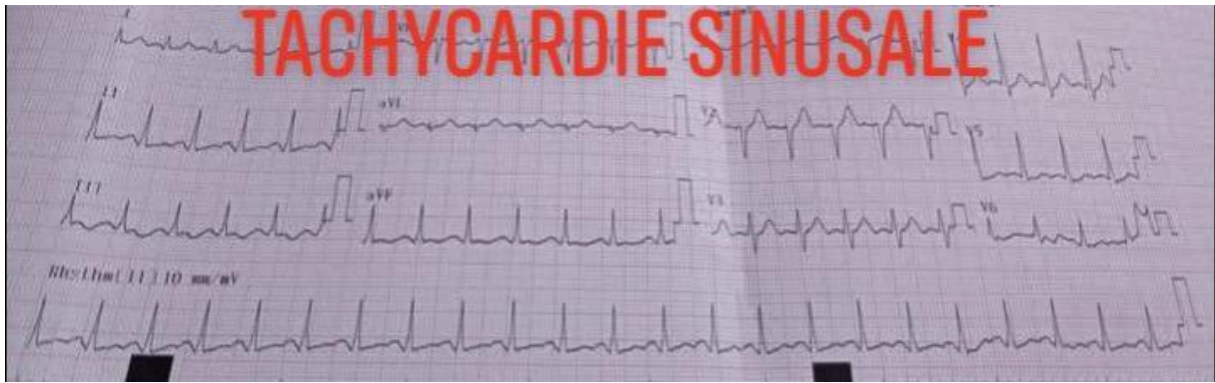
● Sujet jeune

Diarrhée depuis 1 semaine

Présente une lipothymie avec Ta : 09/07

⚠ Interprétation : **BAV 1^{er} degré**

⇒ Allongement de l'espace PR



● Sujet jeune

Ta : 14/ 08

Il bois 4 ou 5 bouteilles d'un boisson
énergétique

Palpitation : Fc : 134

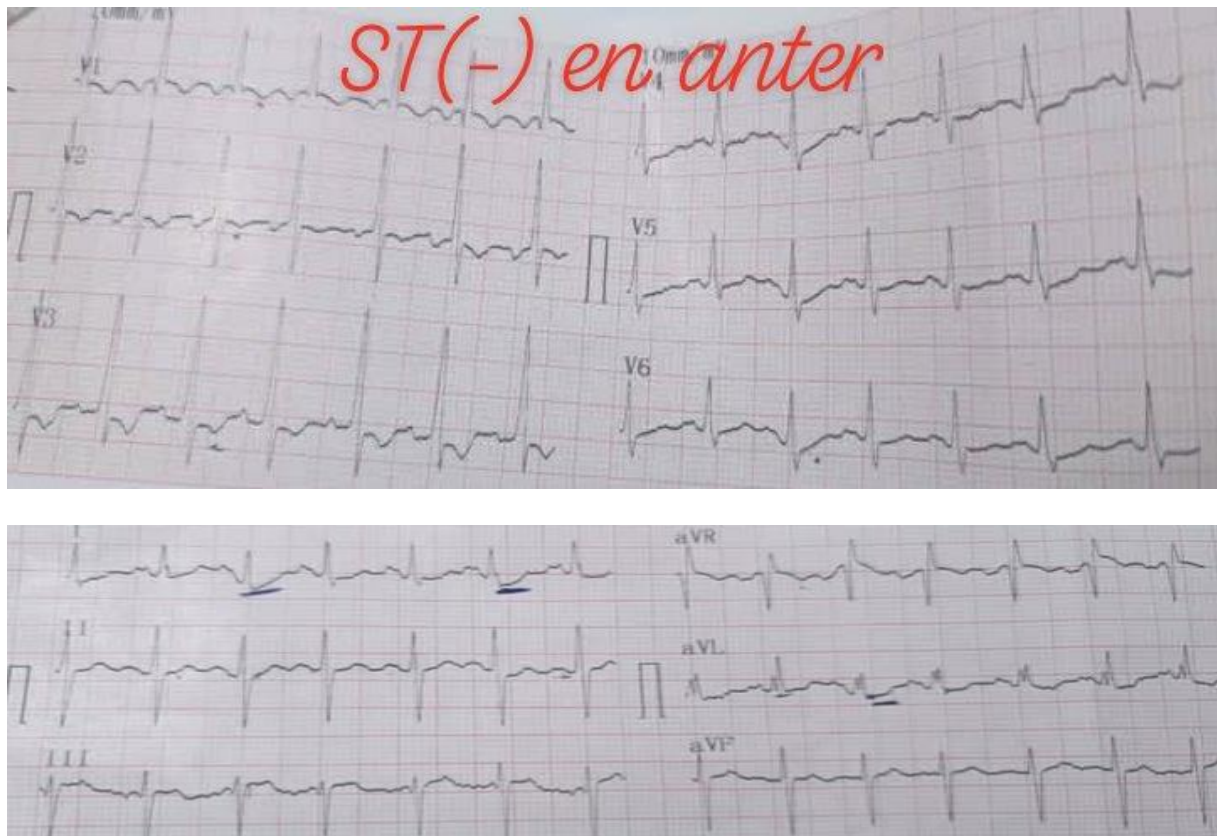
⚠ Interprétation : **Tachycardie sinusale**



⚠ Interprétation : **Tachycardie**
Supraventriculaire TSV

⇒ Ondes P non visibles

- Manœuvre vagale
- Traitement Bétabloquant



● Patiente de 58ans

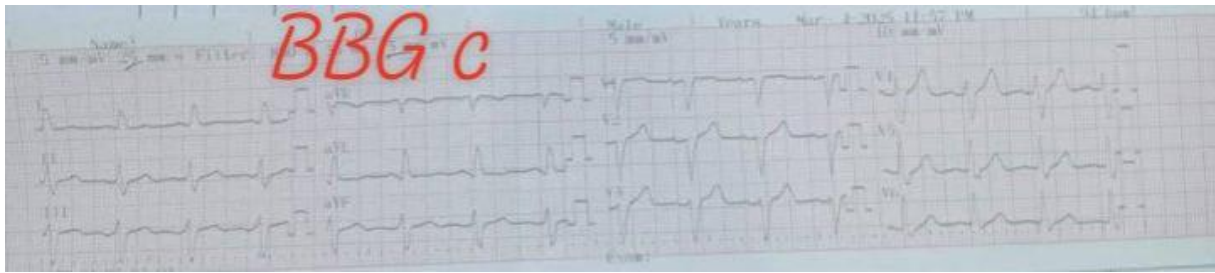
ATCD :cardiopathie non suivie et non documentée, présente des précordialgies

SaO₂:72, Ta: 120/80, Gly: 3g

⚠ Interprétation: **Sous décalage de ST en antérieur**

=> Faire les dérivations postérieurs V7V8V9

■ Dosage des troponines



● Patient âgé hypertendu

Douleur thoracique

⚠ Interprétation: **BBG complet**

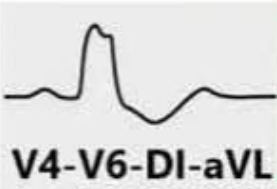
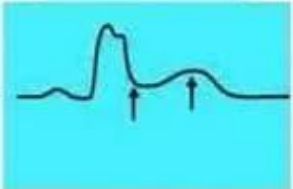
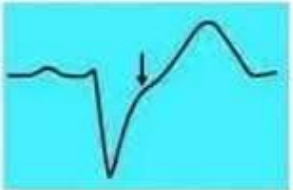
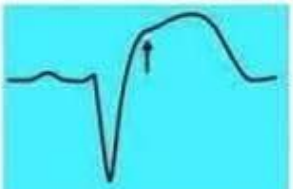
Faut le comparer avec un ECG ancien

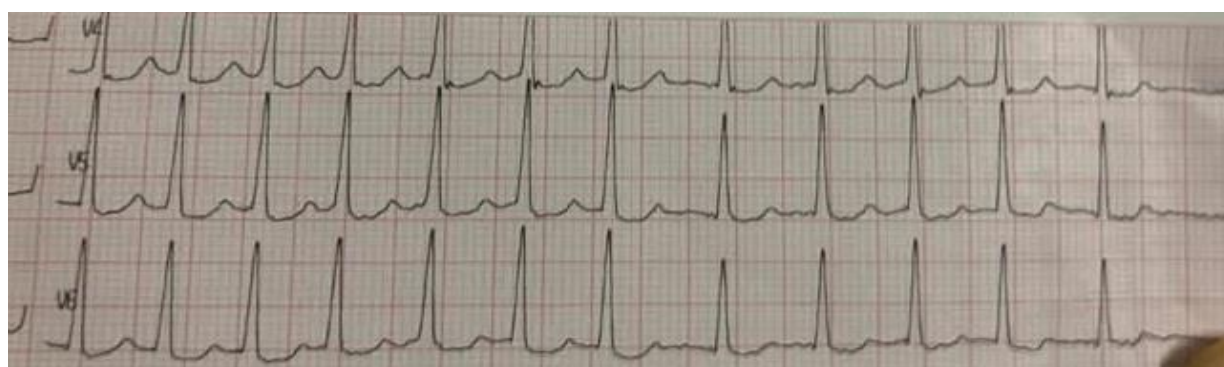
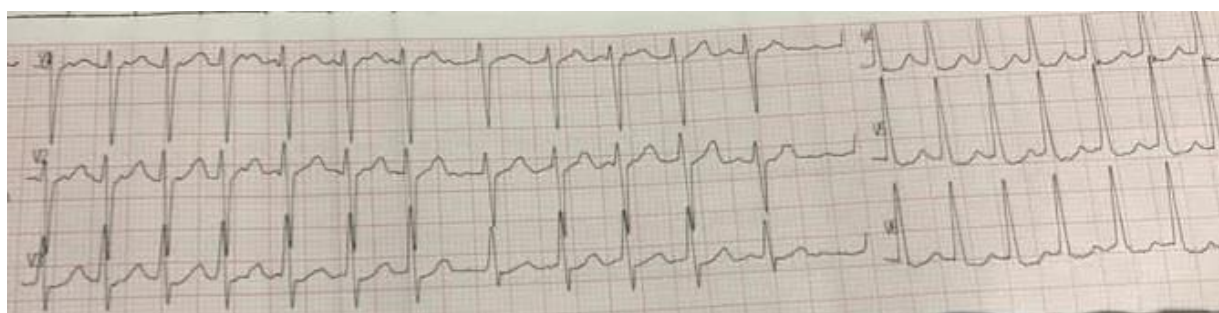
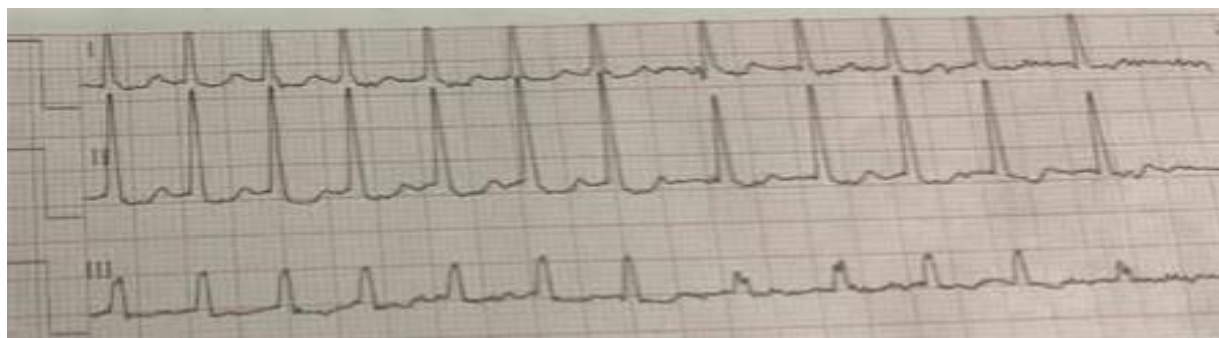
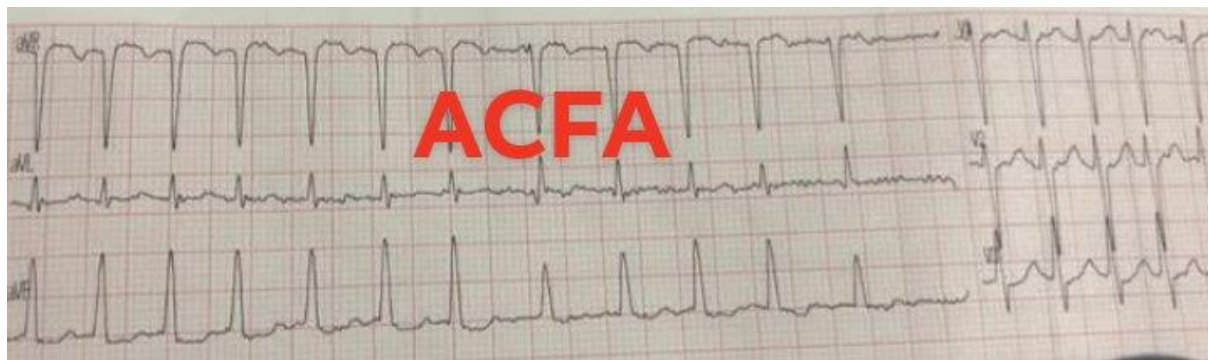
⊖ Si non toute BBG de novo = IDM jusqu'au
preuve du contraire

■ Les blocs de branches soit droite ou gauche
généralement cachent les IDM, donc dosage
des troponines et une comparaison avec des
résultats anciennes s'il existent + Ionogramme
(sus décalage, hyperkaliémie: onde T ample)

■ **Les critères de Sgarbossa** (absence dans ve cas) en cas de suspicion d'IDM sur BBG, dans un contexte de douleur thoracique avec un tel terrain, un dosage des troponines est primordial

« Critères de Sgarbossa »

	BBG	Infarctus avec BBG
► Sus-décalage de ST ≥ 1 mm lorsque les QRS sont positifs (« concordance ») (5 points).	 V4-V6-DI-aVL	
► Sous-décalage de ST ≥ 1 mm en V1, V2 ou V3 (« concordance ») (3 points).	 V1-V3	
► Sus-décalage de ST ≥ 5 mm lorsque les QRS sont négatifs (« majoration de la discordance ») (2 points).	 V1-V3	



● Femme de 52ans, sans ATCD

Présente des palpitations

⚠ Interprétation: **ACFA**

=> Ondes P Remplacée par des trémulations +
rhythme irrégulier

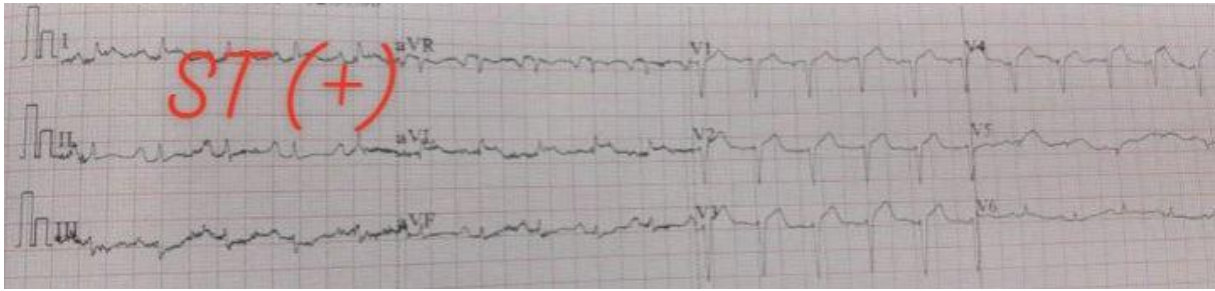
✓ CAT: Inhibiteur calcique bradycardisant en
sublingual comme Diltiazem, car il est en
tachycardie

■ Si: Stabilisation, pas d'hypotension (bien
toléré..)

➞ Orientation Cardiologie: pour instaurer un
traitement anticoagulant le plus tôt possible
(consultation cette semaine)

🚑 Si mal toléré : choc, OAP ..

➞ Avis cardiologie en urgence pour une
Cardioversion en urgence

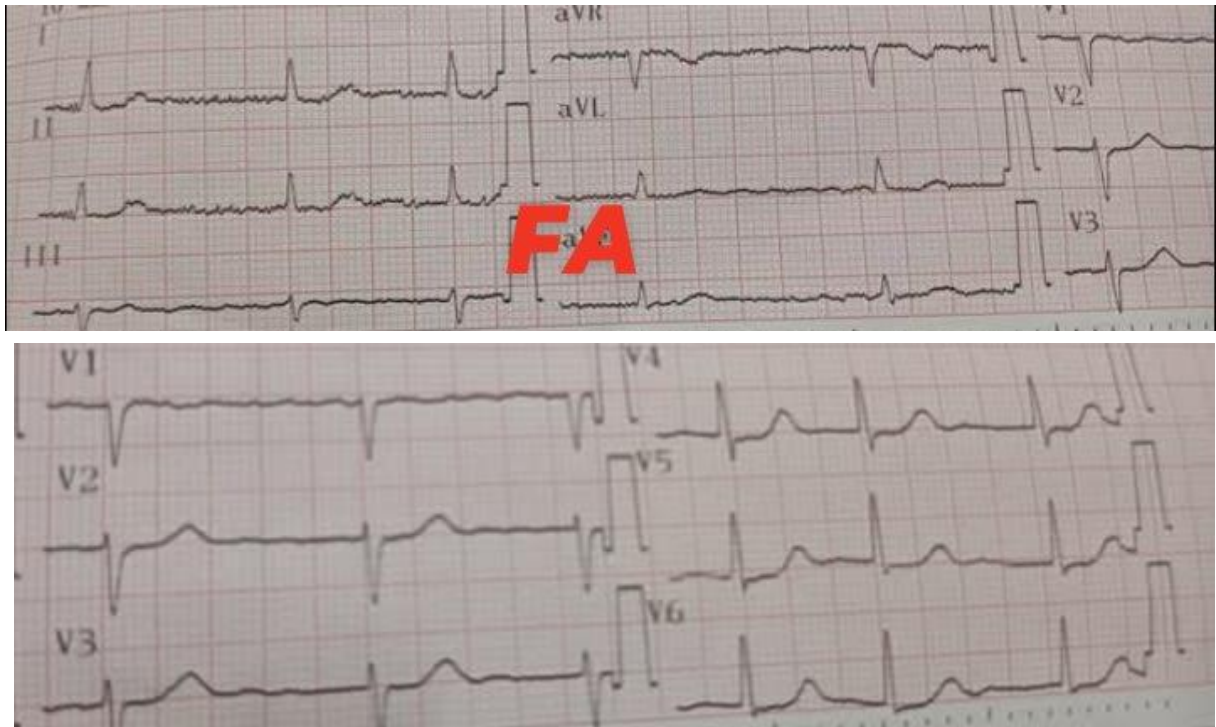


● Patient de 66ans, sans ATCD pathologiques
consulte pour douleur thoracique

⚠ Interprétation : **Sus décalage de ST (+) en
Septoapical**

+ parasitage

■ A refaire l'ECG



● Patiente 73ans, hypertendue, sous Sintrom
Présente pour précordialgies type brûlure

Ta: 13.07

⚠ Interprétation: **Fibrillation auriculaire FA**

+ Sous décalage de ST (-) en latéral bas V4V5V6

■ Refaire l'ECG + Dosage des troponines et
DDIMÈRES



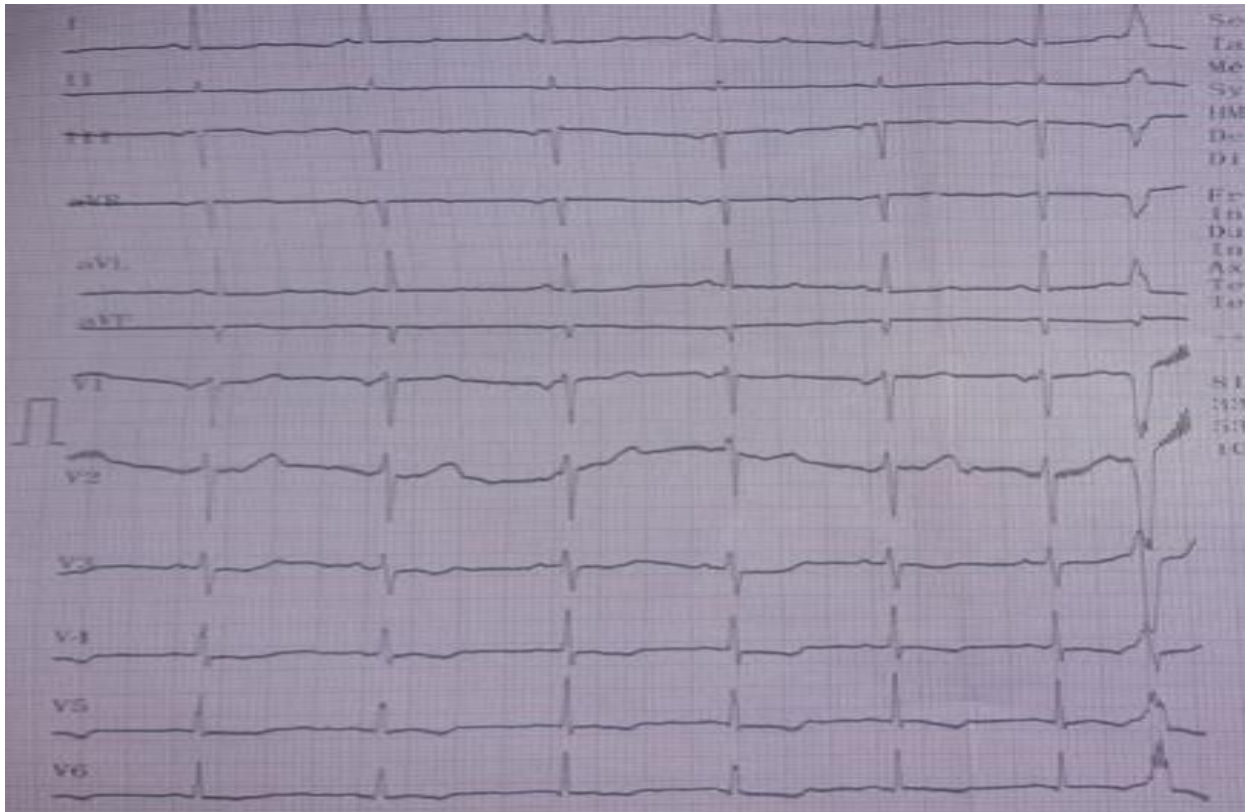
● Patiente de 53ans, aux ATCD HTA,
Cardiopathie sous Sintrom

Consulte pour des Vertiges suite à une chute
sur le sol, douleur thoracique

SaO₂: 99%, Fc: 75

⚠ Interprétation: **BAV 1er degré, PR>5mm**

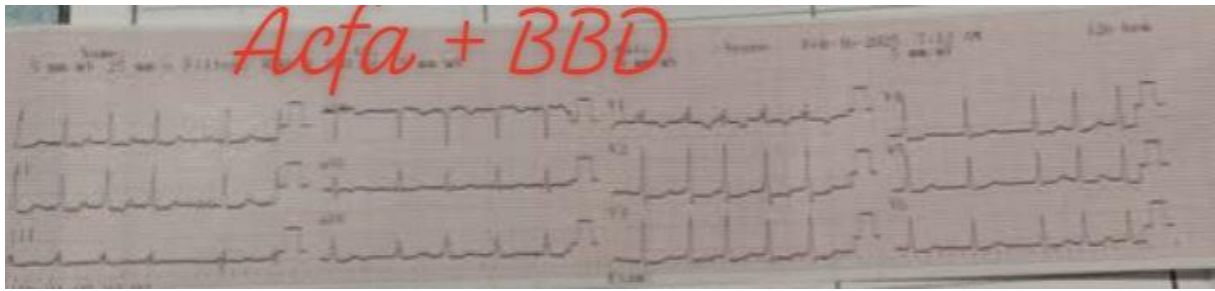
■ Bilan: TP/INR



● Femme de 40ans, sans ATCD

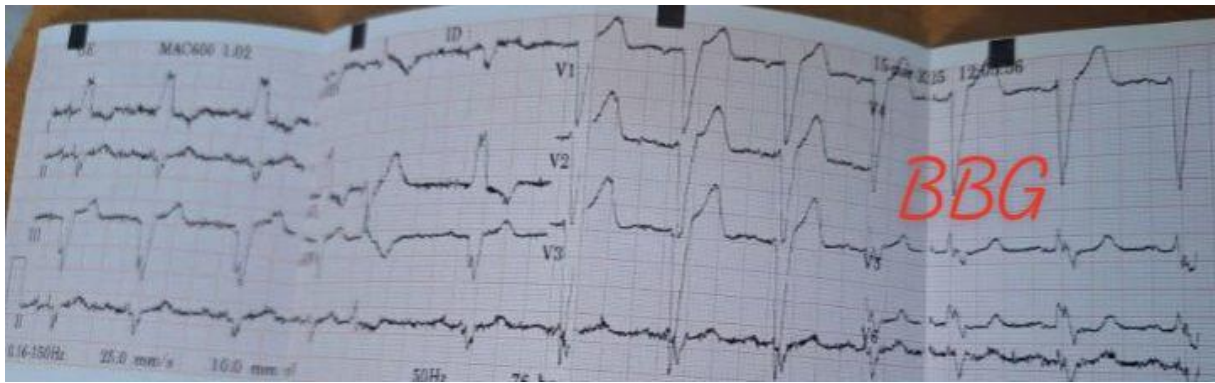
Douleur thoracique irradiant vers le bras gauche

⚠ Interprétation: **Onde T positive en V1V2 et négative** dans les autres dérivations précordiales, compléter par un dosages des troponines + Ionogramme



● Patiente de 52ans, sans ATCD particuliers

⚠ Interprétation: **ACFA + BBD**

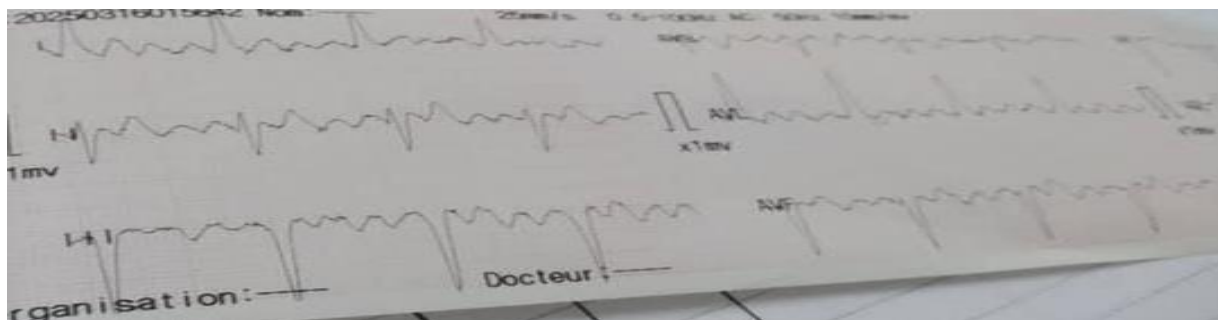
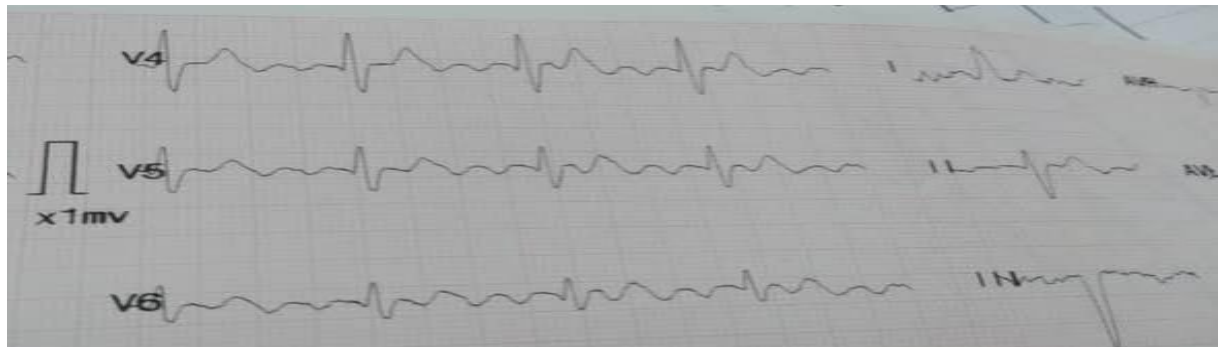
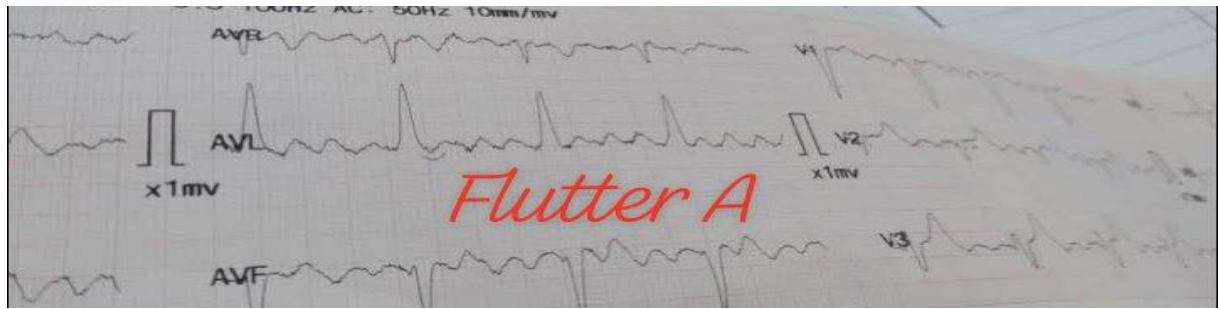


● Patient de 87ans, ATCD de goitre sous Levothyrox, hypertrophie de la prostate, cardiaque, il présente une dyspnée nocturne avec toux occasionnel, à l'auscultation souffle au foyer pulmonaire

Ta: 12/6, SaO₂: 97%, Gly: 1g

⚠ Interprétation : **BBG**

- S'il est récent peut cacher un IDM
- faut le comparer avec un ECG ancien



● Patient de 78ans qui consulte pour faiblesse depuis 48h +/- douleur thoracique et lombaire

Ta: 13/08 pour les 02 membres

Dextro : 1.45 g/dl

Fc: 80bpm

SaO2: 94 %

ATCD : HTA/Diabète/IDM : stenté en 2013/ 2015

⚠ Interprétation: **Flutter Atrial**

- Ondes P Remplacées par des trémulations

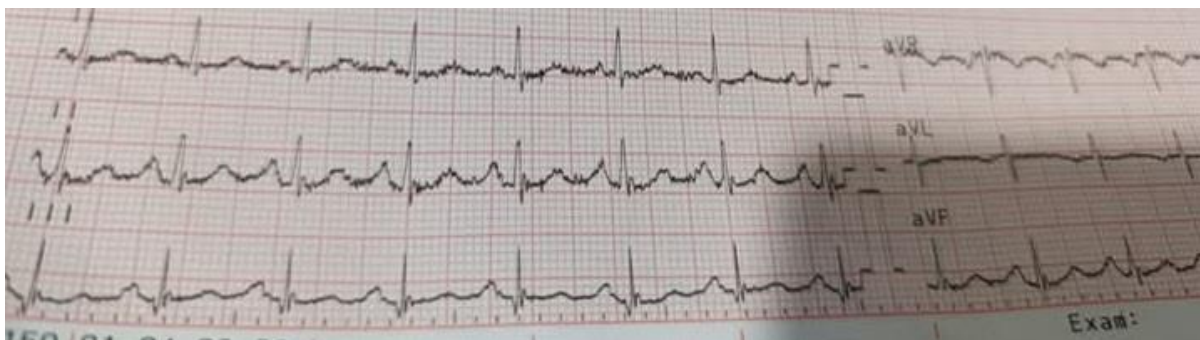
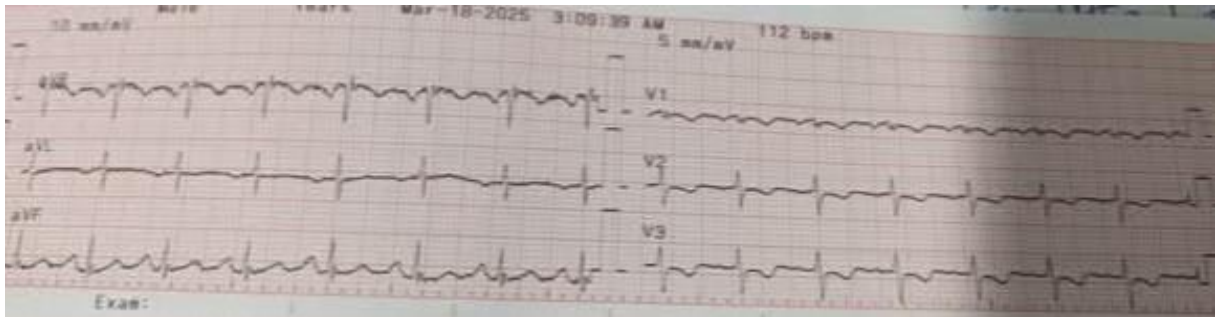
Rythme régulier

- Comparer avec un ECG ancien

- Dosage des troponines pour éliminer un NSTEMI

- Ionogramme

- Bilan complet

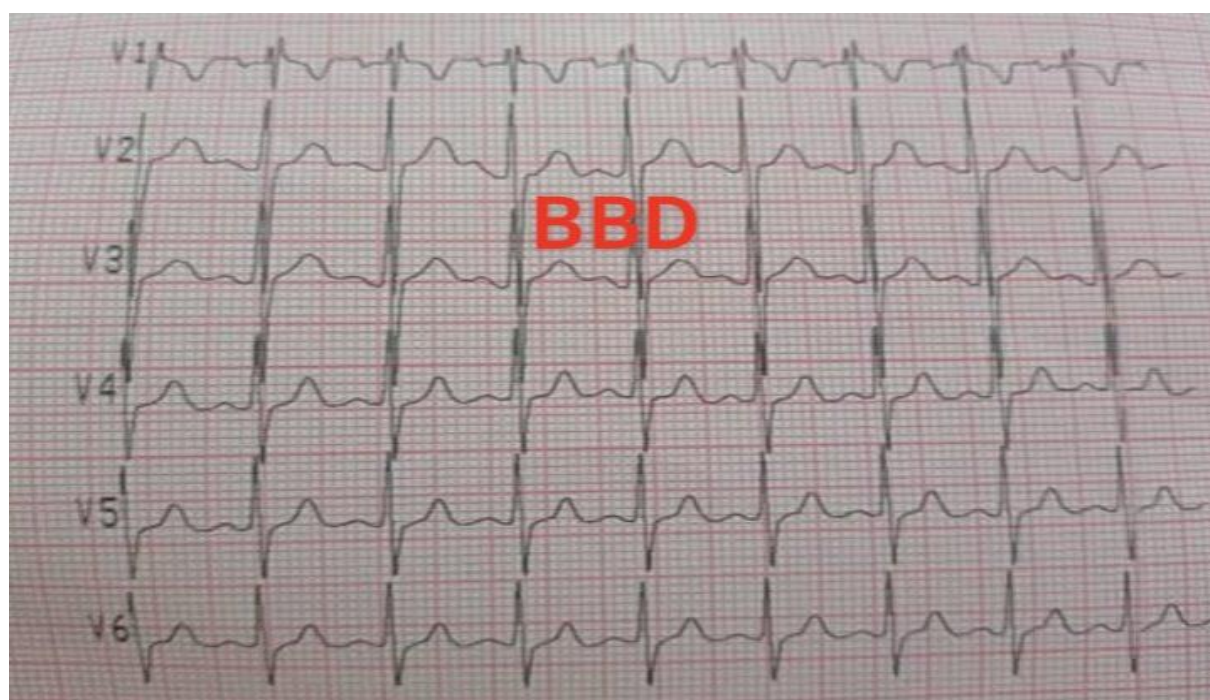
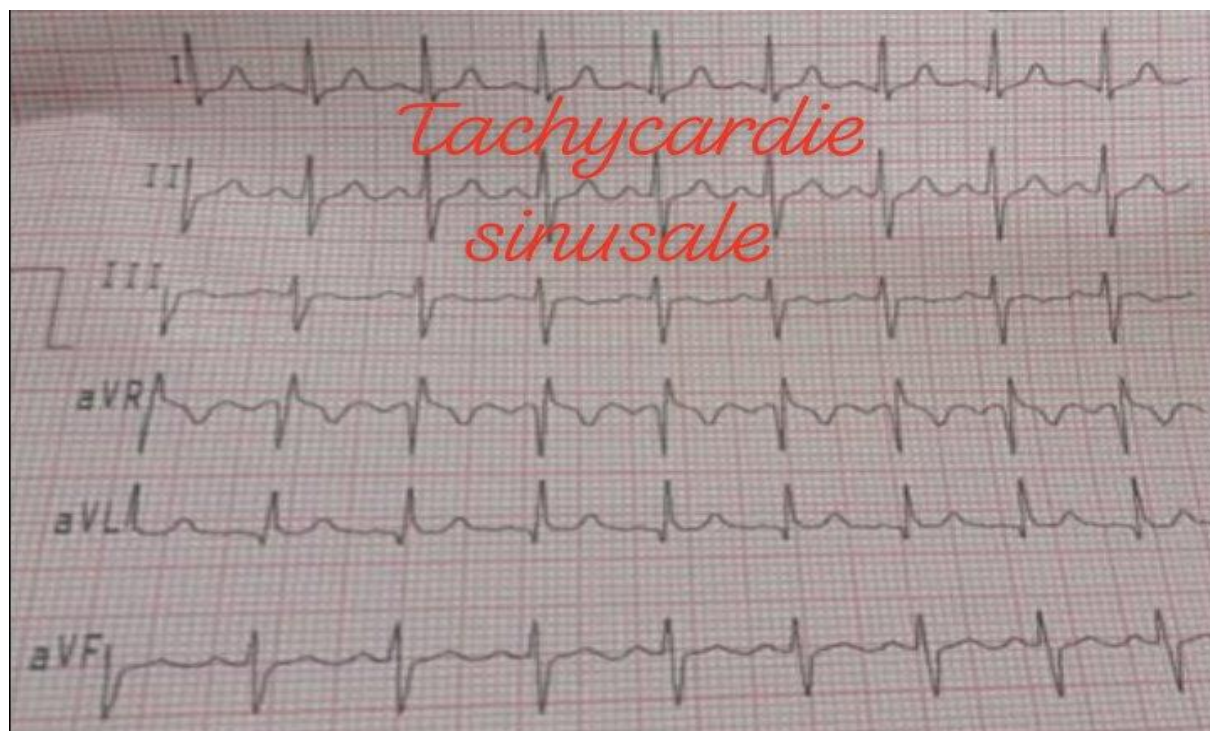


● Patient consulte pour une asthénie et des épigastralgie minime, d'ATCD d'HTA

Ta: normal.

⚠ Interprétation: **Sous décalage de ST en V1V2V3V4**

- Faire les dérivations postérieurs à la recherche d'un STEMI
- Troponines pour éliminer un NSTEMI



● Enfant de 11ans, d'ATCD d'épilepsie

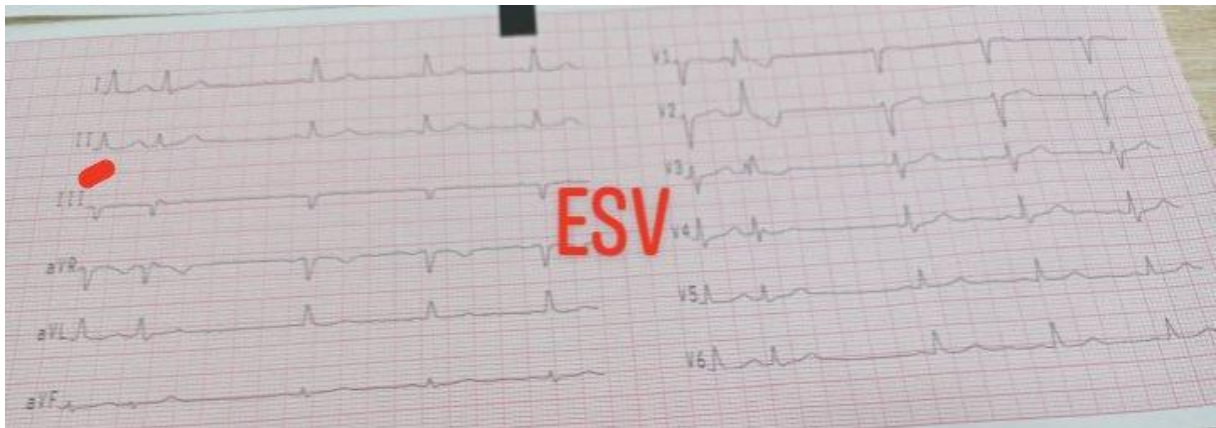
Fc: 140

Motif: palpitation et asthénie

⚠ Interprétation: **Tachycardie sinusale**
+ BBD physiologique

■ Faut ☐ la Fc puis refaire l'ECG: O2 + Mg

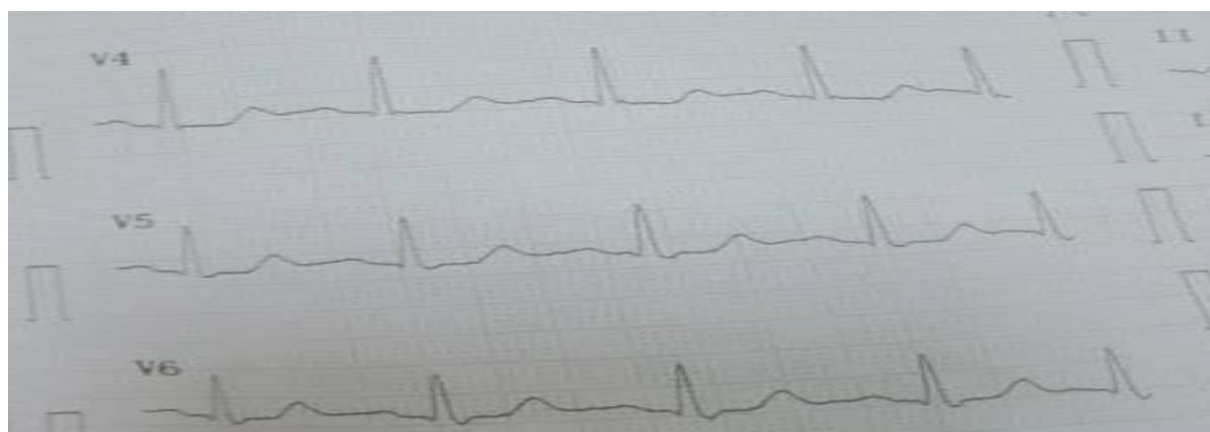
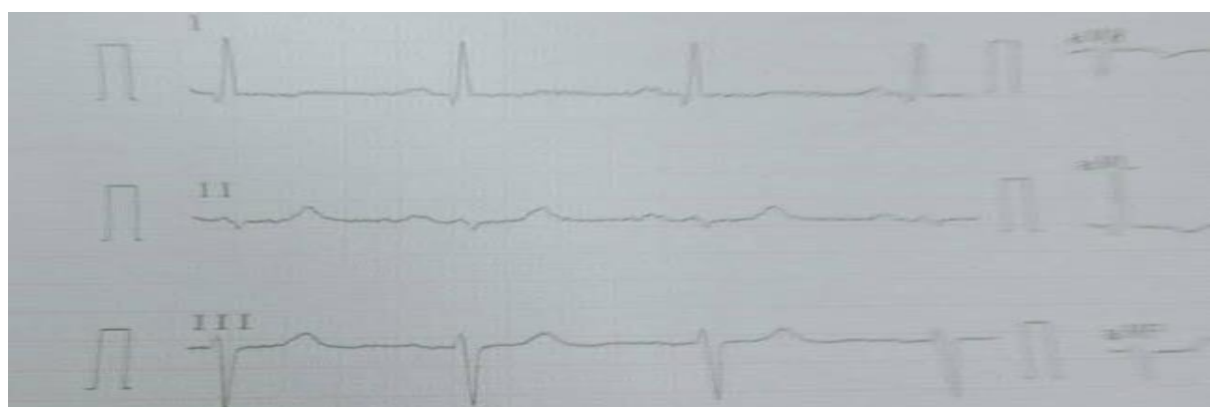
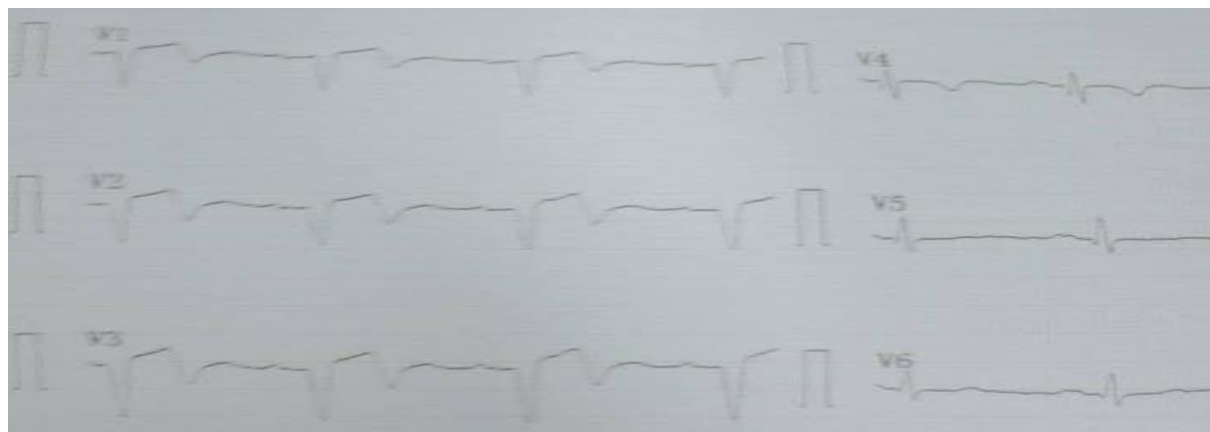
FNS



● Femme 68ans, Hypertendue

⚠ Interprétation : **ESV**

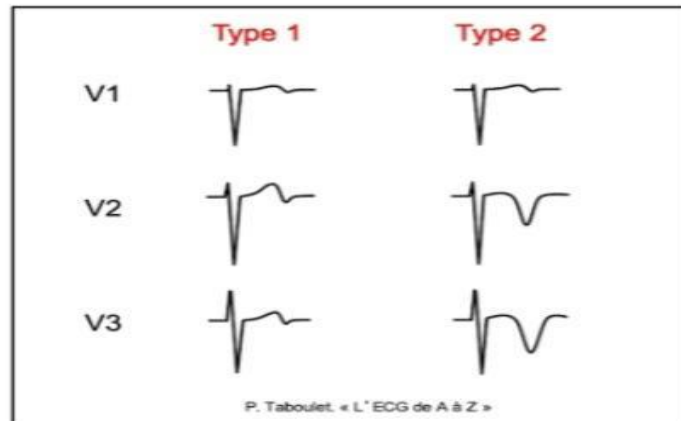
■ Faire un DII long



Syndrome de Wellens

(« syndrome de l'IVA »)

Inversion terminale de T en **V2-V3(V4)** = ischémie sous-épicaudique (**type 1**)
évoluant vers une inversion profonde des ondes T (**type 2**)
en dehors d'un épisode douloureux, sans anomalie des QRS (forme typique)



● Patient de 70ans, sans ATCD

Consulte pour des épigastralgies aiguës

Ta : 160/80

⚠ Interprétation : **STEMI en antéro-septal**
V1V2V3

■ Faire les dérivations postérieures V7V8V9

Ou

Syndrome de Wellens :

■ C'est l'équivalent d'un syndrome coronarien (manifestation de la sténose de l'IVA) .

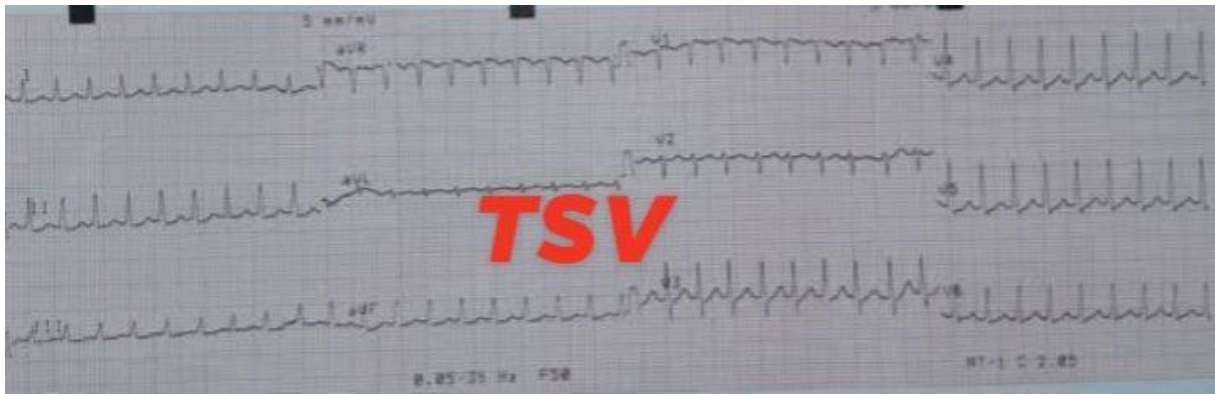
Électriquement y a 2 manifestations :

■ Type 1 : ondes T biphasiques en V1V2V3

■ Type 2 : ondes T négatives (les mêmes dérivations sus_citées)

✓ CAT :

■ On le traite comme un NSTEMI avec une coronarographie dans les plus brefs délais



● Patient âgé de 46ans, consulte pour palpitations, grand fumeur

⚠ Interprétation: **Tachycardie Supraventriculaire TSV**

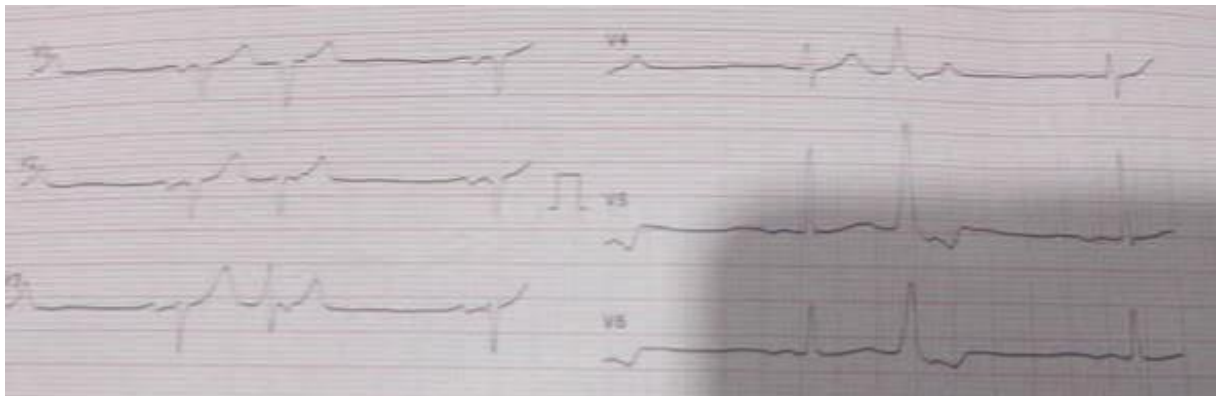
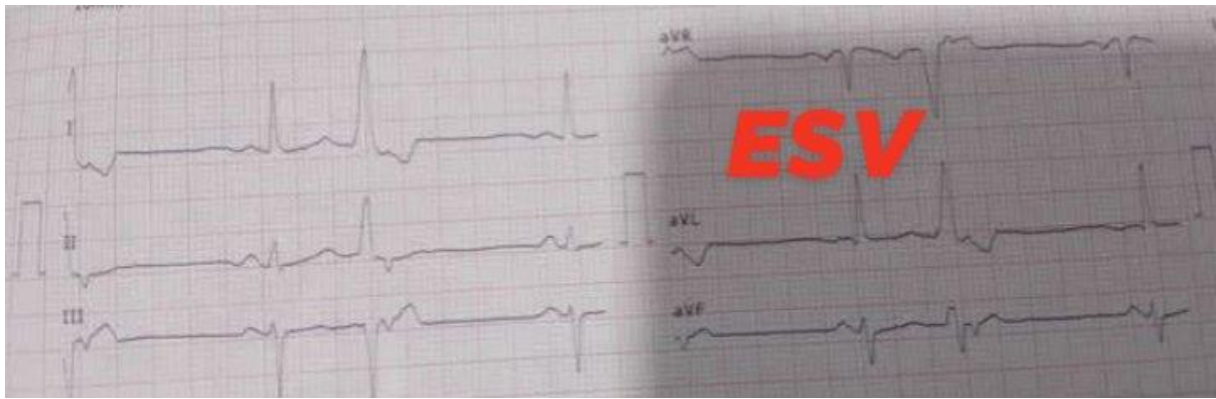
■ Tachycardie + absence d'onde P + rythme régulier



● Patient sous Flecaine depuis 2ans

Consulte pour malaise et palpitations

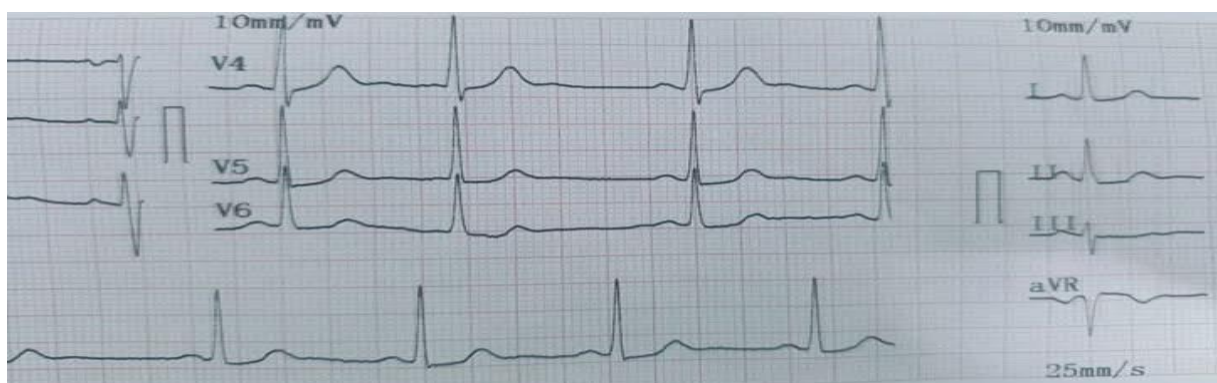
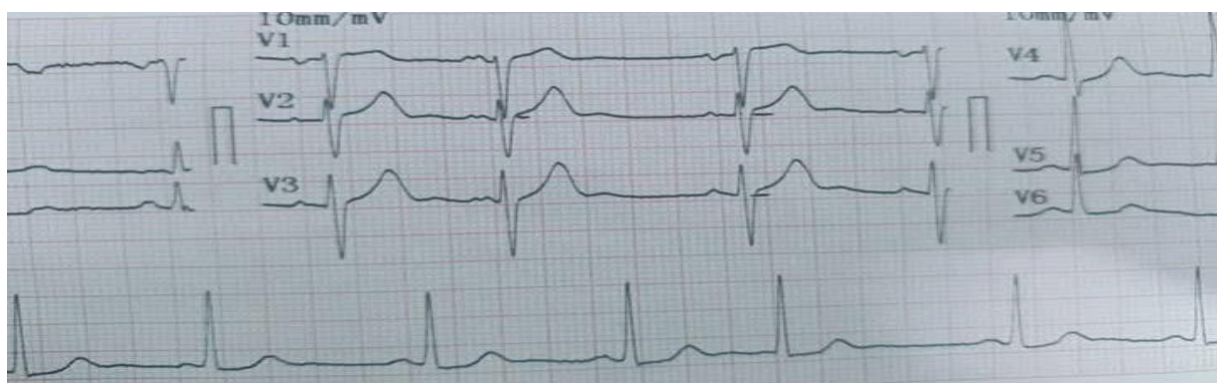
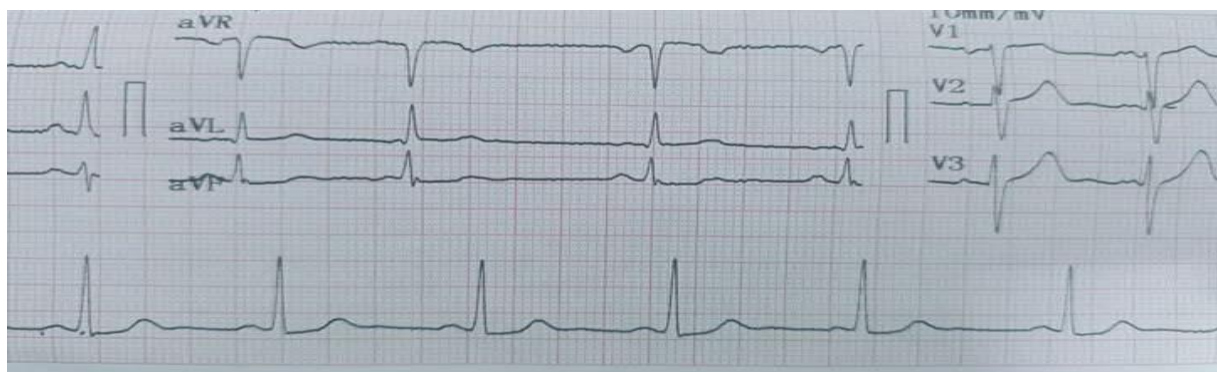
⚠ Interprétation : **ACFA**



● Épigastalgies

Ta : 16/8

⚠ Interprétation: **Extrasystoles ESV**



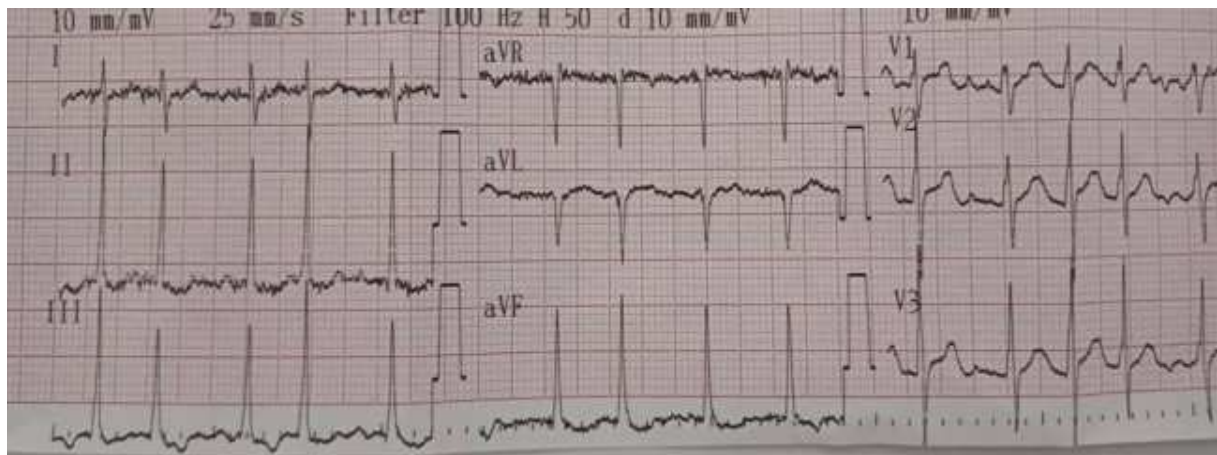
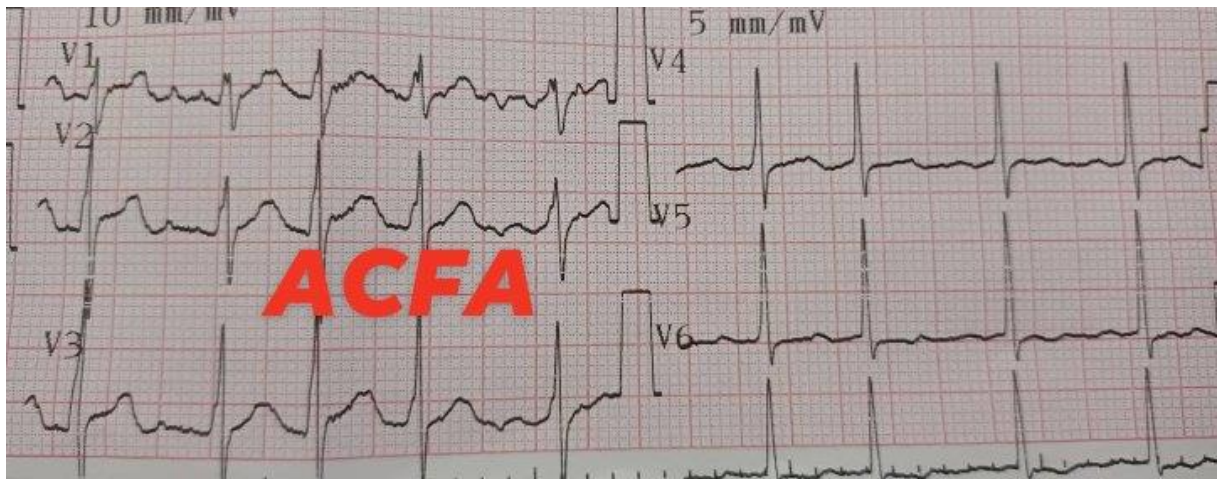
● Femme 54ans , consulte pour fièvre à 39.1 et douleur abdominale

gorge : angine

auscultation: normal

TA: 150/90

⚠ Interprétation: **ESA**



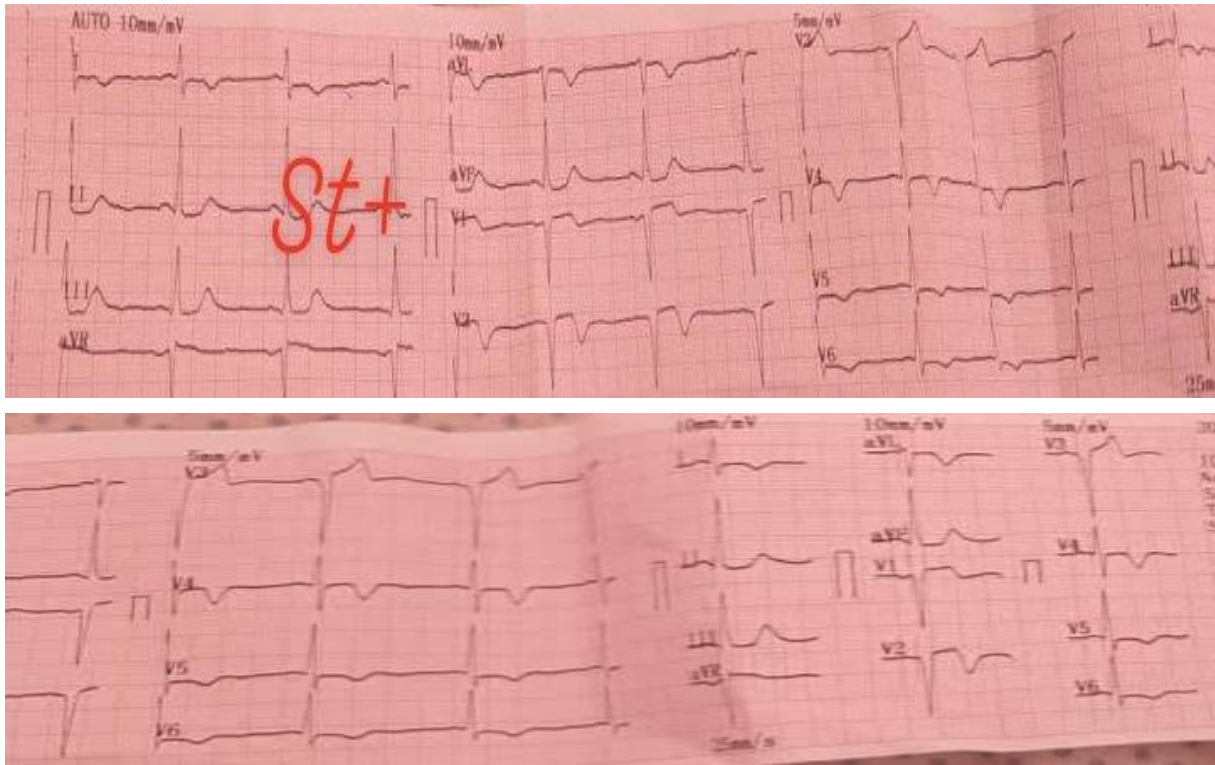
● Patient de 52ans sous Sintrom

Il se présente pour des palpitations et douleurs thoraciques

Ta: 16/11

⚠ Interprétation: **ACFA**

- Palpitations sont à cause de l'ACFA et la Tachycardie
- Eliminer une ACFA mal tolérée (choc, OAP, AEG..)
- Orientation vers son cardiologue pour ajustement de traitement (si les palpitations sont très gênantes => Diltiazem en sub lingual sur place)
- Troponine pour éliminer une NSTEMI (douleur thoracique)
- O2 thérapie + 1/2 amp Mg diluée dans 200cc SG5% puis refaire ECG



● Patient sans ATCD consulte pour des précordialgies

⚠ Interprétation: **STEMI** jusqu'à preuve de contraire

- Sus décalage en V1V2V3 (mais pas significatif en V2V3 1mm)
- Image en miroir en inférieur
- Onde Q de nécrose V1V2V3



⚠ Interprétation : **ACFA**

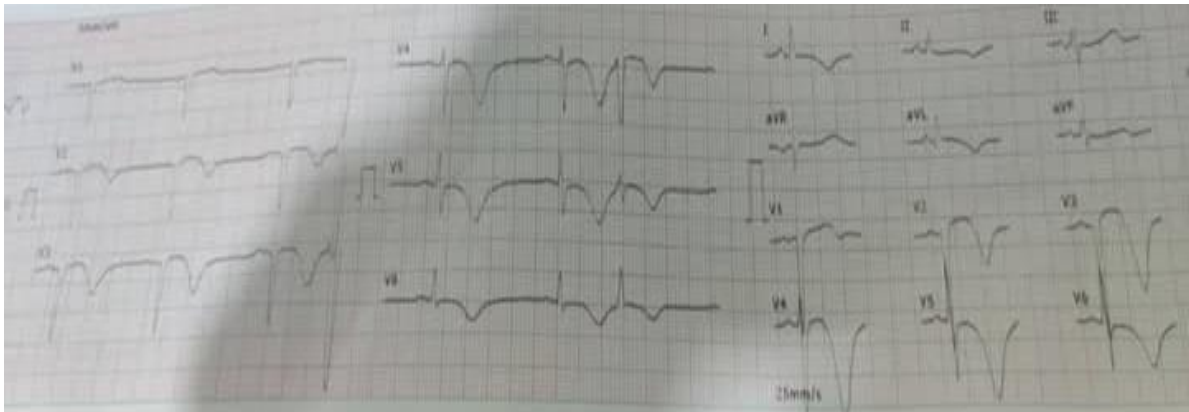
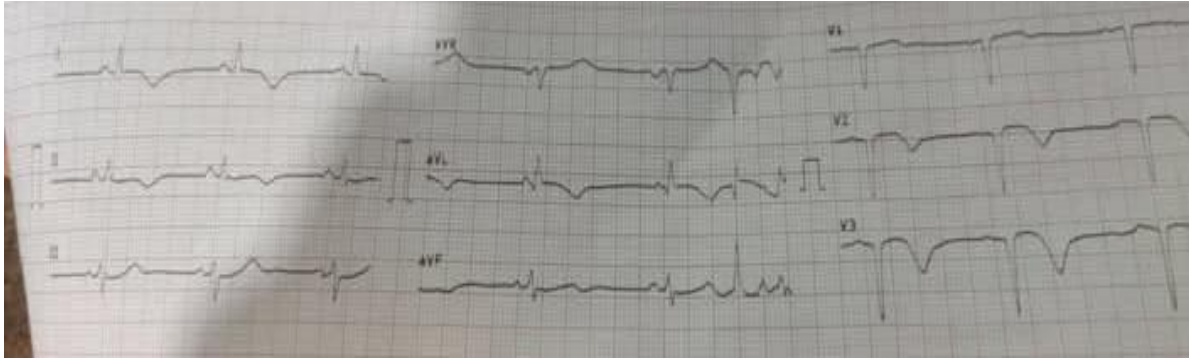
- Absence d'onde P
- Trémulations de ligne de base
- Rythme cardiaque irrégulier



● Patiente âgée de 43ans, sans ATCD

Consulte pour une asthénie avec une sensation de bouffée de chaleur

⚠ Interprétation : **ACFA**



● Patient âgé de 69ans, HTA connue

Ta: 17/10

Il consulte pour des précordialgies

⚠ Interprétation: **Troubles de repolarisation**
T(-)

■ ST(-) diffus (peut-être NSTEMI comme peut-être une hypokaliémie) avec des T(-) très profondes en antérieur [Wellens syndrome] et

ondes Q de nécrose en V1V2V3 (STEMI hors délai)

- Diagnostic probable: un syndrome de Wellens avec une Hypokaliémie

STEMI en antérieur hors délai

✓ CAT :

- Mise en condition / Scope

- Ionogramme

- Bilan rénal

- Dosage des troponines

- Dose de charge : 4cp Plavix, 3cp Aspegic et Lovenox en Sc selon le poids

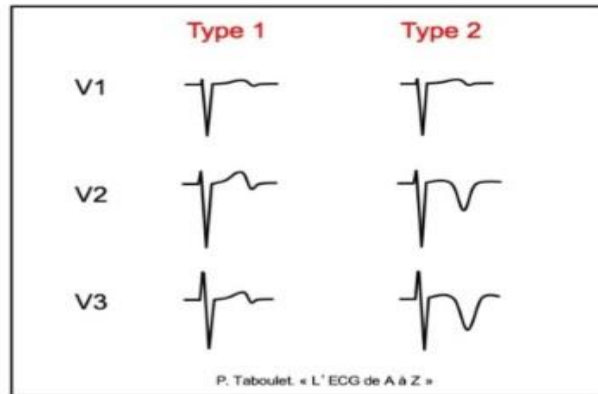
⊖ On ne thrombolyse pas le NSTEMI

→ Coronarographie

Syndrome de Wellens

(« syndrome de l'IVA »)

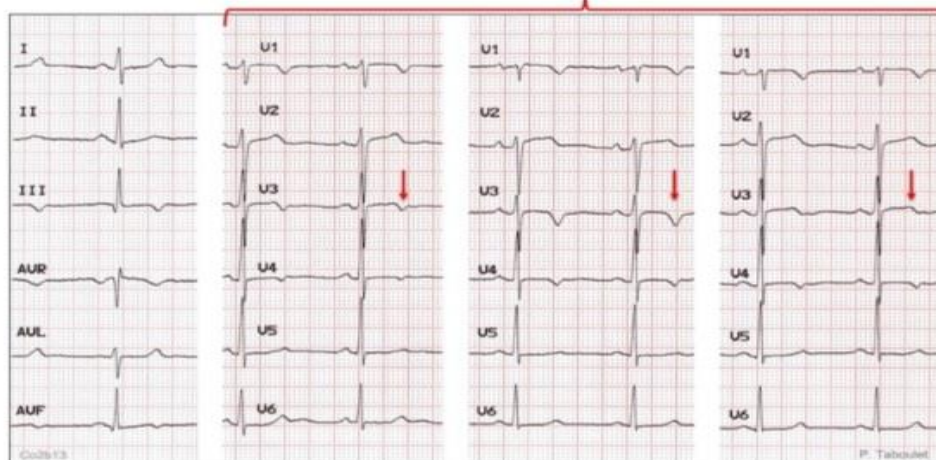
Inversion terminale de T en V2-V3(V4) = ischémie sous-épocardique (**type 1**)
 évoluant vers une inversion profonde des ondes T (**type 2**)
 en dehors d'un épisode douloureux, sans anomalie des QRS (forme typique)

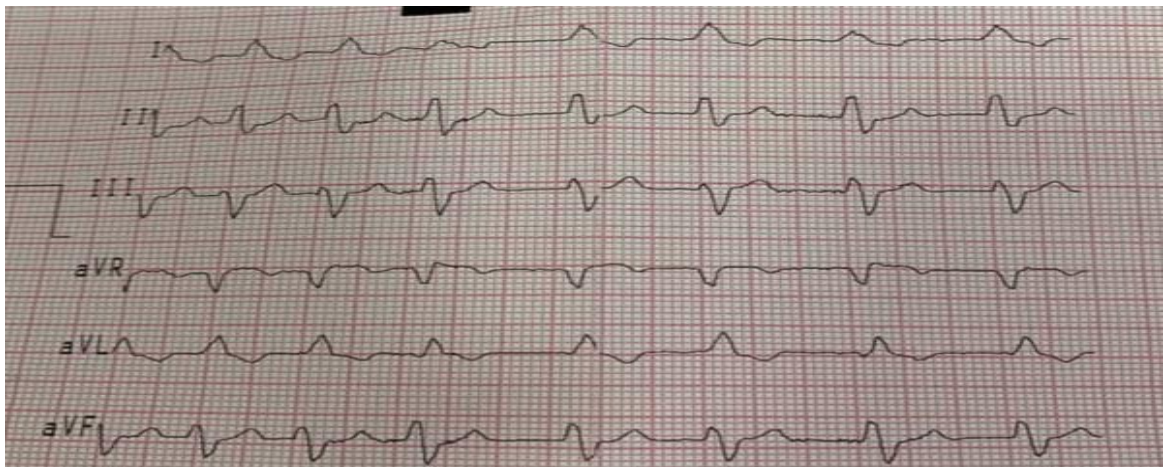


Syndrome de Wellens

(« syndrome de l'IVA »)

Fluctuation de l'onde T en V2-V4 en rapport avec une IVA occluse





● Patient d'ATCD d'HTA et cardiopathie, venu en dyspnée SaO₂ 89%

Ta: 7/5

TLT : OAP

⚠ Interprétation: **BBG + ACFA**

- SCA ST+ (masqué par un BBG), compliqué d'un OAP cardiogénique
- Cardiopathie décompensée

☒ CAT:

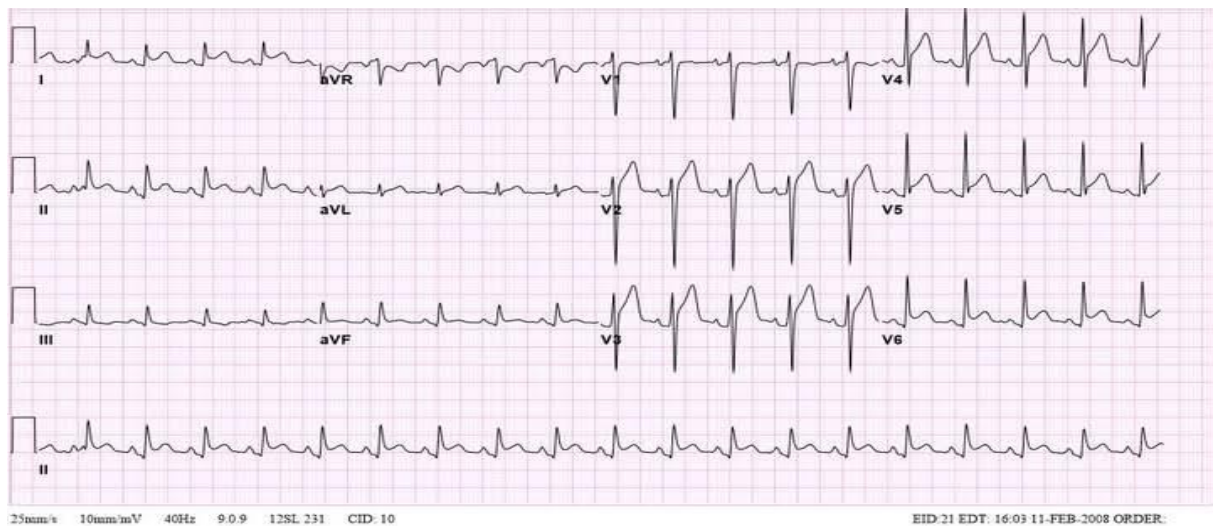
- Position demi assise/2VVP/O2/Scope
- Sonde urinaire
- Perfalgan en IVL
- Dosage des Troponines

■ Bilan: 

■ FNS / Gly

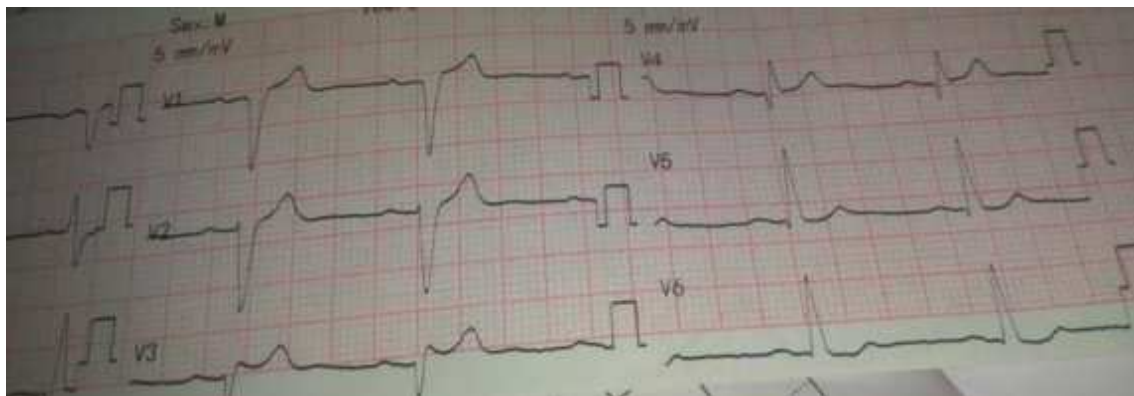
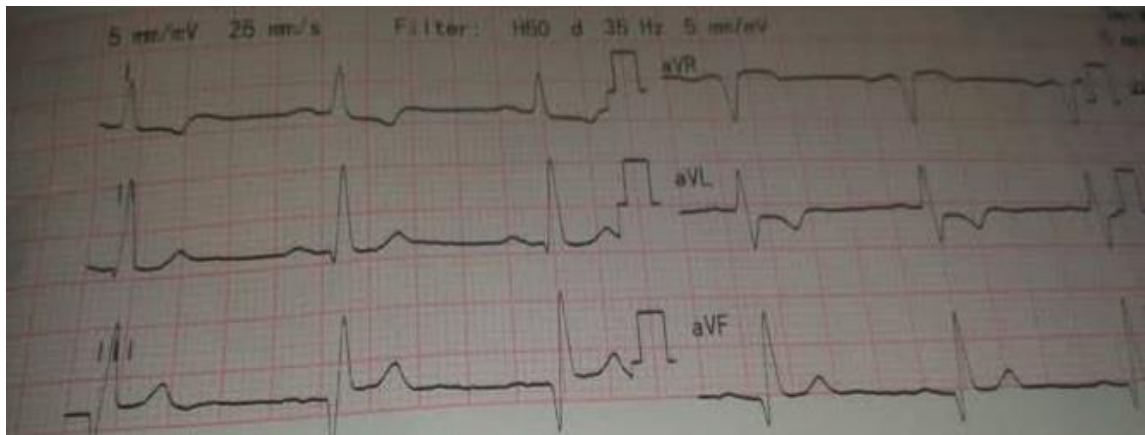
■ CRP

☐ → Évacuation en urgence



⚠ Interprétation: **Sus décalage en antéro
sptale et latéral**

■ Image en miroir en V1



● Patient 79ans, ATCD d'HTA, diabète et cardiopathie

Consulte pour une douleur thoracique

⚠ Interprétation : **ST(+) antéro septo apical**

- Image en miroir en latéral haut
- Onde Q de nécrose en inférieur

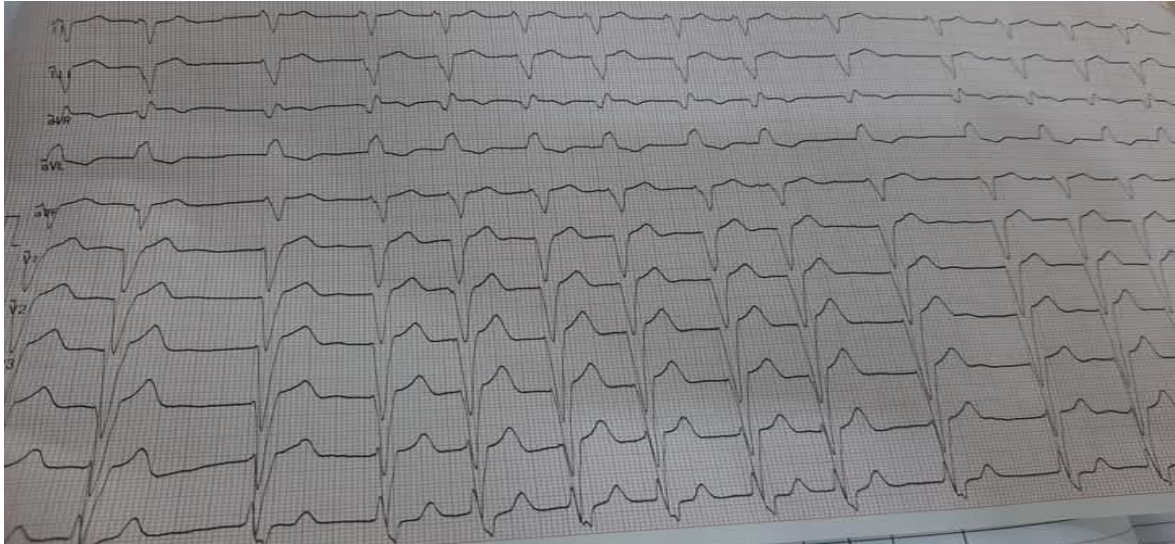
- Dose de charge Plavix Aspebic et Lovenox

Antalgique

- Monitoring

- Bilan d'urgence

→ Avis cardiologie



● Patient âgé de 67ans aux ATCD d'HTA et cardiopathie non documentée

Consulte pour une dyspnée et toux sèche

Ta : 18/11

SaO2 : 95

Fc : 99

⚠ Interprétation: **BBG + ACFA**

■ Rythme irrégulier sans ondes P avec des QRS larges de retard gauche

✓ CAT :

■ Surveillance de Ta/SaO₂/AVS/O₂

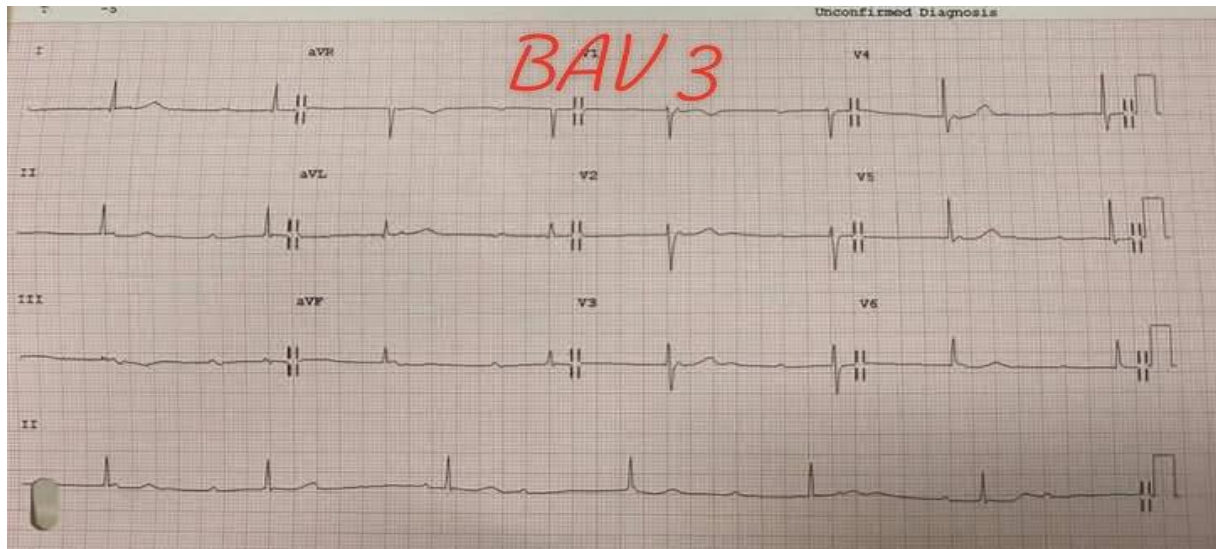
■ Dosage des Troponines

■ Bilan : 

■ FNS/Gly

■ Urée/Créat

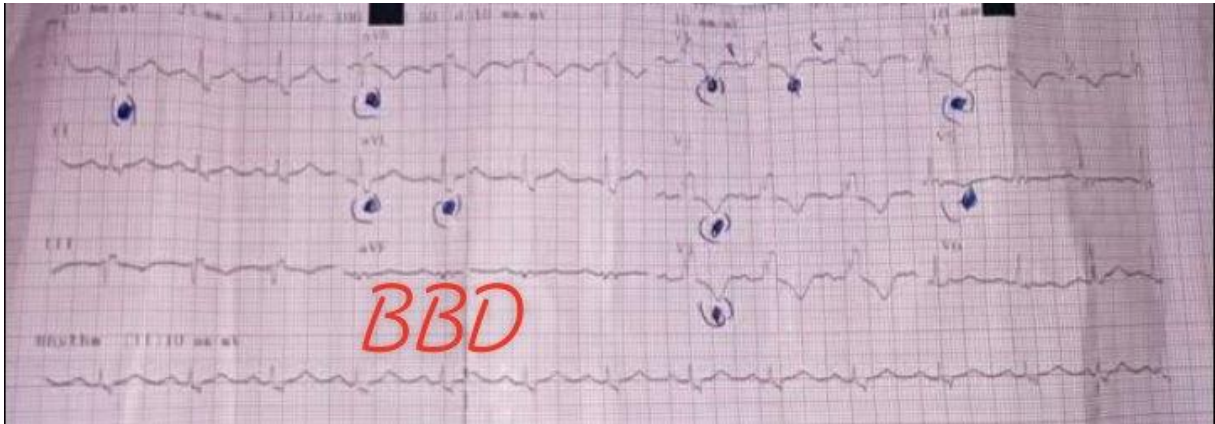
→ Evacuation



● Un sujet âgé qui consulte pour des vertiges

⚠ Interprétation: **BAV 3eme degré**

- P dissocié du QRS
- PP intervalle régulier
- RR intervalle régulier



● Patiente présente épigastralgies

Cardiopathie non suivie

⚠ Interprétation: **BBD complet**

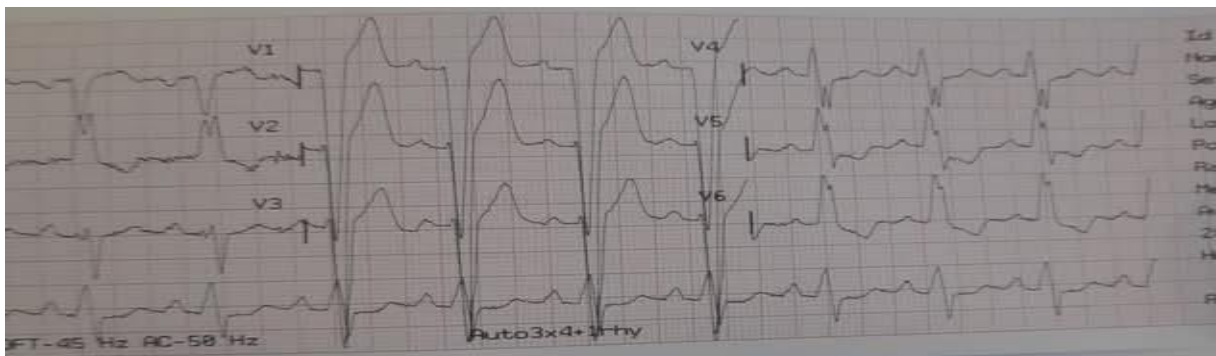
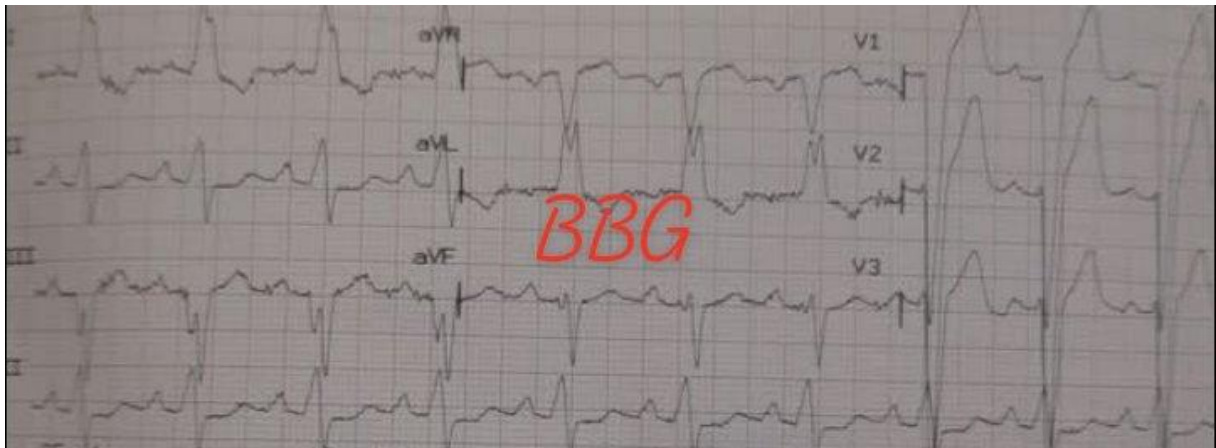
- QRS large, aspect RR' en V1 V2, et onde S trainante en V5V6 et D2 AVL

- Bilan complet

- Troponines

- DDIMÈRES

- Si RAS cela veut dire que c'est un trouble conducteur lié à sa cardiopathie



● Patient 60ans ATCD d'IDM ça fait 3ans

Consulte pour une Toux productive, sueurs, asthénie depuis hier soir, Pas douleur thoracique

⚠ Interprétation: **BBG + HVG**

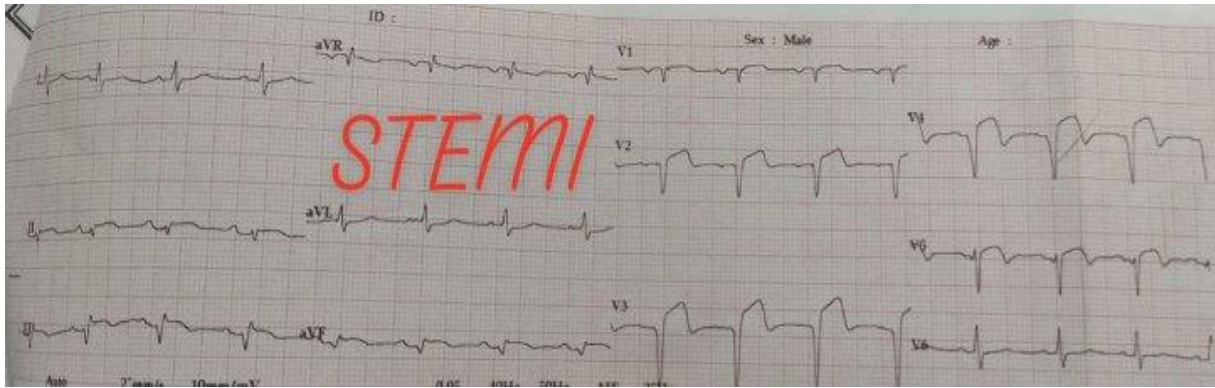
■ Bilan

■ Ionogramme

- Il y a une discordance donc on cherche un Sus
décalage de plus de 5mm en V1V2V3 pour dire
qu'il y a des signes de Sgarbossa positifs et que
notre BBG cache un SCA

- Comparaison avec un ECG antérieur, si c'est
la même image (BBG ancien) → Abstention

- S'il y a une modification → Troponines



● Malade âgé de 67ans diabétique sous ADO, mal équilibré

Le diagnostic de PFLA était posé

Le jour de contrôle patient stable avec une bonne amélioration clinique ..

Pas d'autres symptômes ni signes cliniques alarmantes..

Dextro: 2.7 il ne prend pas son traitement

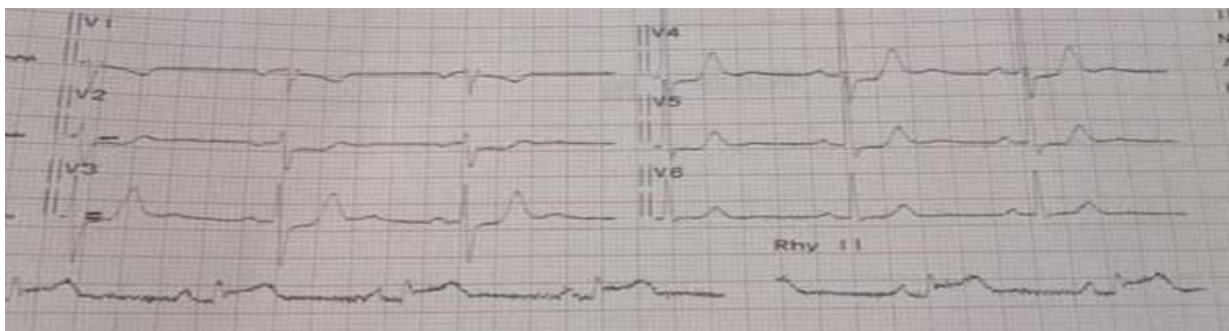
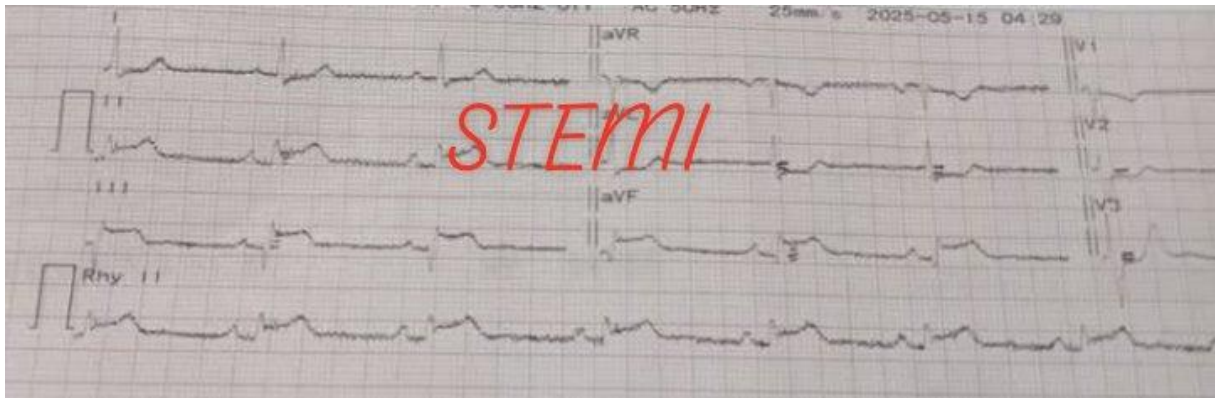
CDU: absence des CC

TA : 11/7

⚠ Interprétation: **STEM**

- Qui a passé inaperçu, y a déjà l'aspect QS (le malade à fait une nécrose)
- Dosage des troponines
- Dose de charge (Plavix + Aspegic + Lovenox)
- Hospitalisation dans un service de cardiologie
- Thrombolyse n'est pas indiquée

⊖ Chez les diabétiques → toujours demander un ECG devant une cétose ou un déséquilibre glycémique



● Patient sans ATCD, consulte pour une douleur thoracique irradiante vers le bras gauche depuis 11h du matin jusqu'à l'arrivée à 4:30h

TA: 10/06

Fc: 63btms/min Spo2: 97%

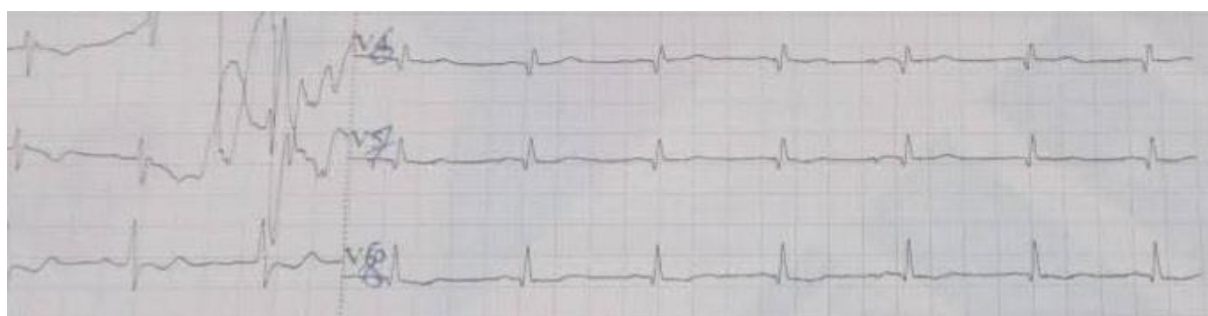
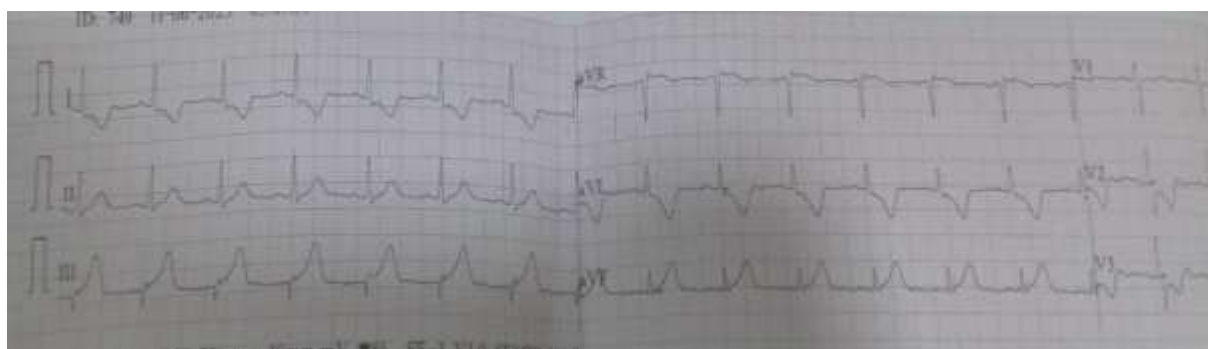
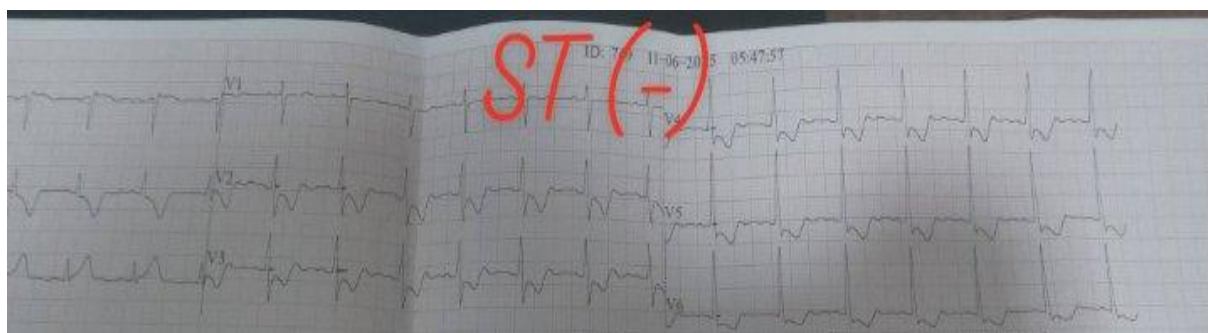
⚠ Interprétation: **STEMI inf D2D3 AVF**

Image en miroir en AVL

- Dose de charge

- Délai dépassé pour la thrombolyse(>12h)

- ☐ → Evacuation vers service cardiologie pour une angioplastie



● Patiente âgée de 40ans, Hypertendu sous traitement, qui consulte pour une douleur rétrosternale intense localisée sans irradiation, non calmée par les antalgiques

TA:140/90mmhg FC: 88bpm SaO2: 98%

Auscultation cardiopulmonaire : RAS

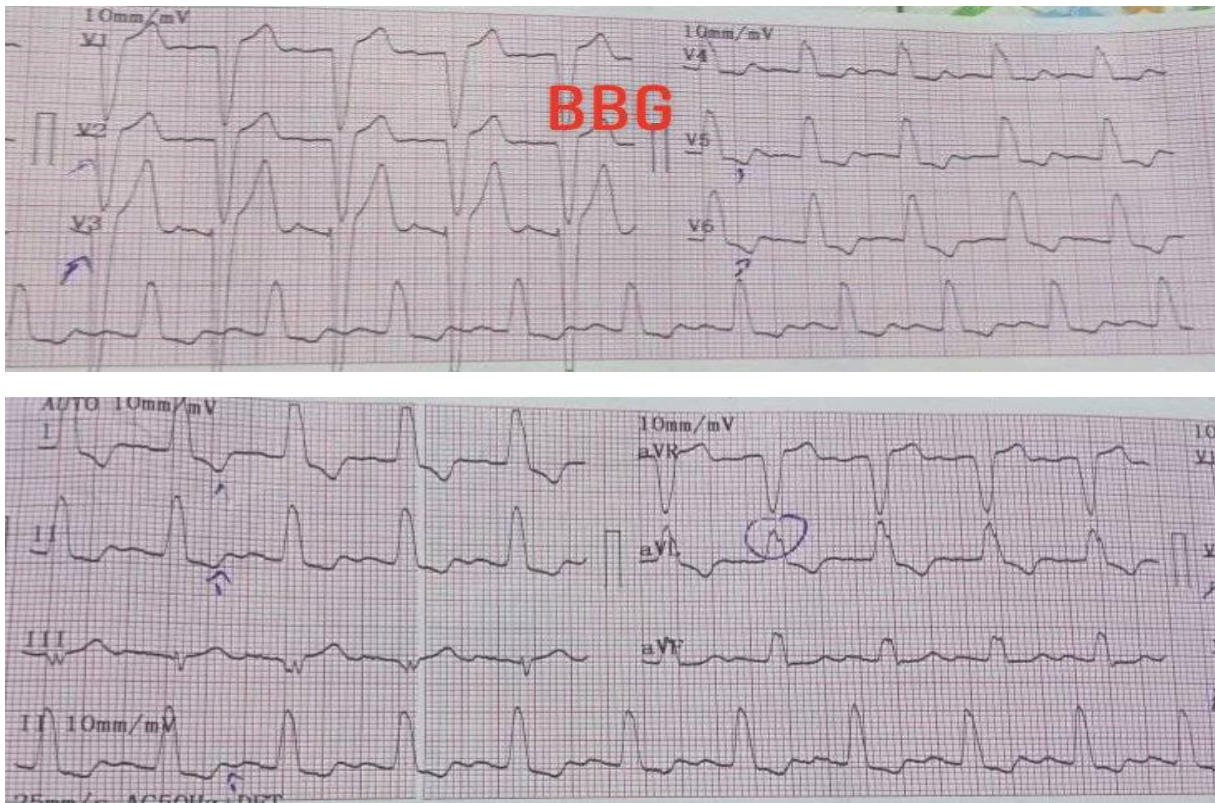
⚠ Interprétation: **ST (-)** (sous décalage en antérieur étendu + inferieur)

- Faites un ECG complet (dérivations postérieurs) à la recherche d'un sus décalage posterieur

- Dosage des Troponines

- Dose de charge (300mg de Aspegic + 4cp Plavix de 75mg) + injection Lovenox 100ui/kg ou 1mg/kg 2/j

➡ Orientation cardiologie



● Motif: Patiente âgée de 80ans , sans ATCD

Elle se présente pour des douleurs thoraciques et épigastriques

Ta: 18/09 SaO2: correcte

Auscultation: Normal

⚠ Interprétation: **BBG**

- TDR secondaires au BBG
- Comparer avec un ECG ancien (Sgarbossa)

- Troponines si douleur typique

- Traiter le pic HTA

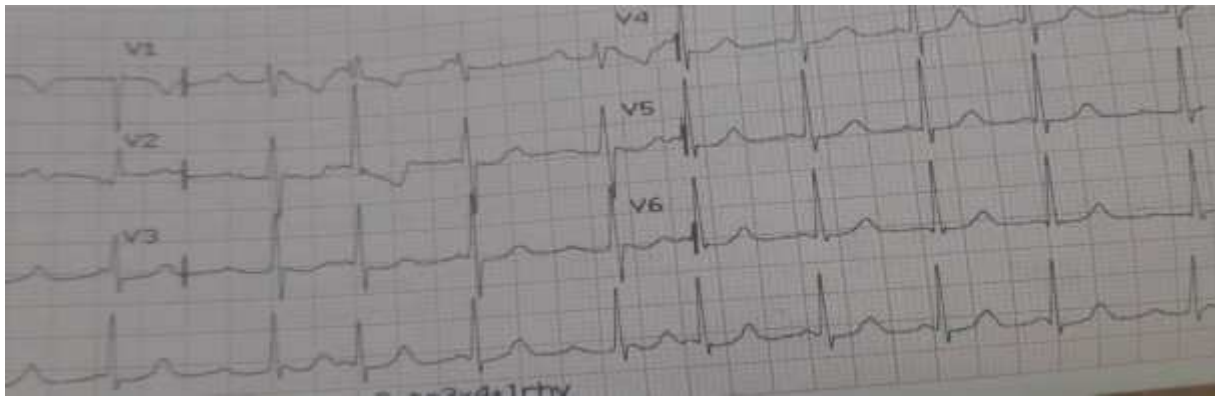
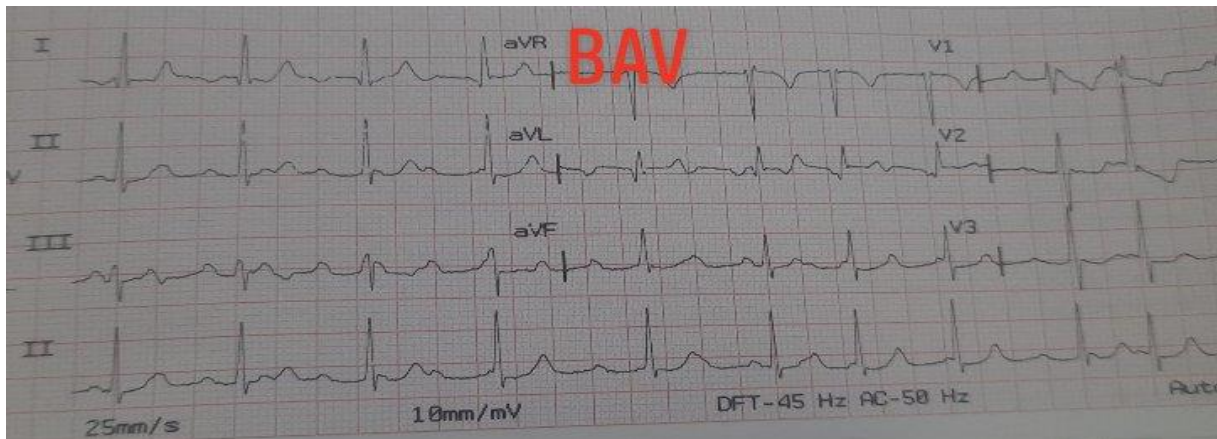
- Bilan 

- FNS

- Urée/Créat

- Ionogramme

 Orientation cardiologie



● Motif: Patiente âgée 49ans

ATCD: remplacement de la valve mitrale, sous
sintrom

Présente pour palpitations et douleur légère
thoracique

⚠ Interprétation: **BAV III**

■ Soulager la douleur: Perfalgan

■ Mg 1amp diluée dans 250cc SG5

■ Bilan 

■ FNS

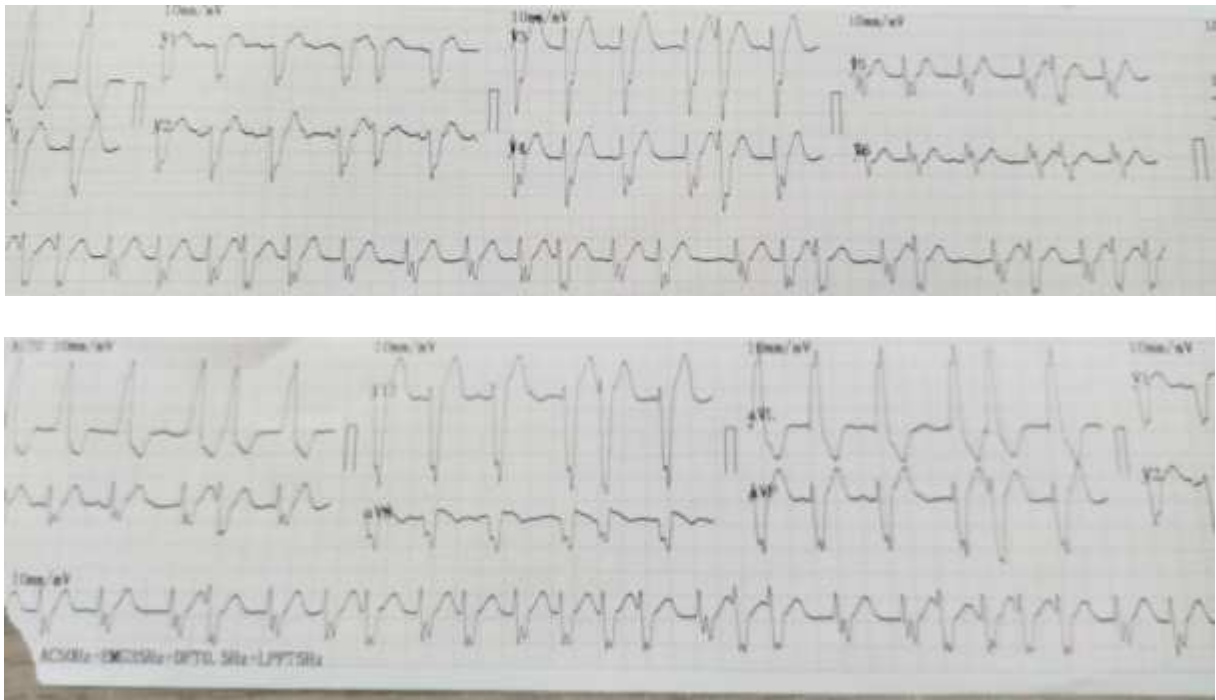
■ TSH

■ TP/INR

■ Ionogramme

■ Troponines

 Avis cardiologie en urgence



● Patiente 29ans aux ATCD de CMH non obstructive sous Neocardil 40mg (1/2cp) avec grossesse actuelle évolutive de 20SA, qui se présente pour une douleur thoracique type d'oppression irradiante vers la mâchoire et le bras gauche

Ta: 08/06, FC: 180bpm

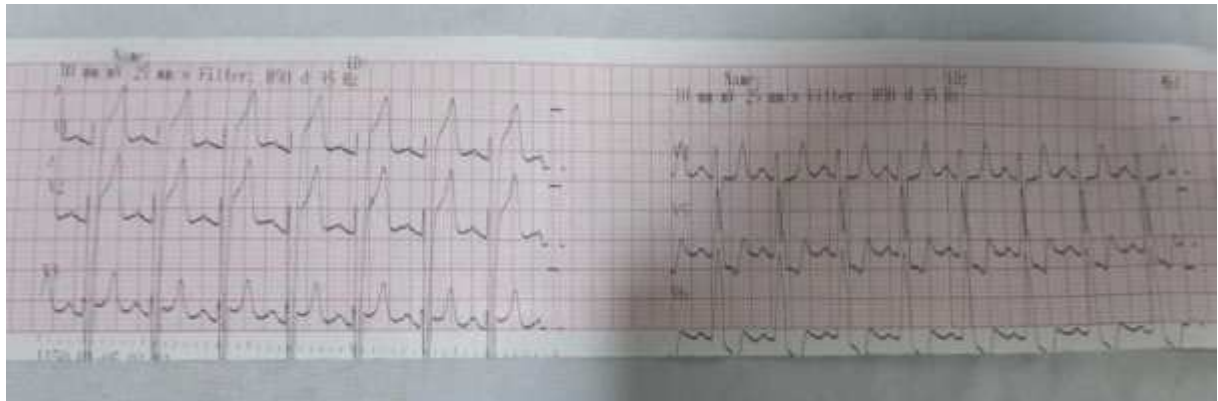
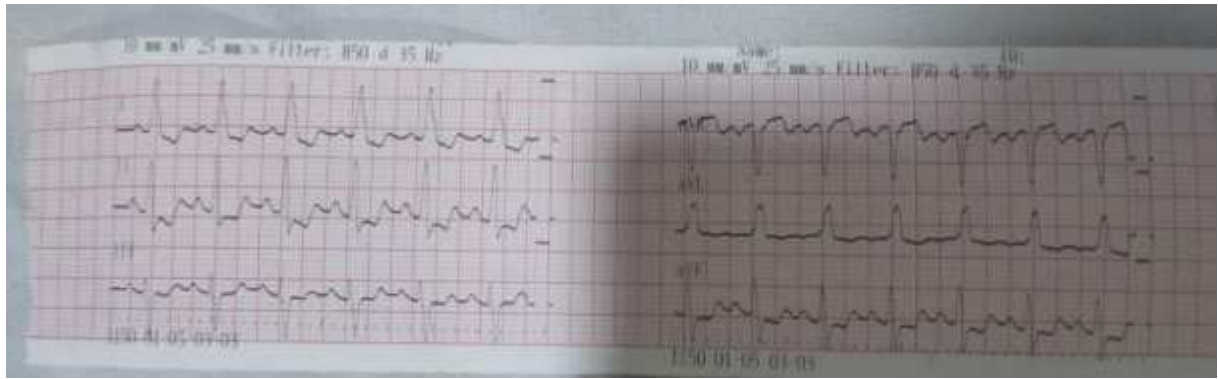
⚠ Interprétation: **BBG + ACFA**

- Rythme irrégulier
- Aspect rS en V1 et RSR' en V6: BBG

- Sous décalage de ST en V1
- Comparer avec un ECG ancien
- Selon la clinique Ta: 8/6=> ACFA mal tolérée

☞ Avis cardiologie en urgence après stabilisation de la patiente :

- Manœuvre modifiée de Valsalva
- Massage carotidien



● Patiente de 90ans, Sans ATCD particuliers, qui se présente pour fatigue, sensation de nausées avec 1 épisode de vomissement + épigastralgies..

Ta : 12/06, Dextro : 1,3g/l

Auscultation propre, Abdomen souple

⚠ Interprétation : **BBG**

- Sus décalage de ST en V1V2 AVR
- Image en miroir en DI DII

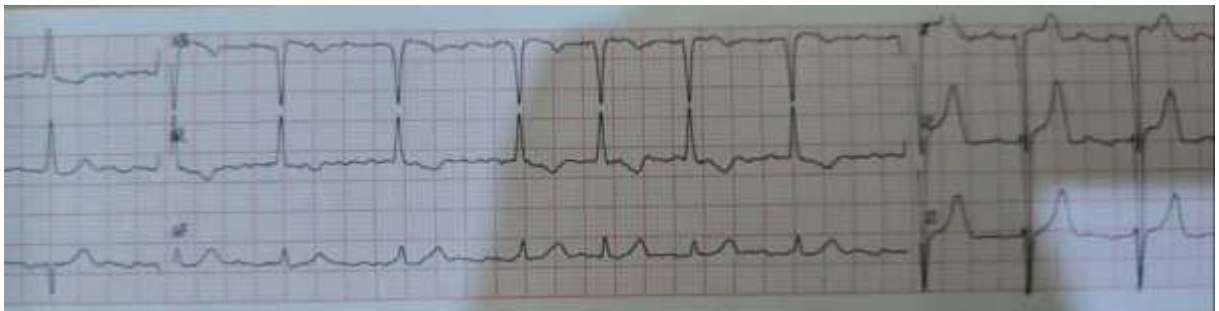
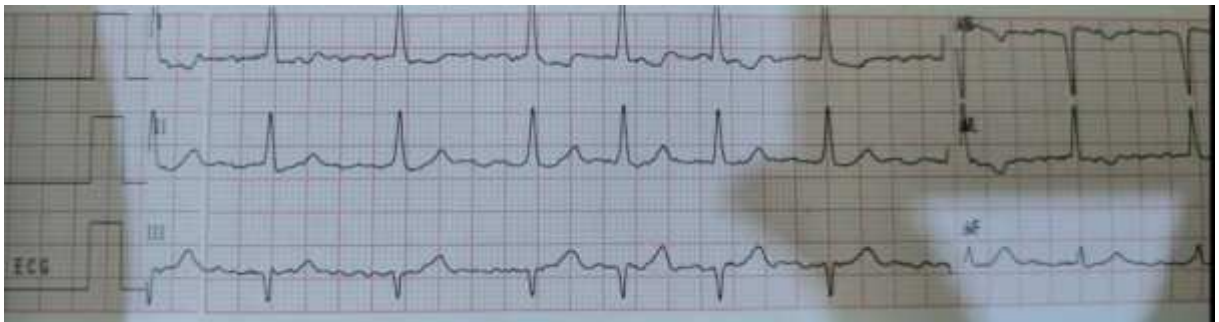
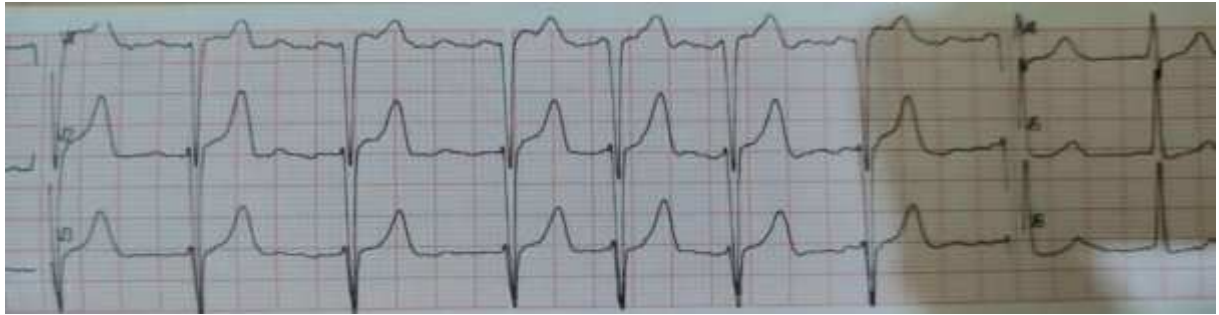
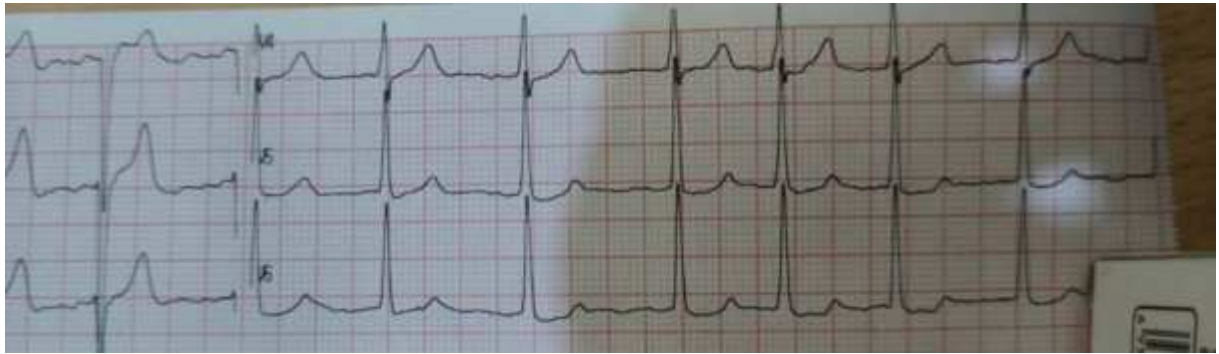
- Bilan 
- TP/TCK
- Ionogramme
- Troponines

☐ 1 Aspegic 300mg en IVD

☐ 2 Plavix 1cp 75mg en per Os

☐ 3 Lovenox 0.4Ui en Sc

☐ → Evacuation cardiologie

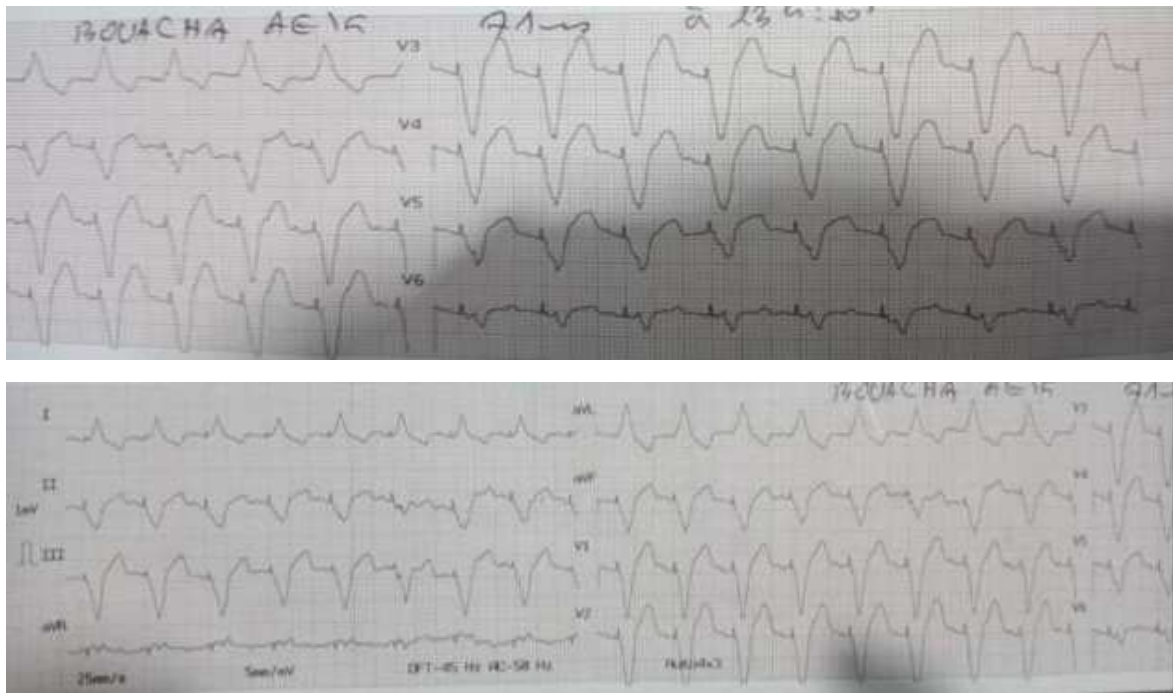


● Patient de 84ans au ATCD de HTA,
rétrécissement aortique, BPCO, IR (clairance à
30), Insuffisance surrénalienne

Motif: Perte de connaissance (légère), nausée,
apyrétique

Ta: 130/80 mmgh, Dextro 1.25g/l

⚠ Interprétation: **ACFA**



● Homme de 70ans, hypertendu, diabétique, néphropathe au stade d'hémodialyse, cardiopathe, qui présente des douleurs thoraciques.

⚠ Interprétation : **BBG complet**

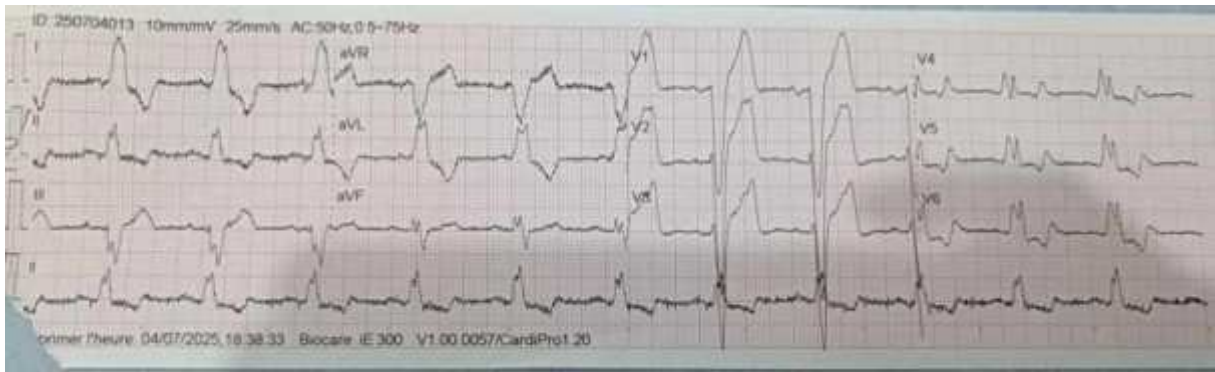
Onde P présente, QRS large à cause du BBG

+ Rabotage de l'onde R : soit une séquelle d'une STEMI antérieur car il est cardiopathe, soit une STEMI courante

Tachycardie 150/min

- Troponines

- Ionogramme



● Patient de 86ans, hypertendu
consulte pour une douleur thoracique

⚠ Interprétation: **STEMI [IDM]** antérieur en
V1V2V3

BBG complet (IDM jusqu'à preuve du contraire)

Aspect en M en latéral gauche V5V6

- Si BBG récent= STEMI
- Si BBG ancien=> On utilise les critères SGARBOSSA
- si (+)=> (majoration de la discordance)=STEMI
- ✓ CAT: Hospitalisation

- Monitoring / O2 thérapie

- Perfalgan en perfusion

- Bilan complet:

- FNS/Gly

- TP/TCK

- INR

- Rénal

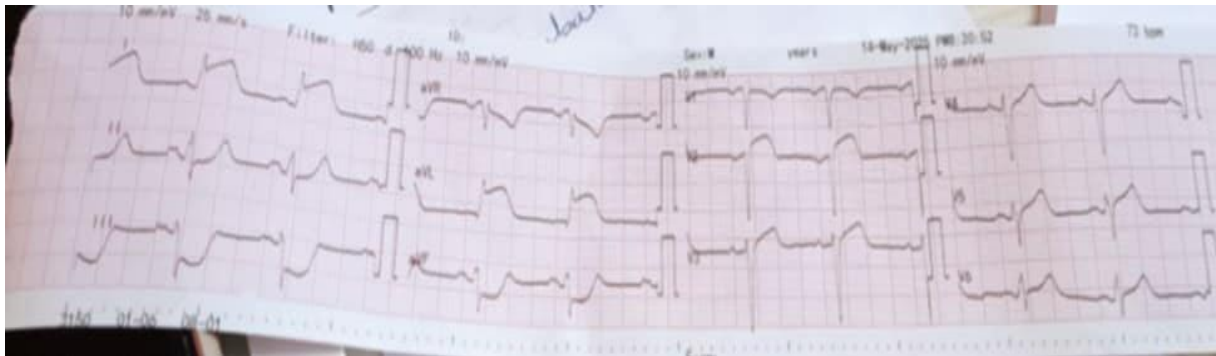
- Ionogramme

- Troponines

- Dose de charge:

- Plavix + Aspegic + Lovenox

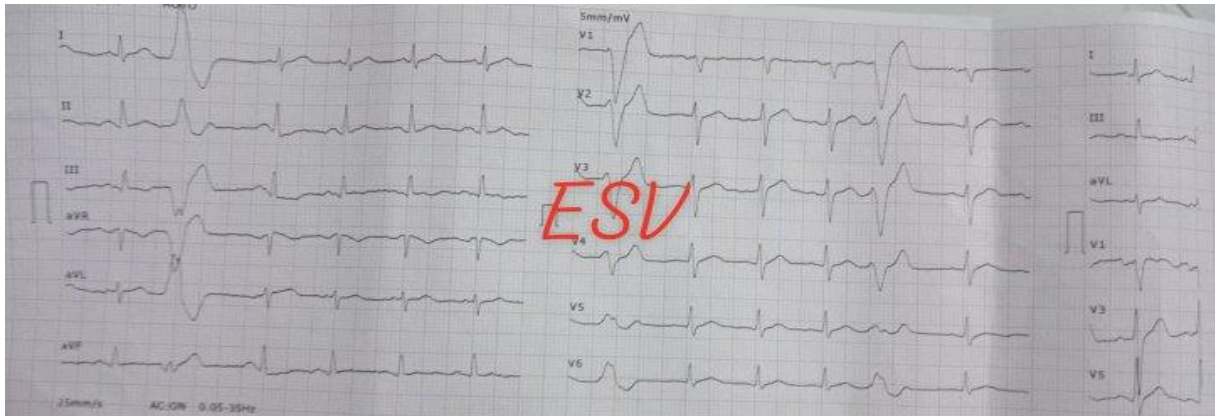
- Evacuation cardiologie



● Patiente de 50ans hypertendue diabétique
Consulte pour une douleur épigastrique +
vomissements

⚠ Interprétation : **Sus décalage en latéral**

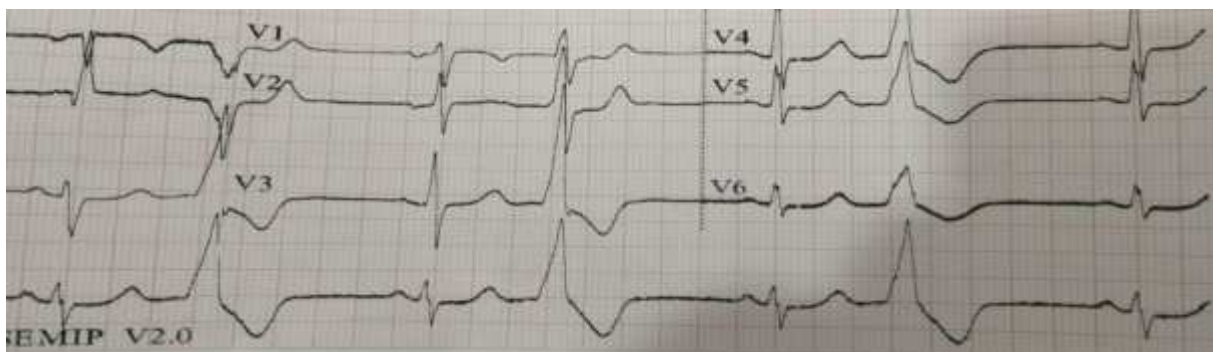
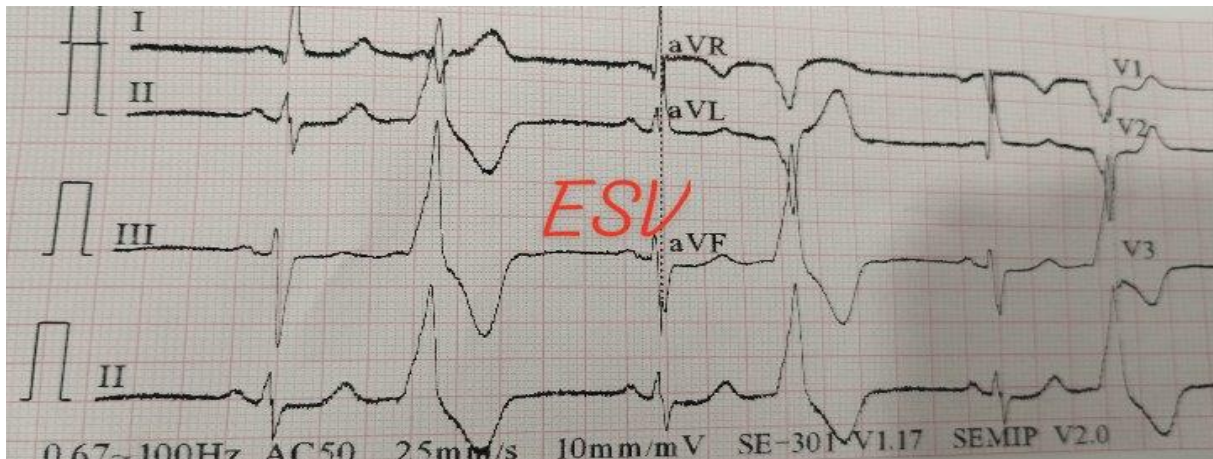
Image en miroir en inférieur



● Un homme âgé de 40ans, diabétique, qui se présente pour des épigastralgies depuis hier

⚠ Interprétation: **ESV**

- Extrasystoles ventriculaire: dans ce contexte considérer un SCA à présentation atypique jsq'à preuve du contraire
- Refaire ECG après 20min
- Bilan d'urgence
- Troponines
- Ionogramme: Hypokaliémie

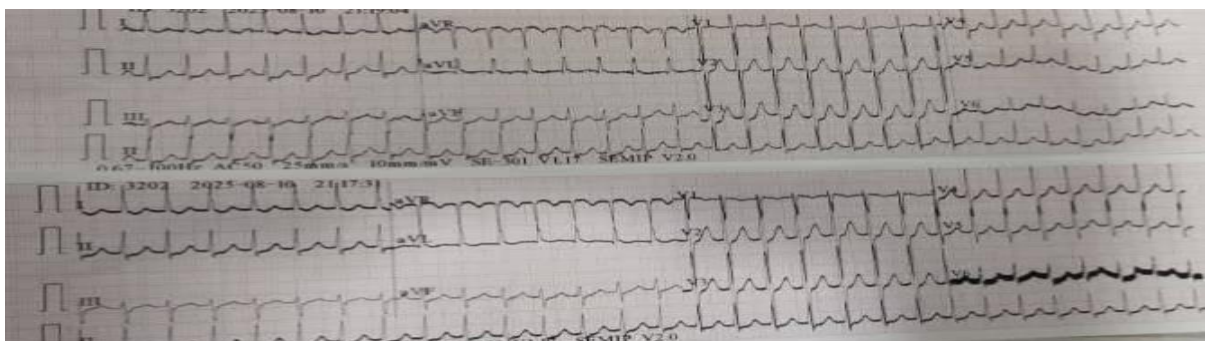
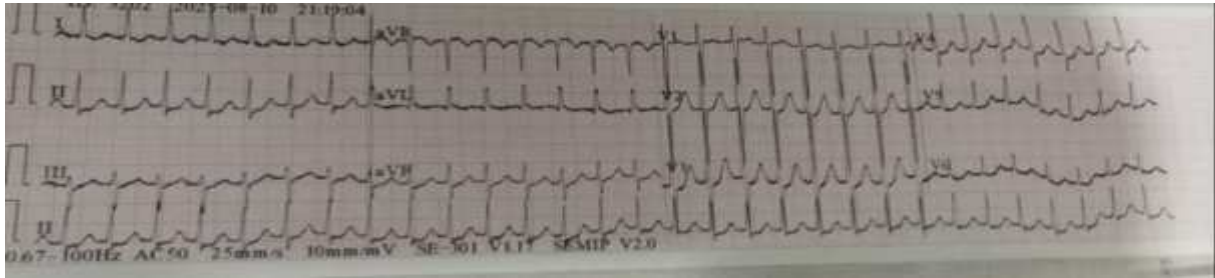
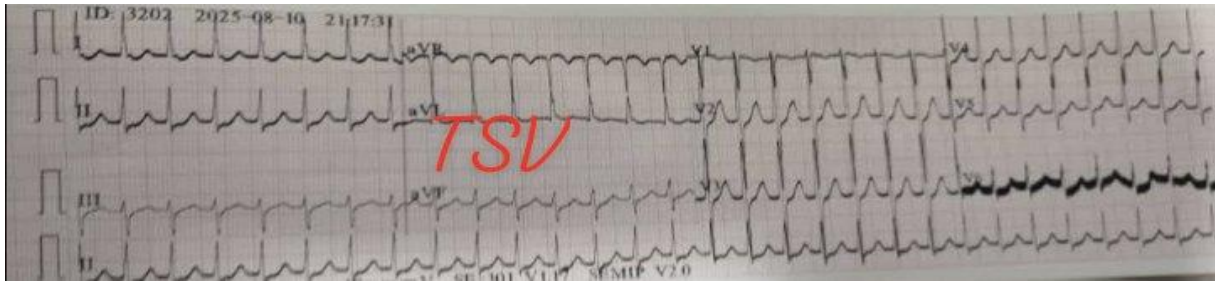


● Patient de 70ans, aux ATCD de trouble de rythme (non documenté), consulte pour des précordialgies

Ta : 14/09 Dextro : 1.51

⚠ Interprétation : **ESV**

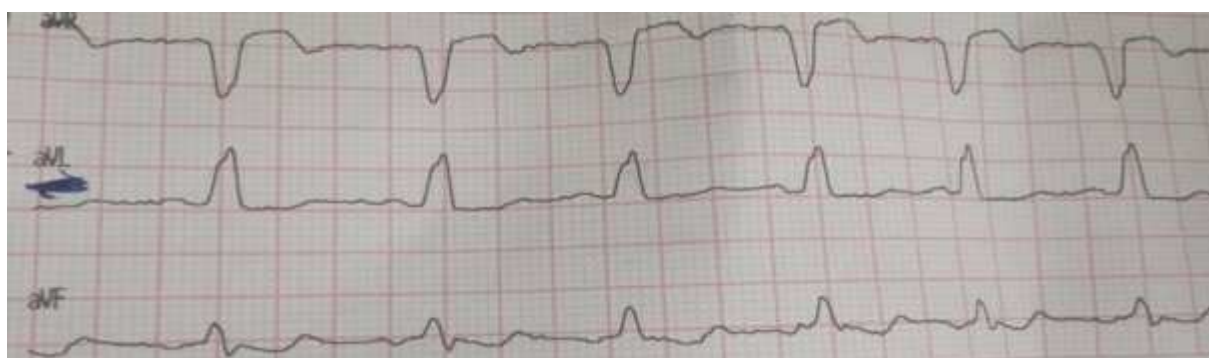
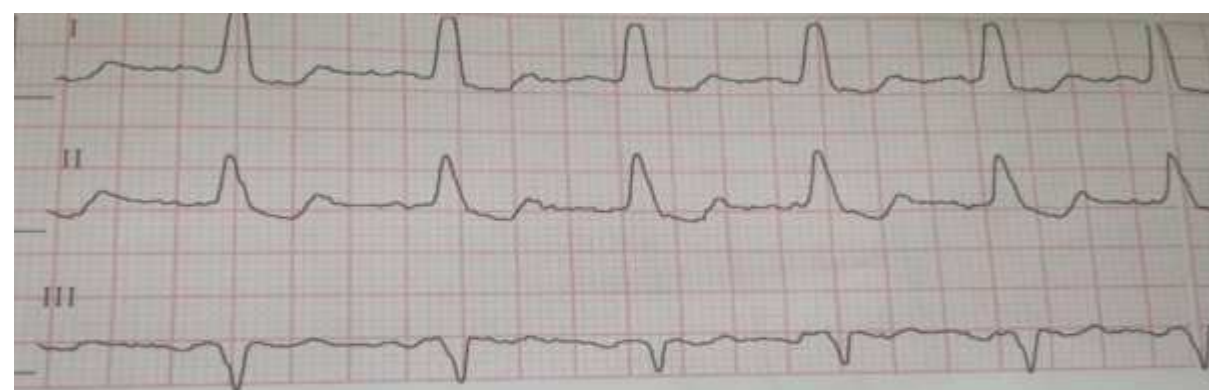
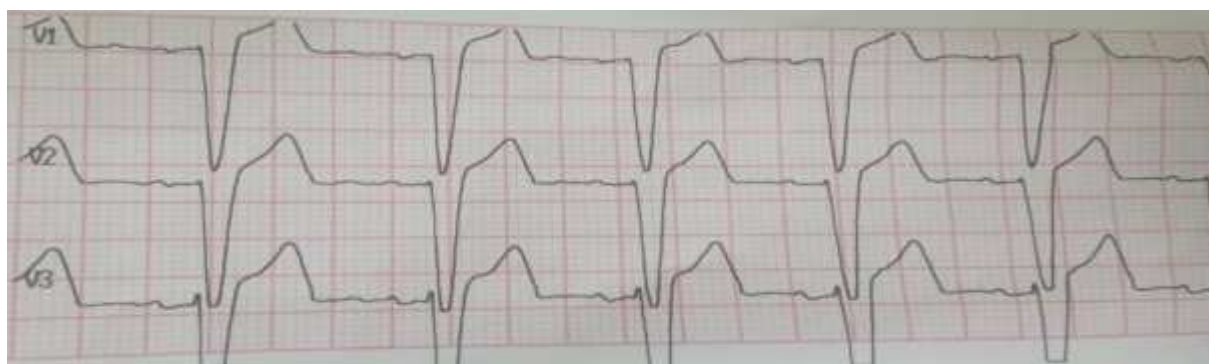
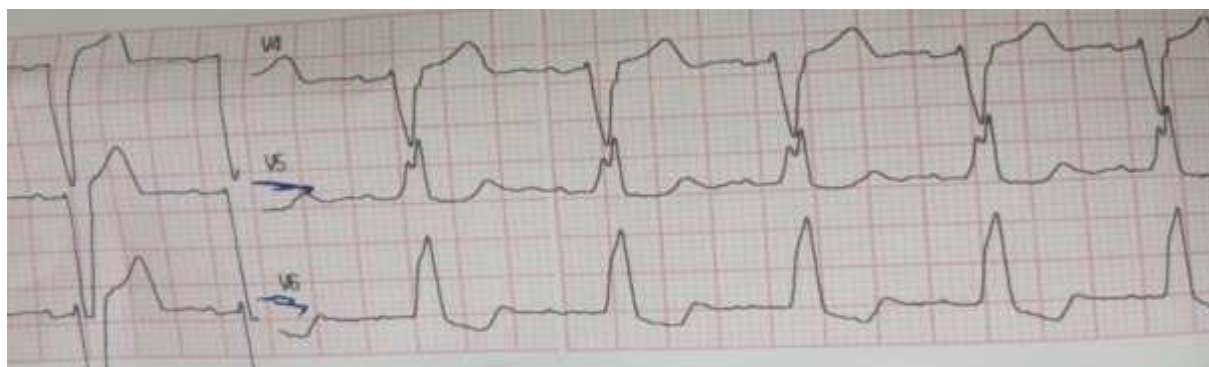
- Refaire ECG
- Antalgique
- Ionogramme + Calcémie



● Patient aux ATCD d'Hyperthyroïdie sous traitement, consulte pour des palpitations

⚠ Interprétation: **TSV**

- Manœuvres vagues
- Mg 1amp dans 250cc de SSI



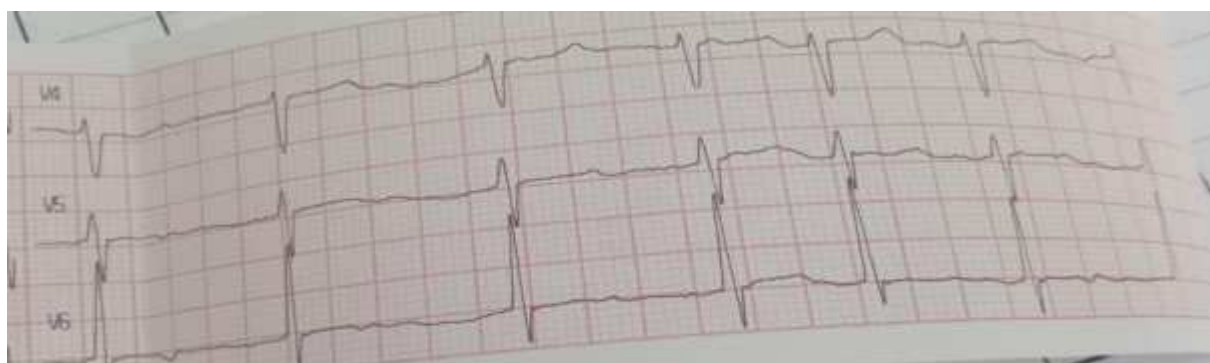
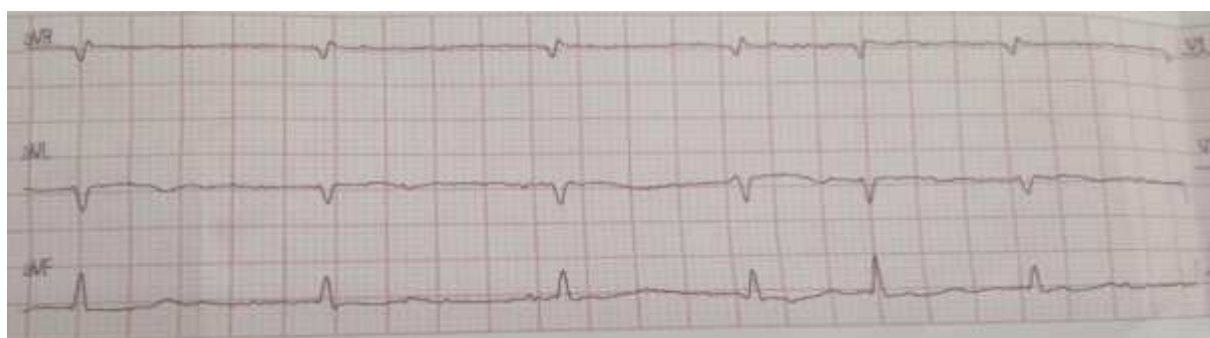
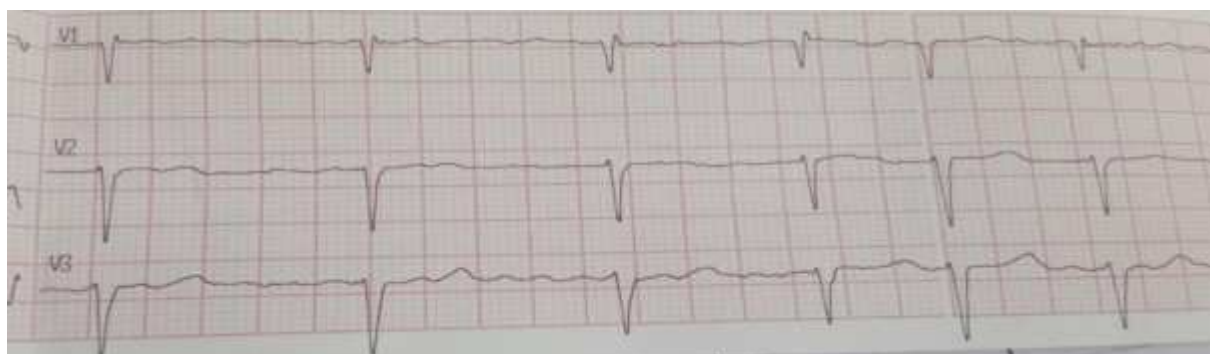
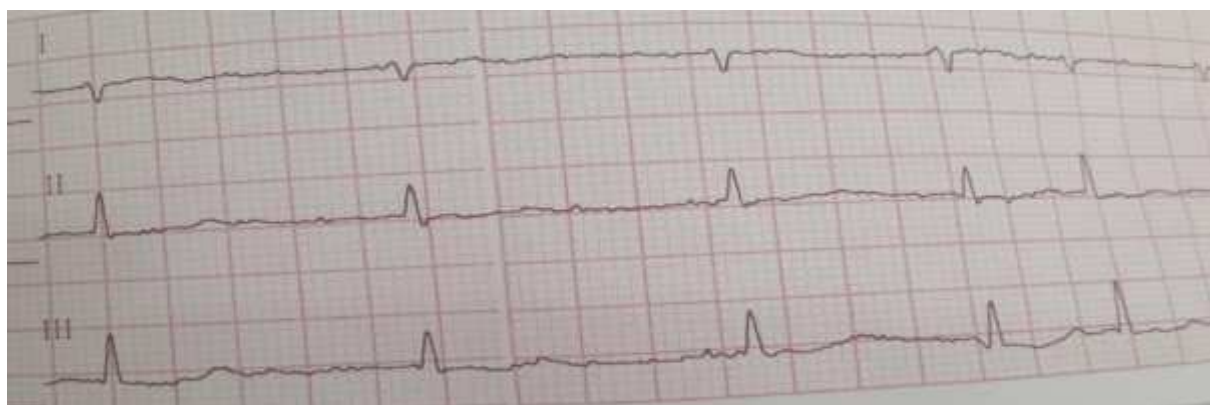
● Patiente de 73ans, d'ATCD d'HTA sous traitement

Il se présente pour des douleurs au niveau du bras droit depuis une semaine.

⚠ Interprétation: **BBG**

- Comparer avec un ECG ancien
- Si nouveau aspect ou douleur typique
- Dosage des troponines

→ Evacuation



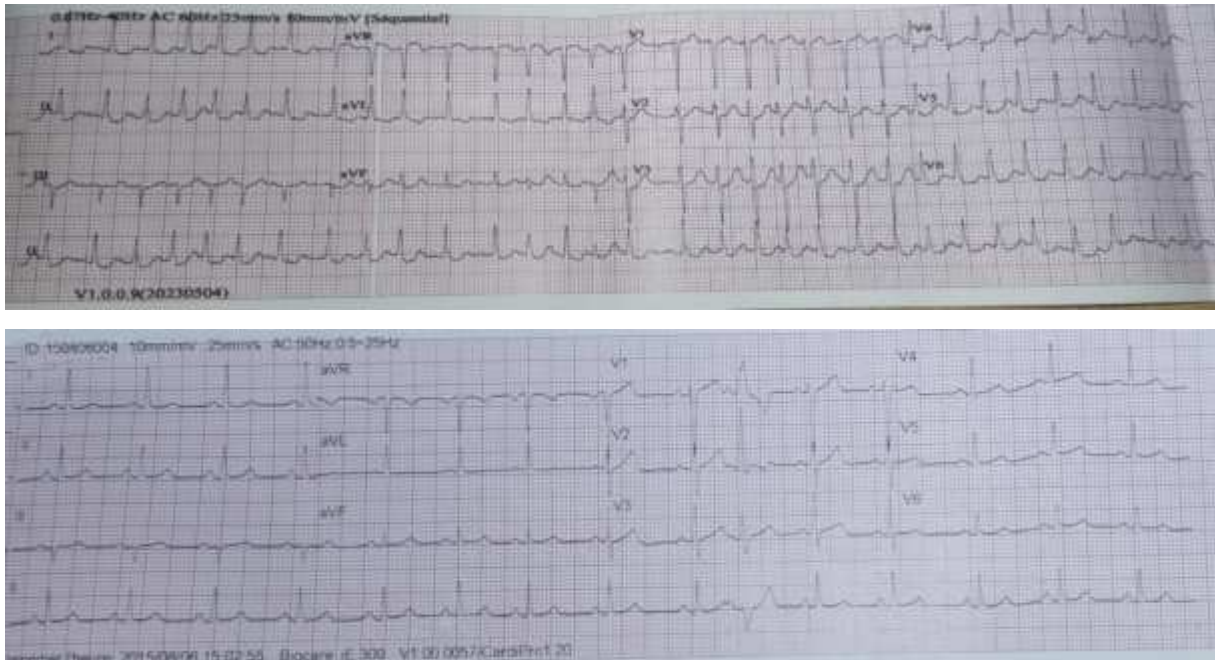
● Patient de 89ans, sous Sintrom

Consulte pour dyspnée de repos

Fc : 80 Ta : 150/90

⚠ Interprétation : **Fibrillation Atriale FA**

- Un rythme irrégulier et très ralenti
- Absence de l'onde P



● Femme 55ans sans ATCD

Précordialgies depuis 4h à l'arrivée

Ta: 8/5 Dextro: 1.55

Troponine négative

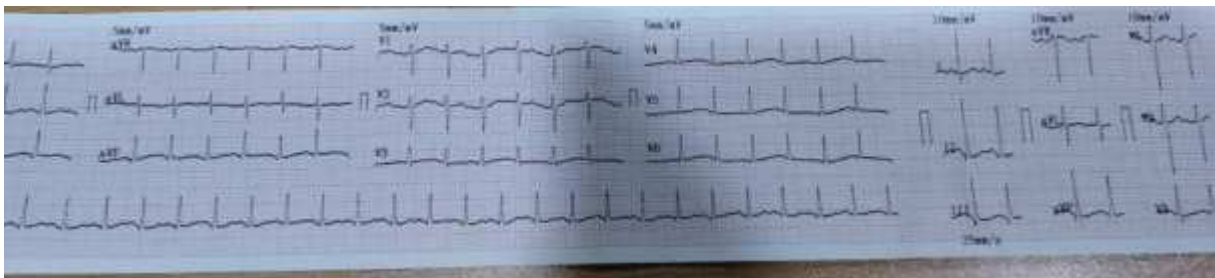
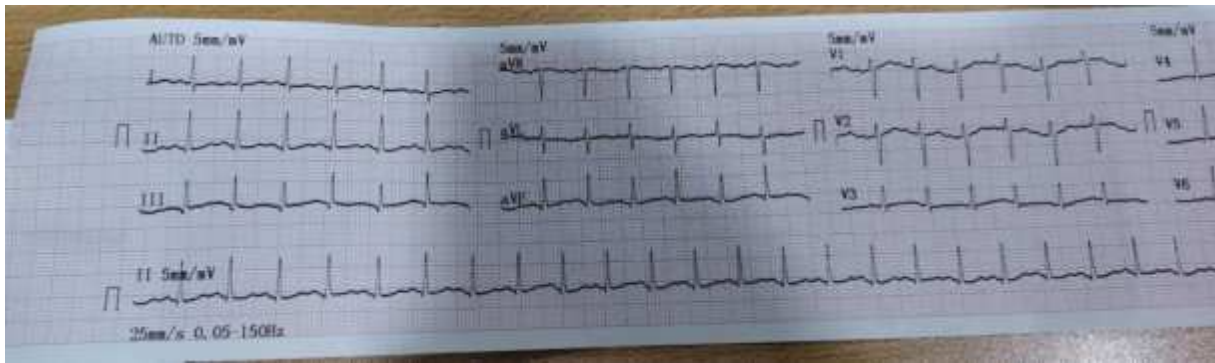
⚠ Interprétation: **TSV mal tolérée**

- Digoxine 1/2amp à 2 reprises
- Cordarone 2cp 200mg
- Mg 1amp dans 250 SSI9

- Bon état clinique
- Disparition de la douleur, respiration calme
- Lourdeur de membre supérieur droit mais sans paralysie ni autres signes d'AVC

■ ECG: **ESV**

Fc: 88/99



● Patiente de 30ans, consulte pour des douleurs rétrosternales avec irradiation vers le membre supérieur gauche et des fourmillements de mâchoire

Ta: 16/10

⚠ Interprétation: **Aspect S1Q3** + Tachycardie sinusale 150btt

- Dosage DDIMÈRES

- Angioscanner

